



王方凌 编著
广东旅游出版社
家庭医疗保健系列

精神病

治疗与护理

精神病(神经病),症状轻者常表现痴痴呆呆,喜怒无因,时哭时笑;重者会攻击别人甚至自伤身体,做出一些有乖常理的行为,使人望而生畏。

本书介绍了各类精神病的成因、防治和护理常识。同时结合其病因、病理,阐述了人遭遇到压迫、打击或灾难时,应怎样面对现实,避免过度刺激,防止精神紊乱而成病。

本书是一本很好的精神保健读物,也是病患者家属必备的参考书。



序

精神病是一种情绪上的紊乱，在心理上造成对真象发生错觉，致使行为乖于常理、甚至癫狂的一种疾病。

其发病原因相当复杂，许多人可能由于幼时便已经埋下不健全的心理因素；或由于身体上的某种疾病（如梅毒性脑损伤等）；或由于社会生活上导致的沉重压力，使情绪不稳定而产生不安全感……

（本书就各类型的精神病，如抑郁症、精神分裂症、周期性精神病、歇斯底里、痴呆症等等，分别阐述其性质、病因、临床表现、治疗方法和护理常识。）

如果说疾病侵犯人是无可奈何的事，那么治愈疾病却是患者及其家属积极以求的心愿。所以本书在治疗方面的介绍更是不吝笔墨，同时结合精神医学、心理学阐述了一旦遭受压迫、打击或灾难时，应如何面对现实，自我减压，保持精神舒畅。

本书还讨论了人格障碍、精神变态、性变态等种种精神问题。这些，也是精神病态的另一种表现，所以，多掌握些这方面的知识，对于每一个人的身心健康助益良深。

本书内容丰富，简明实用，不仅患者及其家属必备必读，也是研究人类行为极具价值的参考书。

目 录

精神病治疗与护理

序

第一章 精神病概述

- (2) 何谓精神病
- (4) “精神医学”反对论
- (5) “反对论”的兴起与失败
- (7) 历史上对精神病的愚昧认识
- (7) 精神病患者的悲剧
- (9) 奇奇怪怪的精神病人

第二章 酿成精神病的几种因素

- (16) 急性子
- (19) 焦虑
- (22) 内疚
- (25) 妄想

第三章 精神病的遗传问题

目 录

家庭医疗保健系列⑭

- (30) 体质遗传的比率问题
- (31) 智能障碍的遗传问题
- (32) 精神分裂症的遗传问题
- (34) 躁郁症的遗传问题

第四章 形形色色的神经质

- (36) 何谓神经质
 - (36) 完美癖
 - (38) 虑病症
 - (39) 人格自卑
- (41) 超神经质的症状表现

第五章 神经官能症

- (44) 何谓神经官能症
- (45) 神经衰弱
- (53) 癔病

目 录

精神病治疗与护理

(62) 病例介绍:

(62) 她突然感到全身麻木

(63) 她要跟父亲一起睡

(64) 她的过去、现在、将来

(66) 强迫症

(71) 病例介绍:

(71) 与夫人床上床下皆不和

(72) 准备离她睡猪栏

第六章 智力障碍症

(76) 病因、临床、诊断、治疗

(80) 预防常识

第七章 痴呆症

(84) 何谓痴呆症

(86) 老年性痴呆症

目 录

家庭医疗保健系列⑭

(92) 动脉硬化性痴呆症

第八章 忧郁性精神病

(96) 躁狂忧郁症

(110) 病例介绍:

(110) 女钢琴家跳楼自杀

(111) 更年期忧郁症

(114) 病例介绍:

(114) 患妇狂饮醉濒死

第九章 精神分裂症

(118) 何谓精神分裂症

(120) 精神分裂症临床类型

(121) 病因、临床、诊断、治疗

(145) 病例介绍:

(145) 感觉有人要害他

目 录

精神病治疗与护理

第十章 周期性精神病

(148) 病因、临床、诊断、治疗

第十一章 癲病症

(154) 病因、临床、诊断

(159) 治疗

第十二章 症状性精神病

(175) 感染性精神病

(179) 内脏器官疾病引起的精神病

(183) 尿毒症时的精神障碍

(184) 产后垂体功能低下症引起的精神障碍

(185) 系统性红斑狼疮引起的精神障碍

(186) 中毒性精神病

(187) 一氧化碳中毒性精神病

(190) 阿托品类生物碱中毒性精神病

目 录

家庭医疗保健系列⑬

(192) 药物治疗过程中出现的精神障碍

第十三章 性变态

(196) 性变态与精神病

(198) 同性恋

(201) 窥淫癖

(203) 恋童癖

(204) 恋物癖

(205) 露阴癖

(206) 易装癖

(208) 施虐狂与受虐狂

(209) 性变态的治疗

“精神医学”反对论

早在 20 世纪 60 年代初，一种反精神医学的理论出现并付之行动，在欧美各国纷纷造成声势。反精神医学者其现由之一是说“狂气”或“狂”是可以被容许存在的一种人类的形态，而非一种疾患，因此这种人应该是被开放的。主张之二是说精神科医师借着神话般的“精神疾患”之名，打着“治疗”的旗帜而剥夺了“狂”者的自由，并且以美其名为“精神医院”的强制收容所把他们监禁、隔离起来。主张之三是说精神科医师是社会体制（指资本主义）的走狗，他们想要使“狂”者服从这个体制，因此以各种的手段如洗脑、戴着假面具的暴力作为治疗的方法，而且以为了社会体制的安全为理由来欺瞒及压制这些人。主张之四是说精神医院内缺点重重，治疗者无视于人权，以权威的手段来对付病人，令病人长期住院，有若饲养牲畜一般。主张之五是说精神分裂病的病因至今未明，不能当它是种疾病，然而一般人都以为他们是逸脱于社会体制之外者而将他们加以隔离，并且发明了名为“精神医院”的人工产物来对他们进行恶劣的治疗，使“狂”者成为这种产物下的牺牲者。

英国有位著名的精神科医师曾经在 1972 年于伦敦举行的世界精神科医学会、精神分裂病研讨会中公然表示“大家都说精神分裂症是如谜般的疾病，但实际上它

“精神医学”反对论

早在 20 世纪 60 年代初，一种反精神医学的理论出现并付之行动，在欧美各国纷纷造成声势。反精神医学者其现由之一是说“狂气”或“狂”是可以被容许存在的一种人类的形态，而非一种疾患，因此这种人应该是被开放的。主张之二是说精神科医师借着神话般的“精神疾患”之名，打着“治疗”的旗帜而剥夺了“狂”者的自由，并且以美其名为“精神医院”的强制收容所把他们监禁、隔离起来。主张之三是说精神科医师是社会体制（指资本主义）的走狗，他们想要使“狂”者服从这个体制，因此以各种的手段如洗脑、戴着假面具的暴力作为治疗的方法，而且以为了社会体制的安全为理由来欺瞒及压制这些人。主张之四是说精神医院内缺点重重，治疗者无视于人权，以权威的手段来对付病人，令病人长期住院，有若饲养牲畜一般。主张之五是说精神分裂病的病因至今未明，不能当它是种疾病，然而一般人都以为他们是逸脱于社会体制之外者而将他们加以隔离，并且发明了名为“精神医院”的人工产物来对他们进行恶劣的治疗，使“狂”者成为这种产物下的牺牲者。

英国有位著名的精神科医师曾经在 1972 年于伦敦举行的世界精神科医学会、精神分裂病研讨会中公然表示“大家都说精神分裂症是如谜般的疾病，但实际上它

“精神医学”反对论

早在 20 世纪 60 年代初，一种反精神医学的理论出现并付之行动，在欧美各国纷纷造成声势。反精神医学者其现由之一是说“狂气”或“狂”是可以被容许存在的一种人类的形态，而非一种疾患，因此这种人应该是被开放的。主张之二是说精神科医师借着神话般的“精神疾患”之名，打着“治疗”的旗帜而剥夺了“狂”者的自由，并且以美其名为“精神医院”的强制收容所把他们监禁、隔离起来。主张之三是说精神科医师是社会体制（指资本主义）的走狗，他们想要使“狂”者服从这个体制，因此以各种的手段如洗脑、戴着假面具的暴力作为治疗的方法，而且以为了社会体制的安全为理由来欺瞒及压制这些人。主张之四是说精神医院内缺点重重，治疗者无视于人权，以权威的手段来对付病人，令病人长期住院，有若饲养牲畜一般。主张之五是说精神分裂病的病因至今未明，不能当它是种疾病，然而一般人都以为他们是逸脱于社会体制之外者而将他们加以隔离，并且发明了名为“精神医院”的人工产物来对他们进行恶劣的治疗，使“狂”者成为这种产物下的牺牲者。

英国有位著名的精神科医师曾经在 1972 年于伦敦举行的世界精神科医学会、精神分裂病研讨会中公然表示“大家都说精神分裂症是如谜般的疾病，但实际上它

是根本不存在的东西，而大家为了这种从来不曾存在的
东西花费了那么多的时间与金钱实在是种浪费。”美国有
一位著名的反精神医学者说过“精神疾患是精神科医师
创造出来的神话”，主张“必须把社会中这些被牺牲者
身上所挂的标志除掉”。

“反对论”的兴起与失败

反精神医学的运动最早应该说是起源于英国，当时
有位著名的精神科医师被称为反精神医学的“鼻祖”。
他曾经表示人的“狂”就是精神上的一种“超越”，而
这些狂者就是在企图“超越”之途中的旅人，精神科医
师企图对这种“超越”加以控制，在早先是用精神医院
来把他们监禁起来，现在则是以被称为“精神药物”的
工具在“狂”者的心中置放了病床与门钱。他出版了一
本书，书名叫作《被撕裂的自己》。这本书虽然受到一
小部分人的欢迎，然而大部分的精神医师在看过这本书
之后根本无法了解这位医师到底想说些什么。

反精神医学这一派的人为了实践他们的主张，于是
在1965年时在伦敦创办了一所“金斯列馆”。他们不
称之为医院而称它是“住所”，其中可以容纳14个人
居住，并且有绘画、瑜珈等一连串的活动计划。在馆
中，工作人员与所谓的“病人”彼此间毫无分别地共同
生活在一起，而且丝毫没有某人要对某人施予治疗的这
种关系存在。这个实际性计划执行后的结果并没有被正

式公布出来，但是有一位曾经在里面待过的医师终于吐露了实情，即在“金斯列馆”中每个人都可以我行我素，不受到任何人的控制。因此有人纵情喝酒；有人随便拿别人的东西；有人把秽物涂在墙上或弄到厨房里而使得整个室内臭气熏天；有人半夜里做恶梦惊醒而不断打门；有人持着自己“在火焰中”的幻想而经常在室内点火、烧毁家具，最后这个馆终于被关闭了，不过没有人知道它究竟是在什么时候被关掉的。

另外有位和这医师唱同调的名叫克巴的人在伦敦市郊外一所拥有 2000 张床的公立医院中尝试使用反精神医学的实践治疗法，结果在 4 年之后这个企图也宣告失败了。克巴其人乃是首倡“反精神医学”的人，他主张精神分裂症是尚未经医学证实为疾病的一种状况，缺乏客观的证据来证实它，但是因为它是一种非常难以了解的现象，所以造成大家害怕它的心理，再加上使用精神分裂症这种名称来称呼它，于是形成了一种社会危机。他这种主张大致上还是跟其他的反精神医学者站在同一条路线上，而这些在 20 世纪 60 年代中突然崛起的反精神医学者在不久之后即告消声匿迹，不过从批判反精神医学的立场上而言，所谓的“反精神医学”可以有多方面的含义，其间的内容虽然有别，然而由古至今所谓的“反精神医学”的现象正犹如下面所述是可以有许多种模式而本质如一的。

历史上对精神病的愚昧认识

自古以来，人们对于精神病的认识是相当愚昧可笑的，头脑中大都存在着“狂”并不是精神疾病的观念，而是恶魔所致的，在有些地区人们相信那是狐狸在作祟，有些地方的人认为是神鬼在作祟，所以在对精神病的治疗上，便赖之于祭狐、拜神、祈鬼等迷信活动，给病人造成悲剧。14到18世纪的欧洲，在宗教力量长时期的控制之下，狂人被认为是与撒旦结伙来对抗基督教的，因此指控这些人是反基督教人士而把他们交付宗教审判。据说在这一段时期内遭受迫害被火焚死的有数百万人之多，在历史上把这种残酷无比的狂暴行为称作是“魔女打猎”而记载下来。虽然他们的行为方式和现代的反精神医学者有所不同，然而这种不承认精神疾病的态度在本质上实际是和现代反精神医学的主张不谋而合的。

精神病患者的悲剧

到了18世纪下半叶的欧洲，“狂”开始被认为是一种精神疾病，这期间最引人注目的就是法国的毕乃尔医师在1793年时把收容所中精神病患者的手铐脚链解开的创举，很快地影响到整个欧洲社会，于是开始了对精神病患者的道德治疗。然而这种依道他标准来指导病

人的风气到了 19 世纪时又趋于式微，反而是企图使用各种的身体治疗法与过分属于观念上、想像上的治疗方法的人增多起来。所谓的观念上的治疗方法指的是企图以惊吓的方法来惊醒病人等的方法。譬如说让病人走过一座架在池塘上的桥而在桥上设下陷阱让病人跌入水，希望藉这种惊吓的作用来达到唤醒病人的目的；或是出其不意地用冷水泼在病人头上、身上，希望他就此清醒过来。到了 1930 年时已发明了好几种的休克治疗法，这些休克治疗确实在不少病人身上能够奏效，但是这种治疗的本身却受到了病人相当强烈的抵制，产生恐惧的反应，而这一类的精神科治疗方法长久以来一直迟迟未能有多大的进步。

在这种情况下，另一种反精神医学的情况出现了，这就是德国纳粹党对精神病人的迫害行动。在希特勒领导下的一群民族纯血统主义的狂热信徒疯狂地杀戮了无数的犹太人，而精神疾病患者也被列入他们要加以铲除的对象之中，无数的病人被拘捕而葬身于瓦斯室、焚化炉及各种密室里而，因此死亡的确实人数不详，但估计不在 5 万人之下。根据当时文件的记载，希特勒主持下的纳粹党曾经允许过在医院里对病人施行安乐死，用意在于杜绝社会经济上的浪费。纳粹党所以如此对待精神病人的一个主要理由，就是在于德国精神医学派所主张的精神疾病体质基因理论，显然这种精神医学上的理论为政治所利用了。在一片纳粹党迫害精神病患者的声音中，有不少的德国精神医学者因为不堪忍受这种

状况而流亡到同盟国的阵营中。

以上所说的各种反精神医学的问题可说是形形色色，而且和精神医学的发展息息相关，要想窥其全貌诚属不易，而就精神医学史看来，20世纪60年代列因等人所提倡的反精神医学并不一定就是新奇的事，因为精神医学在理论上与实务工作上已经历经了一段相当令人困扰的路程，而造成这种情况的原因一方面是因为精神疾病的真正病因一直无法被完全得知，另一方面是因为病人本身对病缺乏自识而使得病程慢性化起来了。精神医学虽然面临了像反精神医学等主张的挑战，但是在客观的立场上面言，精神医学一向都是在“医科学”之内，只要病人确实存在，精神医学也会继续存在下去的，毕竟在超越之途中的人与“狂”者所表现出来的人格分裂两者之间在本质上是全然不同的。

奇奇怪怪的精神病人

人的精神障碍是由多种多样的原因引起的，有许许多多令人不易了解的内容，因为人的精神构造原是十分复杂的，思想和遭遇又各不相同，所以也就出现了千奇百怪的临床现象。症状严重的，常施暴力打人自打，杀人自杀，赤身裸体，抓男掳女，哭笑无常，喜怒无因；症状较轻者，成天痴痴呆呆，傻兮兮，举止荒唐。

曾经有一位25岁患有精神病的小姐，外貌美丽、活泼动人，她对于自己与男人乱交的行为，心里开始越

来越担心；对于自己无法拒绝男人而感到罪恶与不洁。但在她清醒的时候，又老是想到性方面的事情。结果病情越来越严重，最后发展到自己脱光身上的衣服，见到男人就追。

又有一位男性病人，在住进精神科病房之后，一直保持极端的缄默，脸上神情木然，任凭别人一再问他有什么地方不舒服，他都只是低头默默不语。由于病人的家庭要求让病人独处，安静地接受治疗，因此病人被安排在单人的病房里。一住进病房后，病人随即躲到床上，盖紧被子，一动也不动，护士只好每餐来喂他吃饭，所幸病人还能慢吞吞地吃下一些东西。

住院好几天，病人始终维持一成不变的卧床状态，即使医师前往诊视，也丝毫不加理会。

有一天早上，当护士用推车把牛奶送到病人房内时不慎滑落了一瓶，玻璃碎片撒了一地。护士深知精神科病房中不容许置留任何有可能危害到病人的东西，因此马上找工友来清扫玻璃碎片，而在这段时间里病人仍然躺在床上，丝毫无动于衷。

过了一阵子，病房护士在做定时的病房巡视时，向前去问候他并且劝他起床，但是病人仍然来个不理。到了中午，护士发现病人面色苍白，似有异样，于是拉开棉被，赫然发现病人已经拿玻璃片割破了腹部，并且正大量出血。虽然病人马上被送到急救室接受紧急治疗，但仍然回天乏术。

也有一位症状表现较前述病例轻微的年轻病人，他

曾经患过肺结核，因此长久以来对于污秽的东西都特别小心。到了最近他开始出现一些强迫性精神官能症状。

譬如他非常害怕办公室的空气中充满了细菌，因此虽然是在大冬天里他仍然坚持要打开窗子流通空气，使得同事们因此而着凉；在应酬的场合中因为觉得别人的筷子不干净，所以每上一道菜的时候他都是抢先把菜挟到自己的小盘子上，以免感染到别人筷子上的细菌。他对于自己的健康几乎毫无自信，以为过去的肺结核病使得他的身子变得极端虚弱。渐渐地他出现了怕冷的症状，于是乎他每天都随身带了一个小皮箱，里面装了许多衣服，随时根据气温的高低变化来增减衣服，最高纪录时曾经穿了7件衣服。由于他当时尚未结婚，所以也没有任何一个人知道他有这种毛病，旁人只是觉得他有点怪癖，不太合群，一板一眼的十分严肃，总是随身带个小箱子，好像总在忙些什么事似的。这位病人如果不是特别担心自己的健康问题而来就服的话，恐怕他还不能算是个病人，也不能算是个很不健康的人，因为他对于自己的工作仍然是能胜任愉快的。

还有位女病人总觉得自己的手沾满了肮脏东西，成天不断地洗手，隔一会儿没洗手心就忐忑不安，最高记录一天洗三十多次手。同样，她也觉得人家的手肮脏，要是谁的手动到她身上的衣服，她就要立即换掉，最高记录有一天换五次衣服的。

更为奇怪的是：她在自己出门之前，门窗明明已经锁好，但总不放心，走了老远还要再回来看看，常常出

一趟门要来回十多次。

爱清洁，小心门户的习性，如果善加发挥，会成为很好的优点，但这位女人正因为过分、反常而成为病——成为一种“强迫性精神官能症”。

精神病临床，碰到的现象真可谓无奇不有。有个患恐惧症的病人，非常怕待在高楼上，尤其当他住在大饭店的高楼上时，心里更是担心会发生火警。所以当他赴美留学时，首先就是对自己所住的公寓的窗户及太平门做了番详细的观察，同时在自己的床下准备好足够长度的绳子，以便万一发生火警时用以逃生。每当上大饭店楼上，更要带着长绳随行。事实上大饭店发生火警的事，确实是时有所闻，也有许多人因此而丧生火窟，但是一个人如果因此而经常随身带着绳子旅行的话，不用任何检查诊断，一看就知道是一个精神病人。

还有位年老的精神病人时常会听到有人在跟他说话的声音，听到有趣之处就一个人哈哈大笑起来，而旁人却不知道他因何自言自语以及发笑。在他居住的村子里没有一个人觉得这位老人家有什么特别异常之处。看他平日过得悠哉悠哉，早上在路上碰到他时看到他在喃喃自语、吃吃发笑，大家还以为这位老年人是个很乐观的人，恐怕是因为寂寞的关系才这么跟自个儿说起话来，因此大家对他照样打招呼。可是站在医学的立场而言，这位老年人可以说是妄想病人，但是在他置身的周围环境中并没有人认为他是个异常者，而他本人更是不曾自觉到有什么病。像这种情形是相当普遍的，也就是说在

一般人的常识中缺乏把这种状况看作是一种疾病的概念。不过当同样状况的另一位老年人是住在都市中的时候，如果他也是一早起来在街上边走边笑、自言自语，别人都会把他当成是一个老疯子，否则他不会如此地一路走一路傻笑。如果警察看到他，警察也会觉得不对劲，倘若他是在外国使馆区附近晃荡的话，恐怕警察还会叫救护车来把他送到精神医院去。所以病人的病态很可能是由社区一般人的看法或常识的尺度来加以衡量的，以致正常与异常的判断幅度大有差别。



第二章

酿成精神病的几种因素



做事呆板，缺乏弹性

性急的人往往具有完美癖，他根据自己的观点而要求事事完美、整齐、清洁。这种人做事有板有眼，工作能力也许很高，但是因为他要求今日事今日毕，因此相当缺乏弹性而不知变通。假如做妻子的人具有这种癖性，每天必然要花费无数的时间与精力来保持家中的整洁，床单也得天天洗，这真让她的丈夫和子女受不了。有这种完美癖的人大概这辈子是甭想悠悠闲闲地享受一下人生了。

焦虑暴躁，缺乏忍性

性急的人往往心思也太多，什么事都要操心，而不知道分个先后轻重缓急。在他的心中，好像老有什么坏的事情在发生似的，对任何事都是在事先就操了一大堆的心，一切事情也都往坏的方面去想，结果丝毫不能放宽心。有些人只要家人一出门就怕他们会碰到车祸；小孩子出了点小毛病也会让他们紧张兮兮的；假如有人说他的不是，他这辈子都忘不了。

有些性急的人脾气非常暴躁，只要一点小事就会惹他发怒，像这种性子的父母亲对小孩子往往动辄打骂，在家庭教育上造成许多的问题。性急原本是在性格中的冲动性作用之下所造成的，而环境的压力又较大的话，他就会以在家对家人发牢骚来发泄他的冲动。

做事呆板，缺乏弹性

性急的人往往具有完美癖，他根据自己的观点而要求事事完美、整齐、清洁。这种人做事有板有眼，工作能力也许很高，但是因为他要求今日事今日毕，因此相当缺乏弹性而不知变通。假如做妻子的人具有这种癖性，每天必然要花费无数的时间与精力来保持家中的整洁，床单也得天天洗，这真让她的丈夫和子女受不了。有这种完美癖的人大概这辈子是甭想悠悠闲闲地享受一下人生了。

焦虑暴躁，缺乏忍性

性急的人往往心思也太多，什么事都要操心，而不知道分个先后轻重缓急。在他的心中，好像老有什么坏的事情在发生似的，对任何事都是在事先就操了一大堆的心，一切事情也都往坏的方面去想，结果丝毫不能放宽心。有些人只要家人一出门就怕他们会碰到车祸；小孩子出了点小毛病也会让他们紧张兮兮的；假如有人说他的不是，他这辈子都忘不了。

有些性急的人脾气非常暴躁，只要一点小事就会惹他发怒，像这种性子的父母亲对小孩子往往动辄打骂，在家庭教育上造成许多的问题。性急原本是在性格中的冲动性作用之下所造成的，而环境的压力又较大的话，他就会以在家对家人发牢骚来发泄他的冲动。

失眠头痛，相交发生

失眠和头痛对急性人而言是非常普遍的现象。因为他们睡得少、睡得又不深，于是白天的时候便觉得身心疲惫。由于怕影响到第二天的工作或功课，因此当他躺下来的时候就希望能赶紧睡着，但是愈急却愈睡不着，当然了，一个人的大脑愈是活动就愈不会想睡的。头痛和失眠之间往往有连带的关系，于是他们开始担心自己是不是长了脑瘤。这些人常常会去找脑外科或神经科的医师，也常要求作脑检查，赶紧拿药吃。但是因为他希望药效能快点发生，也许只吃了一次或是一天的药就急着想再找医师。如果找的不是同一个医师，他就会把旧的药留下来换用新药，到头来家里的药摆摆列列变成一大堆。在每次换一个新医师时，他总忘不了随身携带了以前所服的药给医师作参考，有些人所买过的药已经可以塞满一个水果箱了。

性急的人大概都是从小就具有这种个性的，也许他的父亲或是母亲本身就是个急性子，因此从小就养成他性急的习惯，由习惯而进一步形成他的个性。性急的母亲似乎要比性急的父亲多些，因此性急的女性要比性急的男性多，也许女性中患精神官能症者较多的原因也可以用这种性格因素加以说明。性急并不是遗传而得，倒是认同的结果。

至于这种急性子的情形要怎样才能改变呢？这一点还需要大家共同来研究研究，也许可以先从放慢说话的

速度这一点开始着手吧!

焦虑

焦虑——潜意识的恐惧

焦虑是一种来自潜意识中的恐惧感，与以往被潜抑下来的心理体验有直接的关系。有关此类的心理体验包括有愤怒、攻击性、罪恶感、不安全感等混在一起的情感。焦虑严重的人会有坐立不安的感觉，精神也无法集中，还会发生失眠的现象，甚至会有精神快要崩溃的感觉。随着紧张与恐惧而来，焦虑的人生理方面也会发生反应，也就是以自律神经的不安定为主，结果又造成心跳、心窝狭窄感、呼吸阻塞感、头痛、头晕、头部或脸部盗汗、手发抖、四肢无力等等现象。而这些身体方面的现象往往会发展成慢性的情形而且固定化起来，焦虑的人的日常生活受到许多困扰。

焦虑严重的人最突出的表征就是恐惧感，这现象是相当莫名奇妙而不可理喻的。这种人虽然明知道实际上并没有什么值得恐惧的事，却偏偏怕搭火车、汽车或飞机等交通工具；有些人怕人潮汹涌的场所；有些人担心家人外出会发生意外事故，甚至怕到连门也不敢出；也有些人因为产生了各种生理症状而担心自己是否患了某些重病如脑瘤、心脏病、胃肠癌等，一直朝坏的方面联想下去。病人在这种情况下自然会要求做全身检查及脑部、血液学检查，但即使检验报告的结果一切正常，病

是毫无效果可言了。

另有一位归国学人在自美返港之前就因为与父母亲之间的一些冲突而感到郁闷不已，而且有心跳、脸色苍白、四肢无力等症状。经过X光、心电图及血液学各方面的检查之后，医师表示他的生理上并没有任何毛病。后来他在工作或爬楼梯、爬高时即会气喘心跳、呼吸急促、上气不着下气；早上醒来时也感到十分忧虑及恐惧，结果引起胸部胀闷、呼吸困难等症状。他在去年临回香港之前又做了一次生理上的总检查，医师仍然说他没有病，但他老是焦虑重重。最近一个月以来又经常感到胸部发闷，碰到不愉快的事时会发生恐惧感，台风来袭甚至天气转阴下雨都会使他心神不宁，常觉得后脑勺发晕；如果想起还有某件事没做时也会忧心不已，甚至无法去上班，对此他深以为苦。他打算到香港来就医，但是近来又开始怕搭火车，一想到要坐车就觉得呼吸不顺喘不过气来，最后终于写了一封信来要求医师为他安排一个会谈的时间。

治疗的必要性

对这一类的焦虑人，医师首先要做的就是帮他们认识所存在的焦虑症状，并帮助他们了解此类症状的性质，必要时再做一次身体检查。而要排除焦虑纠缠的痛苦，关键就要看是否能了解并接受此种状态了。更进一步则需要了解潜意识里的问题所在，但是由于每个人都有他特殊的环境背景与生活经验，故无法在此做一概

说。不过这种恐惧感往往是在幼儿时期曾经身受并埋藏在潜意识里的，目前则是因为受到某种环境的刺激而再度复发起来，因此用普通的心理治疗方式往往仍旧无法揭露出此种早期的潜意识经验。一般而言，适度使用抗焦虑剂来逐渐减轻病人的症状，是针对病人现状所应采取的必要措施。

内疚

内疚——因罪恶感产生

所谓的“内疚”，就是把种种自己感到惭愧的事都压抑在心里而不让别人知道的情况。这种内心情况，内向的人往往容易让人发觉。但事实上内疚并不是内向的人所特有的现象。人从种种生活体验中会获得许多感受及看法，其中大部分都埋藏在自己的心中，也就是说每个人幼年时代开始就不断累积各种精神内界的体验，而这种积存起来的内界体验则可以令个人的人格具有充实而丰富的内涵，因此它在人格的成熟上是不可或缺的。一般而言，内向的人很少会在别人面前发表自己的意见，尽管如此，他们仍然具有相当丰富的精神内涵，和他谈起话来还是有不少事是可以谈得来的。内向的个性也许不太符合现代社会所强调的“开朗的人际关系”模式，不过单就内向这点来说，应该不算是什么问题，随着年龄的增长，许多人的内向倾向也就愈来愈淡了。

从临床的观点来说，所谓“内疚”就是个人具有罪恶感而予以压抑下来；或是在无意识中将它压抑下来而感觉到忧虑不安的情形。而这种内疚往往容易引起种种的精神科症状。

母亲的内疚

有位妇人丧失了年仅 10 岁的儿子。这个孩子在死前的两个月左右发生了后头部的剧痛，医师检查之后，发现他有脑压升高的情形，因此在某综合医院住院治疗。结果因为药石罔效，经过了一个月之后终于不治逝世。

在儿子病逝之前，这位母亲就感到非常内疚。因为她儿子刚刚开始头痛的时候，她不知道病情的严重性，还逼他去上学；等到头痛转剧时才急着带他去看病，然而已经迟了。这件事使得她内疚。这种内疚的感觉，折磨得她也病了，而且和她的儿子得的是同样的病。

这位妇人所采取的心理机转，是在下意识里选择和儿子同样的疾病（也就是后脑部的疼痛），想要通过这种疼痛来达成她想代儿子分担痛苦的愿望。她一方面想藉自己的痛苦来减轻儿子的痛苦，另一方而则是藉此来责备、惩罚自己，因为她对儿子实在抱有极强烈的罪恶感，在病理上这种情形被称为“病态认同”。

儿子的内疚

另一位病人，男性，7岁时父亲因肝癌逝世，他的母亲含辛茹苦抚养他及哥哥长大，及至成家立业。

不幸他（病人）的哥哥在3年前才45岁的时候突然罹患胃癌不治。自大哥死后，病人的母亲就一直和病人生活在一起，他的3个子女也都和祖母十分亲近。也许是多年的辛劳，使得他母亲很早就患了高血压的毛病，在几年前开始有暂时性因脑血管收缩而昏倒的情形发生。到了去年的某一天，终于在椅上突然失去意识而猝逝了，去世时高寿78岁。当母亲葬礼正在进行的时候，病人突然觉得呼吸急迫、脸孔胀红、心脏剧跳，产生了莫名的恐惧感，而这种情况一直没有改善。

病人逐渐回想起母亲猝逝时的情景，当时他正在叱责次女不认真念书，结果几分钟之后，母亲就从椅子上滑了下来，不久即开始呕吐，马上就丧失了意识。病人的次女是他母亲最宠爱的孙女，病人认为他在母亲面前责骂女儿，可能刺激了母亲而造成母亲的死亡。虽然这纯属他个人的想像，但是却使他产生极强烈的内疚感。从客观的立场看来，他母亲的脑溢血发作，应该是以偶发的可能性较大，但是对于一个对母亲有太强烈的情感依附的孩子而言，这样的解释仍旧是不足以排解他心中的内疚感的。于是，也就逐渐出现了因内疚而造成的病态现象——一开始害怕自己得了高血压症，又怕是得了癌症，于是开始到处求医。

虽然所有的检查都证明病人是正常的，但是他的疑虑却一天比一天重。他想到父亲方面有癌症的遗传，母亲那方面也有高血压的遗传，而父亲和大哥又都在45岁时死于癌症，现在自己正是45岁的年纪，应该也会得癌症等……这些事一直翻来覆去地在他脑海里滚。很快又增加了一些新的症状出来，他开始怕脏的东西、怕细菌传染，因此频频洗手，有时会洗上一个多小时；他又担心太太及子女可能会遭遇不测，但是又说不出可能会有什么危险发生。他嘱咐家人要小心、要保持清洁、要有规律，恐怕不依时回家的孩子会发生不幸的事故。

这样的个案，已经从内疚面完全变为一种精神病态了。

妄想

妄想与梦想

妄想一般是指不可能实现的追求而又企望实现，带有狂妄和痴心两种含义，是人类潜意识中复杂的经验与感受经过各种机转的变形、倒错面后再重现于意识中者，所表现出来的内容则多半是荒诞无稽的。“妄想”又不同于“梦想”。梦乃是潜意识里的心理内容经过浓缩、象征化后，片断地出现于睡眠之中。根据精神分析的解释，正常人的梦可以有在无意识之中达成愿望及发泄攻击冲动的作用。妄想则通常仅出现于某些人的意识中，同时控制着这些人一部分或大部分的精神作用，他们对自己妄想的内容总是深信不疑，难以打消。通常一般

人都是用胡思乱想或做白日梦的方式让各种念头在脑子里自由翱翔，其内容则是辽阔无际的。不过正常的精神状态对于现实与遐想、自己与别人之间能作明确的区分，并能充分利用这种遐想的方式来满足在现实生活中所未能达成的欲求。反之，在病态的情形下，现实与遐想之间，显然是没有什么区别的了。

妄想与病态

有一位 35 岁的妇女，育有一子一女，她的丈夫在一家贸易公司里工作，协助董事长处理各种私事已经将近十年之久，虽然为人忠厚老实，不过只知道服从老板的指令而缺乏独立创业的才干。

大约自两年前开始，这位妇人觉得自己脑子里所想的事情好像自然而然的就会被董事长知道——不论她在家里做什么事，董事长都可以用无法解释的力量知道得一清二楚，所以他认为用这种方式可以和董事长做心灵上的沟通。

有一天她家的天花板漏水，她马上认为这是楼上的人要害他们；但是过了一会儿，她又认为这是楼上的人暗示她把这件事告诉董事长，藉以沟通。

次日，她搭车的时候，一面幻想着自己再生一个儿子；这时候，突然有一辆车子超前停下，车号是 1386，她直觉地认为这就是一个答案，即“一个人娶三个太太，那么爸爸（‘八’的谐音）就会有六个孩子”。董事长现在已经有两个太太、五个孩子，她想要

多一个孩子的答案就是让董事长娶她做第三个太太，然后再生一个孩子，这样爸爸就会有六个孩子了。

某日她前往该贸易公司去找她丈夫，抵达的时候看到公司前面停了一辆车子，车号是 1799，她觉得这是董事长给她的回音，即“一娶（‘七’的谐音）了你，很久（‘九’的谐音）很久”，她觉得这是董事长了解她的意思而经常用这些号码来和她联络。虽然在妄想中她对董事长有强烈的爱慕之意，但是她从不敢当面对董事长表达出来。由于她的言行变得愈来愈古怪，于是她的丈夫强制带她来精神科就医。

不健康的心理投射

这个个案虽然未达到人格严重崩溃的地步，但是她的病状也已经属于妄想性精神病的程度了。个案整天为了自己妄想的内容而内疚、自责，日夜心不在焉。她坚决否认自己对董事长的恋情，但在她的潜意识里，对于事业飞黄腾达、家财万贯的董事长确有钦慕之意，换言之，个案对丈夫的社会地位与成就略感失望。

妄想的内容一般而言是受到个案的家庭、社会环境与时代潮流的影响；同时妄想和梦一样，有满足各种未能达成的心理欲求的作用。就这位妇人而言，贸易事业鼎盛而又多妻的男性正是她理想偶像的象征。

当她病好的时候，觉得从前恍如做梦一般，自己想来都觉得好笑。同时她也觉得自己对董事长的妄想实在无稽，在意识上她已经把这种想法整个除掉了。如今个

案已恢复在现实生活中贤妻良母的角色了。

关于酿成精神病的因素不止上述几种，还有其他许多复杂的原因，但上述几种毕竟是主要的，其他就不再赘述了。



精神病分为遗传性与非遗传性症。躁郁症和癫痫症是属于有遗传性的精神病，但是梅毒性精神病（麻痹性痴呆）则是不会遗传的，而精神衰弱与轻微精神病较少发现，但这些症状往往被误为是遗传性精神病初期。在以前精神分裂症称为“强烈神经衰弱”，至今名称才有些改变。若是你结婚的对象的亲人中，有人患有精神病，则要小心调查清楚，以免留下后遗症。

体质遗传的比率问题

关于精神病的体质遗传的比率问题，长期以来一直为大家所注意，也是精神医学界不断在探讨研究的一个问题。

医生对于精神科的住院病人给他们子孙带来的体质遗传影响力这一点上，大略估计的概率究竟应该是多少呢？事实上医生的确无法就这一点提出确切的数据，因为每一种疾病的情形都不同，而同一种疾病也会因为家庭的不同而有差异发生。如果勉强要说的话，体质影响的比率大概仅占10%，至多也只能占20%，其他80%~90%的人应该是不会有体质遗传影响的问题，不过这个回答也只是根据临床经验来提供的一点参考意见而已。

智能障碍的遗传问题

有好多入问，智能障碍是否会遗传？对此问题，我们只能说有些会遗传，而有些却不会。因为产生智障的原因太多了。

例如出生后患病（脑炎等），或出生时因脑出血而罹患脑性麻痹时，也会造成智能障碍，但这是不会遗传的。

有些先天性智障也不会传染。比如怀孕初期，母体感染风疹受影响而生出的智障儿；受原子放射能的影响或其他中毒、外伤而使得大脑受到侵犯以致引起智障，这也悉非传染性。

母体和胎儿的血型若不合，生出的孩子会有黄疸病或贫血的现象，甚至会死亡，症状较为严重时，脑部也会受损而成智障。

有些因为染色体异常而发生的智障，则很难说与遗传有关，而是属于一种突变的情形，因此是无法预测的。

遗传性的智障有很多种，若生出遗传性智障儿，则第二胎是智障儿的可能性很大，且近亲结婚更会加大比例，所以遇到这种情形，最好能限制怀孕。还有，有些孩子虽很可能成为智障儿，但若及早发现治疗，或许能防止不幸的发生。

中也会有 1 人患精神分裂症。

我们经常以双胞胎为实验，研究精神病和遗传的关系。检查结果若同卵双胞胎其中之一有精神病，则另一人的罹病率约 80%；若是异卵双胞胎则仅有 13% 而已。这是因为同卵双胞胎的遗传因子组合相同，所以罹患同样的遗传性疾病的机率高，而调查结果也证明他们遗传性强；而另一方面，他们中的另一个虽有相同的遗传因子，但却有 20% 的机会不患病，这也证明环境本身可以预防疾病。事实上罹病的双胞胎之一大都属外因性，而健康的一位则没有这个外因。

如果父母患有精神分裂症，而孩子又和生病的父母一起生活，那么这些孩子也很容易患有精神分裂。小孩如果离开父母到另一环境长大，患精神病的比率会降低，所以与其说个性遗传所致，还不如说由生长的环境来左右还恰当些。如家中有精神分裂的遗传因素，在养育孩子时要特别注意，尽量使他们的性格活泼开朗，避免强迫他升学考试，如此才可防止精神分裂症的产生。

如果患有精神分裂症的母亲怀孕时，是否可以施行人工流产呢？对这个问题要考虑的是她若是生 6 个子女，其中就有一个人可能会发生同样的疾病，但是这也只是一个概率而已，也许他生的 6 个子女中没有一个人会罹患该病，也可能他只生一个孩子却不幸发生了同样的疾病。

躁郁症的遗传问题

躁郁症即“躁狂病”和“忧郁症”，比精神分裂症的遗传性强多了，大约有 30% 患者有遗传病史。这种病如果接受治疗大都能痊愈，但仍然有许多人患这种病，所以应尽量使这种人多与外界接触，结交更多朋友，扩大生活圈，使他变得主动而积极，不要让他经常处在静态之中。许多成功的政治家或企业家，多拥有悲观的个性，这些人都有躁郁症的特征。类似这种个性我们称之为循环个性，这种性情虽然不错，但太极端了反而不好，因此最好能有中庸温和的性情。

第四章

形形色色的神经质



何谓神经质

精神医学上，经常谈到神经质；在生活中也常常说某人神经质，究竟一个人在说话及行动上有什么样的表现才叫做神经质？这个定义恐怕也不是容易下的。

在一般人的观念中，所谓的神经质指的是做事非常细致、对某些事物的态度十分执着、或者是对样样事都要操心挂虑的倾向。神经质和神经官能症可以说是两种不同的状态，不过就临床上的观察所得，神经质倒是构成神经官能症的一个主要因素。

神经质的表现方式大体说来有三种：第一种是完美癖，也就是要求所有的东西都要十全十美；第二种是具有自恋性而致变成虑病症的情形；第三种的表现方式则是对于别人考虑得太多以致形成害怕面对他人的情形。这三种倾向也许会同时发生在同一个人身上，不过每个人所表现出来的倾向和症状都是互不相同的。以下对三种表现的各项特征略加叙述。

完美癖

过度追求十全十美的人因为要求自己所做的每一件事都必须是完美无缺的，所以把全副精力都放在事物上，其实他想要做的未必都是有用的事。比如说在清洁方

面，有些人喜欢让自己的周围保持绝对的干净，于是乎为了要符合自己这种标准，他整天都得忙着打扫、擦拭，做这些反复的工作，甚至连枕头套、床罩都得每天清洗，不知道要花多少时间在这些清洁工作上。也有些人是把注意力放在煤气开关、抽屉及门的上锁方面，他们所要求的是绝对的安全，因此要防范所有具有危险性的事物。当然在超过了一定的程度之后这种人就会发生反复关煤气开关、关门这一类的动作，而这种反复动作的结果就是形成了强迫症状，而当事者本身也会发现这种动作并不见得会有什么实际上的效益可言。

具有完美癖的人在某些事情未完成时，会产生相当强烈的焦虑感，觉得浑身不对劲，所以不论在任何情况下都非得要今日事今日毕不可，一旦碰到什么事没法马上做完时就会紧张万分。倘若跟别人一起做事时别人不根据他的满意标准来做的话，他也会觉得如坐针毡。像这一类神经质的人同时也是个急性子的人，往往也非常富有责任感而规规矩矩、一丝不苟地做事，但是他们经常会对某些事情执着起来以致总是想不开。譬如说他离开家出外游山玩水之际，却因为整个心牵挂着家里的事面无法享受到户外生活的乐趣；有些上班的人在碰上长期的假日时仍然惦记着自己的工作而无法轻松下来。像这些人都可说是不折不扣的完美性与执着性的神经质，不过，具有这种个性的人做起事来倒是比较正确、认真而负责，但过于追求完美就属不正常而成了病态。

检查完毕之后，他们很少会有人继续前来精神科接受治疗，这是因为他们的病况并不严重，有的仍然维持在神经质的状态，并不需要接受精神科的心理治疗。

由于挂虑身体的健康状态，这些人自然会把全副心思都集中在身体的生理功能上。例如当身体略为消瘦时就开始担心是不是染上了严重疾病；有人因为怕冷而在大热天也要穿上厚厚的衣服；有些人在不能照自己习惯睡眠的时间去睡觉时就会紧张起来而发生失眠的现象，也就是在上床之后如果入睡所需的时间拖长了一点，他就会开始急躁、担心、忧虑、恐怕第二天的精神不好，过度急躁的结果有时使得他整晚都无法入睡。在忙碌的现代生活之中，头痛是一种很普遍的症状表现，而神经质的人一有头痛的情形马上就会联想到某某人曾经长过脑瘤，于是开始担心自己是不是也患了同样的毛病。在临床上常有许多头痛的病人要求做脑部的检查，三十年前的病人通常都是要求做头部 X 光检查，近二十多年来病人则多半要求做脑波检查，近来有许多病人开始要求做脑部的扫描了。而在这些人的检查结果记录中，绝大多数都是正常无碍的。

人格自卑

第三种的神神经质表现方式是发生在人际关系上的，这种神经质的内容涉及到个人的姿色、容貌、身材、口才、表现、自我成就力、给别人的好感、别人对他的观感等等非常广的范围，不过主要都是集中在与他

超神经质的症状表现

一位 18 岁的学生，可以说是最具典型性的神经质症状病人。

这位病人由于对别人尤其是同班同学有着过度的神经质的顾虑，因此整个高中生涯一直过得非常紧张。起初他在班上觉得周围的同学可能会闻到他的体臭，虽然在事实上他觉得自己的体臭并不浓，但是心里认为别人闻到这种味道时一定会感到相当困扰，因此心中总是觉得过意不去。后来他又认为自己的体臭可能是以发自胸部和腋下的最为强烈，别人一定闻得到的；再接下来他又想到自己脚部的臭味最令人嫌恶。在这种情况下他非常注意别人无形中的反应来判断是否他们已经闻到自己的体臭，同时也极力避免走动，以免体臭会散发出去，就算要走路的时候也要尽量轻踏、慢行。他虽然也想抹去脑中这种想法，但是却一时一刻也无法摆脱这种观念，到了最后他觉得自己实在是愧对班上同学，认为这三年以来全班的人都因为他的存在而没有好日子可过。在他的想法中，毕业的那一天也就是他获得解脱的一天，但是离这天愈近，他愈觉得自己对同学的罪恶感无法加以释怀。于是他写了 30 张明信片给同学，其中一一记下他对每位同学不起的地方，为他的体臭所带给大家的不快而道歉，也为因为他的存在而使大家的高中生活不愉快而谢罪。似这位同学的想法与行为表现，已经大大超

过神经质的表现，可以说几乎已到了边缘性精神病的地步了，因为他所相信的别人对他的感受的确已经进入妄想的地步，倒错了别人客观的看法，完成了他对现实的歪曲。神经质症状是一种与社会文化有密切关系的现象，在神经质倾向相当普遍的社会中，神经质的人究竟是有病或没病是依其神经质的强度而定，而不是根据神经质的病理本身来判断其是否属于病态。



何谓神经官能症

神经官能症是概括一组神经机能性疾病的一个名称，其中常见的有神经衰弱、癔症、强迫症以及各种内脏神经官能症（如心血管神经官能症、胃肠神经官能症等）。神经官能症的发病机理，迄今还有不同的认识。但精神因素在发病上起着重要作用则是一般公认的事实。本组疾病临床症状繁多，甚至多个系统均能表现功能紊乱，病人甚感痛苦，然检查时多数难以发现阳性体征，理化检查也常无异常所见，所以治疗也无所适从，相当棘手，没有特效方法，往往只能对症处理。

祖国医学认为，此类病症究其病因多为忧愁、抑郁、愤怒、思虑以及悲伤不解，所欲不遂等剧烈精神情绪波动所致。因情志致病多累及于心肝两脏，从生理上看，心主神明，肝司疏泄，精神思维活动由心所辖，而身之气机舒畅则由肝所主。因此，剧烈的精神情绪波动是首犯于心。正如《灵枢·口问篇》说：“悲哀忧愁则心动，心动则五脏六腑皆摇”。临床所见患者往往主诉之症首先是失眠、心烦、心悸。其郁怒难伸，是肝木不能遂其条达之性，气失泄，因而出现胸闷、嗝气、喜怒无常或悲伤欲哭等症状。

下面叙述神经官能症中常见的几种类型。

经衰弱症，单独治标，病根犹存，并无助益。用食疗法治疗，第一要注意用补气药，培补元气，使患者元气充沛，神经坚强，精力便旺盛，各种神经衰弱的心理病态才能消减于无形。至于患者会有失眠、怔忡、肢冷、盗汗之症状，因病势变幻不定，须逐渐予以各个击破，不可操之太急。

总之，本病症状极大多数是主观而含糊的，临床上各类症状可能掺杂在一起，形成了多种多样的临床表现。

起病多数是逐渐的，病程较长，常有反复与波动，一般而言，预后是良好的。

【诊断和鉴别诊断】根据发病有精神因素和上述临床表现，体格检查和实验室检查的阴性结果，病人惟恐诉述不详和迫切要求医治，诊断一般并不困难。

在工作中必须防止滥用“神经衰弱”这个诊断，以免遗漏了可能是严重的器质性疾病。许多躯体疾患和精神疾患的早期都可能表现为神经衰弱症状群，如高血压、肝病、甲状腺功能亢进、肺结核、贫血、脑动脉硬化、脑瘤、慢性工业中毒以及精神分裂症的早期等。脑震荡后遗症也易被认为是神经衰弱。它们各有其不同病因和临床特点，只要在诊断时考虑到器质性病症的可能，仔细采集病史，周密检查，还是容易鉴别的。

部分精神分裂症病人的早期可出现类似神经衰弱的症状，但他们对疾病的态度通常并不关切，不肯主动就医，情感不协调，有思维障碍等，经认真检查后可不致

混淆。

西药疗法

神经过敏和焦虑症状突出者，可予轻性安定药，如利眠宁 10 毫克，一日三次；或安定 2.5 毫克，一日三次；安宁 0.2 ~ 0.4 或安太乐 25 毫克，一日三次。

精神疲劳的患者可短期选用小剂量兴奋药，如溴咖合剂，每次 10 毫升，一日三次；谷氨酸片，每次 0.6 ~ 3 克，一日三次，哌醋甲酯（利他林）片，每次 10 毫克，每日早、中午两次服用。

对失眠患者，一般于夜晚加大轻性安定药的剂量，可以诱导正常睡眠，必要时也可短期选用水合氯醛，巴比妥盐、安眠酮，导眠能等安眠药，使用时应交替轮流，不要固定一种药物，睡眠好转应及时停药，以免形成依赖性和成瘾。

有植物神经机能失调的患者，可用谷维素，每次 10 ~ 20 毫克，每日三次，连用 3 个月左右。

中药疗法

【处方一】淫羊藿 24 克，陈皮 9 克，桔梗 9 克，半夏 9 克，当归 9 克，黄芪 15 克，党参 15 克，白术 9 克，茯苓 9 克，熟地 21 克，枸杞子 15 克，郁金 9 克，细辛 3 克，甘草 6 克，酸枣仁 15 克，大枣 5 枚。

【服法】一日一剂，水煎服，7 剂为一疗程。每服一疗程药后，间隔 5 天再服第二疗程的药。

【疗效】 共治神经衰弱病 34 例，治愈 27 例，占 79.4%；好转 5 例，占 14.9%；无效两例，占 5.7%。

中医认为神经衰弱此类症候群乃为七情所伤而致郁，久郁而逐渐引起五脏气机不和，及劳倦思虑太过，必使气血耗伤，伤其心神，神魂无主，所以处方中用郁金以解其郁，用党参、黄芪、当归、大枣、甘草、酸枣仁调补气血，养其心神。心脾不足，使其肾精虚衰，如医家汪昂所述：“人之精与志，皆藏于肾，肾精不足则气衰，不能上通于心，故迷惑善忘也。”因而用熟地、枸杞子、淫羊藿补其肾，壮其肾阳。

对食欲不振、腹部胀满、腹泻等消化不良症状，中医认为：郁则使肝失条达而犯其脾胃所致，故用白术、茯苓，补脾健胃。

头昏头疼、四肢麻木、发冷、胸闷等症状，乃为风痰之症候，中医认为：“郁则生痰者，凡五脏之伤，皆能致之”。因而，用半夏、细辛，开胸化痰，祛风镇痛。

症例治验

例一

【辨证】 肝郁气滞，化火伤阴，心阴不足，神无所附。

【治疗】 疏肝解郁，滋阴润燥，养心安神。

百合 36 克，夜交藤 51 克，当归 15 克，白芍 21 克，郁金 15 克，香附 15 克，连翘 15 克，莲子心 15

克，生地黄 21 克，麦芽 51 克，珍珠母 30 克，甘草 15 克，大枣 9 枚。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】上方曰“逍甘百合汤”，应用该方观察治疗 50 例神经衰弱患者，其中除 3 例合并有更年期综合症者外，均使症状改善治愈，获得了较为理想的疗效。

汤××，女，43 岁，患者近半月来夜不入眠，心烦，健忘，胸闷，时常长吁短叹。舌质红，苔薄黄，脉弦数。经西医检查后诊断为神经衰弱，中医诊其乃为肝郁气滞，化火伤阴，心阴不足，神无所附。治当疏肝解郁，滋阴润燥，养心安神。故投以逍甘百合汤，病者连进 12 剂，诸症得除，复如常人。

例二

【辨证】淤血内阻，郁而发热，淤热扰心，心神不宁。

【治法】行气活血，化淤清热。

生地 12 克，川芎 6 克，红花 6 克，桔梗 6 克，桃仁 6 克，当归 9 克，赤芍 9 克，牛膝 9 克，柴胡 9 克，佩兰 9 克。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】陈××，女，40 岁，失眠已半年之久，常彻夜不眠且伴有头晕、欲吐、胸闷、心悸、纳减、口苦、乏力，不能坚持正常工作。经检查临床诊断为神经衰弱，服用多种安眠药物，初服略见效果，继用无效。患者面色黧黑，无华，神萎，脉小弦略涩，苔白腻，舌

质绛，舌边紫绛，并见紫色淤点数个，舌下静脉呈紫黑色。脉症合参，此乃淤血内阻，郁则发热，淤热内扰，心神不宁。治当行气活血，化淤清热。处以上方，服药一剂，病见好转，夜已入眠 8 个小时左右，3 剂服尽，诸症大减。嘱原方中加用枳壳 3 克，桃仁增至 9 克，继续服用。其后略作加减，共用药 23 剂，诸症悉除，病获痊愈。已追访 5 年，病人坚持全日工作，未见复发。

例三

【辨证】阳不入阴，阴阳失调。

【治法】引阳入阴，交通阴阳。

法半夏 12 克，秫米（高粱米）30 克，夏枯草 9 克，干百合 30 克，紫苏叶 9 克。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】伍××，男，51 岁。患者自述夜卧不寐已近一年，日渐加重，乃至通宵不眠，耿耿残灯，辗转待旦，且伴有自汗，纳食不香，时吐涎沫，周身乏困，耳鸣头晕，脉沉，舌苔正常。曾服用“温胆汤”、“养心汤”、“桂枝龙牡汤”等，均未获效。窃思“胃不和则卧不安”，“阳不入于阴故目不瞑”。此证不食，头晕，而吐涎沫乃痰浊中阻，胃不和降之阴。自汗乃系卫气不得入于阴，阴阳不交之象。于此可见不寐之因系阳不入阴，阴阳失调，治当调和脾胃，引阳入阴，交通阴阳。故投以上方。服药一剂，当晚即能安睡。惟汗出较多。再于方中重加茯苓服用，其汗亦止，纳食增加，诸症渐平，精神日益振作。

杨××，女，28岁。患者5年来头晕不寝，反复发作。今已妊娠8个月，腰背酸痛，近月来不能安眠，有时虽能入睡，但眠而不熟，梦寐多端，恍惚不安，口苦口渴，小便频数，大便干结，脉滑而数，舌苔无异。患者曾服用中药数剂以及氟丙嗪，以期能够安睡，然效果不著。即投以上方，再加入桑寄生15克，川续断12克。服药一剂，当晚即熟睡两个小时许，翌日再用一剂，入夜甚适，如若常人。自此不眠之症一扫而除。

方中半夏生于阳长之会，成于阴生之交，能使阳入阴而寐；秫米治阳盛阴虚夜不得眠；夏枯草禀纯阳之气，补厥阴血脉，能以阳治阴；百合花朝开暮阖，紫苏叶朝提暮垂，皆能引阳气而入阴分。诸药合用，共奏交通阴阳之功，故治其不寐而收捷效也。

例四

【辨证】心肾不交。

【治法】滋阴降火，交通心肾。

黄连6克 肉桂6克 玄参9克

【服法】水煎服，每日一剂，分3次服。

【疗效】熬××，女，24岁。失眠已达半年余，每夜仅睡一小时左右，而近月来病情加重，头昏，目眩，咽干，口渴，喜热饮，自觉上半身发热，下半身发凉，而赤神差，夜尿多，大便难，月经提前，色质黯红，8天始净。诊其六脉稍数，左三部沉细，右尺沉弱，舌尖红，苔黄白。详考病因，乃素有痔疮，反覆出血，且有妇科之疾。脉症合参，此因出血较多，阴血亏

虚，心阴不足，火不下承，乃致心肾不交。治以滋阴降火，交通心肾。遵古人“善补阴者，必于阳中求阴”之说，故仿韩飞霞“交泰丸”而拟“交泰饮”方，投药一剂，当晚病者已能睡3个小时以上，头昏目眩、咽干等诸症皆感有减。上方见效，嘱其方中加重玄参为24克，以养肾阴，加甘草3克以和中，另冲用蜂蜜60克以滋肠道，再进4剂。服后，诸症皆除，睡眠已恢复正常。随访，情况良好。

下面是按临床上两组症状的辨证施治：

(一) 头痛、头晕、目眩或耳鸣、易怒、床象有力等阳亢现象。处方：钩藤 珍珠母 旱莲草 女贞子、菊花、白芍、丹皮、生地、白蒺藜等加减。

(二) 头昏、体倦无力、心悸、而色无华、脉象无力、腰酸背痛等虚弱现象。处方：熟地、党参、黄芪、当归、白术、茯苓、五味子、酸枣仁、龙眼肉等加减。

(三) 如有失眠，一般以酸枣仁汤为主。酸枣仁15克，知母9克，茯苓12克，川芎6克，甘草6克，可在上述方剂中加减并用。

一般失眠患者亦可用中草药，如：夜交藤15克，松针30克，酢浆草15克，红枣6枚，煎服。中成药安神补心丸或养血安神片亦可选用。

精神疲劳可用五味子片，每次2片，一日两次。

癔病

癔病，又称歇斯底里，是神经官能症中常见的一种。患者以女性多见，大多发病突然，有明显的精神因素而致，可因恰当的治疗而迅速恢复。其临床上可类似多种疾病，内科各科均可遇到。

【病因病理】

本病多由情志因素或体质衰弱所致。两者均可导致脏腑亏虚，使五脏所藏之神不安而见本病诸症。五脏亏损，阴阳失调，故本病常延搁时日，日久不愈或反复发作。

一、五志过极

本病常在过度的情志刺激下发病。《素问》指出：“喜则气缓，怒则气上，悲则气消，恐则气下，惊则气乱，思则气结。”故情志刺激，可使气机失调，经气运行不畅，进而伤及五脏。所谓“喜伤心，怒伤肝，思伤脾，忧伤脾，恐伤肾。”从而使五脏气血、阴阳失去平衡，五脏所藏之神不安，或五脏之所主失常，则表现出本病症状。

二、劳逸失调

过劳则伤气耗精，过逸则气血壅滞。劳逸无度，则气血难以充养五脏。五脏精气不足，则五脏所藏之神不安。如《灵枢·本神篇》所述：“肝气虚则恐，实则怒”，“心气虚则悲，实则笑不休”。五脏所藏之神不同，

损及何脏，乃见何证。

三、病后失养：

历经大病，邪正交争之后，邪气消退，正气耗损。若失于调养，则气血亏虚，阴阳失调，五脏之精得不到补偿，故五脏之神不安。初病在一脏，如肾虚多惊恐，心虚则悲泣；日久则传变，或于病及母，或相克相侮，以致两脏同病，症状复杂。

【临床表现】癔病的临床表现可发为精神障碍（分离型癔病）和躯体机能障碍（转换型癔病）两大类。

精神障碍（分离型癔病）

症状的发生与精神因素密切相关。在第一次发病前一星期内可追溯到明显精神因素。起病后表现为下列症状：

病人大哭大笑，大喊大叫，蹬足捶胸，倒地翻滚，手舞足蹈，撕衣咬物，乱唱乱骂，常有装模作样的戏剧样表演。病人以生动的表情、夸张的动作以博取注意和同情。如用唱山歌小调的方式，把内心不愉快的事唱出来，在人多的时候发作尤剧。发作历时数分钟至数小时不等，但易反复发作，只要询及精神因素，触及要害，或暗示“又要发作”，便能即时再发。有的病人以不符其年龄的儿童样语言哭唱，表情和行为也摹拟儿童的方式，称为“童样痴呆”。还有，迷信思想影响较深的人，发病时往往有所谓死去的人附体说话的做作。

癔症性昏厥可单独或在情感爆发时发生，病人突

然倒地，屏气或作过度喘气，不言不语，双眼紧闭，面色潮红，全身僵直或手足不规则舞动，维持十余分钟至数小时。此时，意识并未消失，眼球活动良好或检查时似故意逃避，肌腱反射正常，也无病理反射。发作形式颇为特殊，一般诊断并不困难，至于真正要与癫痫鉴别的癔症性大发作那是不多见的。

有些病人发病时变得好象什么都不懂，称自己年方三岁，二加二等于五，一个人有三只手等，给人以故意讲错的印象，看来痴呆很严重，但从片断正常活动中却反映出其智能并非真正缺损，叫做“假性痴呆”。

躯体机能障碍（转换型癔病）

运动障碍：癔症性瘫痪，以单瘫和截瘫为多，常系突然发生，如治疗或暗示不当，症状可能面定下来，长期肢体不能动弹或卧床不起面不会行走，影响工作和生活。瘫痪肢体腱反射正常或增强，肌张力正常，无病理锥体束症，除长期不动而致废用性萎缩外，一般肌肉无萎缩，检查时可见到对抗的两组肌肉同时收缩，以致无法完成指定动作，电刺激反应也是正常的。有的病人表现为运动增多，加粗大的震颤，肢体的不规则抽动或类似舞蹈样动作，在检查时症状愈加明显和加剧，在安静时或设法分散其注意力后症状可减轻或消失。癔症性的言语障碍以失音为最常见，病人突然失去发音能力，只得借助于手势或笔谈以表达思想和要求，声带检查活动良好，吸气时能保持内收状态，能咳出声音。有些病人并非全部失音，但只能发出喉音或耳语声。

感觉障碍：视觉障碍多为黑朦，病人突然失明，此时瞳孔反射、眼球活动都是良好的，眼底检查也无阳性发现，病人虽说什么都看不见，可是在单独行走时却能避开障碍。癔症性弱视、色盲、视野缺损等较易造成假象，以致把器质性的疾患误诊为癔症。另外，各种脑部疾患因其累及中枢神经系统的功能也可能产生癔症样表现，在脑萎缩、额叶肿瘤中，癔症样症状可能是最早出现的症状。所以，当遇到中年或晚年的首次癔症样发作的病人时，检查与诊断尤宜谨慎。

西药治疗

可口服安定 2.5 毫克或利眠宁 10 毫克，一日三次；对兴奋较剧的病人可服氯丙嗪或泰尔登 25 ~ 50 毫克，一日二至三次。极度吵闹时可即时肌注苯巴比妥 0.1 克，或氯丙嗪 50 毫克加东莨菪碱 0.3 毫克。

中药治疗

中服对本病的治疗以调整五脏阴阳气血、填五脏之精，以养五脏之神为本。若兼见气郁化火，或痰阻、或血淤等均为内生之邪，当先攻邪，分别选用泻火、开窍、涤痰等治法。

一、肝郁化火：

情绪不稳，烦躁易怒，头痛眩晕，失眠，多梦，易醒，肢体瘫痪，暴聋，暴盲，神识不清，肌肉紧张，麻木，震颤，胸肋胀痛，口苦咽干，便秘，舌边尖红，

舌苔黄，脉弦或弦数。治宜清热泻火，平肝安神，用泻清丸或天麻钩藤饮加减。

龙胆草9克，栀子9克，大黄9克，当归9克，川芎6克，天麻9克，钩藤21克，石决明30克，黄芩15克，杜仲9克，牛膝9克，桑寄生9克，夜交藤21克，茯苓9克，茯神9克，牡蛎30克，龙骨30克水煎服，每天一剂。

二、肝郁脾虚：

情绪低落，多疑，注意力不集中，喉部有梗阻感，强迫思虑失眠，难于入睡，胸闷，腹胀，月经不调，食欲不振，便溏，舌质暗淡，舌苔白腻而厚，脉弦细。治宜以疏肝解郁，健脾化痰为主，选用逍遥散为主方。

柴胡9克，当归9克，白芍9克，白术9克，茯苓9克，甘草9克，生姜3片，水煎服，每日一剂。

若妇女兼月经不调者，加丹皮9克、栀子9克以活血、清热、调经。

若兼郁痰明显者，上方加四七汤（半夏9克 厚朴9克 苏叶10克）以加强健脾化痰解郁之功。

若肝部重者，加香附9克，枳壳9克，川芎6克以疏肝解郁。

三、心脾两虚：

精神不振，乏力，多思多虑，失眠多梦，或多寐，健忘，心悸，胆怯，惊恐不安，妄想，腹胀纳差，便溏，舌淡边有齿痕，脉沉细弱。治宜健脾益气，养心补血，用归脾汤加减。

克，肉桂 6 克，茯苓 9 克，党参 21 克，白术 9 克，干姜 9 克，丹皮 6 克，泽泻 9 克，甘草 9 克，水煎服，每天一剂。

症例治验

例一

【辨证】气郁痰阻，蒙蔽清窍

【治法】涌吐痰湿

瓜蒂 9 克，赤小豆 9 克，豆豉 9 克，郁金 9 克。

【服法】水煎服。

【疗效】李××，女，43 岁，因家庭不和，忧怒悲伤，觉心中烦乱难忍，情志郁而不伸，突发失语，时悲时哭，舌苔厚腻，懊恼不眠，以手摸胸，烦躁难忍，手指咽喉，梗塞难息，欲吐不出，脉滑数，此为气郁痰阻，蒙蔽清窍，治以涌吐痰湿为急务。

投上方一剂，水煎服。服后先吐痰涎碗余，后泻 3 次，诸症减轻，但仍不能语。由于催吐重剂，服之难受，患者拒再服用，后经多方劝解，又进一剂，仍先吐后泻，开始言语，诸证好转，后以饮食调理而愈。

按：怒伤肝，忧伤脾，肝郁不舒，不能疏泄经脉之气。

例二

【辨证】热邪内结，上扰神明。

【治法】养阴除热，解郁除烦。

生栀子 9 克，淡豆豉 15 克，麦门冬 9 克，广郁金

9克，石菖蒲9克，淡竹叶6克，炙甘草6克，水煎服，每日一剂。

实热偏盛者，加川大黄、川枳实、川厚朴；肝阳偏亢者，加生石膏，杭菊花，霜桑叶，西杞果；痰湿内盛者，加胆南星，毛橘红，白茯苓；阴虚内热者，加酸枣仁，生阿胶，生鸡子黄。

【疗效】赵××，女，46岁，患者述其病已8年之久，间歇发作，每次发病时心烦意乱，双目不睁，牙关紧闭，可持续三至十余日，尤其是精神受刺激时，发作频繁。每次发作且伴有大便秘结，多三日解一次，小便黄。曾屡服镇静药物及泻下药物，未能获理想效果。

检查其体质尚好，精神抑郁，智力正常，舌质边尖红，舌苔中心黄，脉沉弦有力。临床诊断为癔病。此系郁热内结，上犯神明，治当养阴清热，解郁除烦。用上方剂，其方中再加酒大黄9克，炒枳实9克，姜厚朴9克。前后略作加减共用药二十余剂，久病得愈。

张××，女，50岁。患者自述病史已达10年之久，病作时头部沉重，胸闷心烦，继之牙关紧闭，痰涎壅盛，神识不清，四肢发冷，两手紧握，大哭之后诸症缓解。往往因情志不舒而诱发，每次发病延续约两小时左右。月经正常，临床诊断为癔病。用上方剂去麦门冬，加入白扁豆21克，胆南星6克，毛橘红12克，白茯苓30克，大枣3个。进退用药30剂，病获痊愈而未再复发。

周围，勿令倒置。再加蜂蜜冲入开水，以浸没为度，放在锅内炖熟，去费菜，分两次食尽。用于肝郁脾虚型的癔病。

④ 鸡蛋两个，灯芯草 6 克，朱砂 3.6 克（研粉）。将灯芯草放入砂锅加水 100 毫升，文火煎煮 20 分钟滤入碗内，加蛋黄及朱砂粉拌匀，隔水蒸后服用。每晚一次，7 次为一疗程。对癔病患者之心神不安、烦躁不眠有显著疗效。

病例介绍

她突然感到全身麻木

念高中的 N 女在某一天放学后搭上巴士时突然觉得全身麻木，等她回到家的时候，发觉自己的左腿已经完全无力而且有知觉异常的情形，此后大约有一年的时间她一直拄着拐杖上学，学校的体育、军训及课外活动也因此而不能参加了。N 女的父母在焦急之下带着她到处探访名医，但是神经科医师、脑外科医师都没有办法查出她的病因。在高一下学期末的时候，N 女的情绪显得非常低落，无法集中精神，在家里会无故乱发脾气，偶尔还会爆发一些暴乱行为，尤其是会拿东西掷打她的母亲和大她两岁的姐姐。在这种情况下医师劝她住进精神科病房接受治疗，但是 N 女坚决拒绝了医师的建议。到了暑假，N 女在发脾气的时候曾经拿起刮胡刀割腕，大声哭泣，进入情绪错乱的状态中。

她要跟父亲一起睡

此后的两年半之中 N 女一直待在家里，精神状态时好时坏，较坏的时候就会表现出暴乱行为和自杀企图，好转一点时就好像三四岁大的小女孩一样，言语内容幼稚，爱看电视，看卡通影片，经常像腿部的麻木，和过去的朋友的一切关系都断绝了。她的母亲看到她经常要装得很小的样子，像要设法纠正这种情形，但是一经训诫，她不仅要攻击母亲，而且在发怒的当晚一定会闯入父母的卧室赶走母亲，同时要求像父亲一起睡。最特别的是每当她到父母房间睡的时候，一定随身带来一个大皮箱，里面装满了她小时候所喜欢的东西和陆续买来的零里东而如玩具、化妆品、小饰物等。这些东西她从来都没有丢掉过一件，以前在念书的时候还经常带一些在书包里，到了学校后一个人偷偷欣赏。当她像况较好的时候，在家里还可以表现出一副愉快的样子，但是走动的时候都只动右脚，使得家人烦不胜烦。平时她很喜欢跟邻居家中三四岁大的小孩子玩，经常摸弄他们，替他们擤鼻涕，非常照顾他们。而这个时候她过去的同学有的已经念大学，有的已经进入社会了。

后来 N 女的手指上长了几个疣瘤，她随手就用指甲把疣瘤给抓破了，抓破流血之后，就随便拿块布包起来，好像毫不在乎的样子，而且拒绝去看皮肤科医师。她幻想着能当个小儿科医师来照顾可怜的孩子，有时又想要当幼儿园的老师，因为她觉得小孩子们很可爱。

如果家人指出她根本没念书怎么能当医师就会使她大发雷霆，闹着说家人都在欺负她、侮辱她、瞧不起她，于是要打母亲、摔东西、捣烂家具。她的姐姐因为受不了N女的攻击，在考上专科学校之后就离开家跟同学在校外租屋合住了。

她的过去、现在、将来

N女父亲开设的公司在业务上相当鼎盛，母亲也受过高等教育，家庭里也从来没有发生过什么重大的事情，唯一比较特殊的是她的父母都是在早年即丧失父母，因此N女从来就没有见过祖父母们。不过就N女而言，她人生中最重大的事件是从她生下来就开始的。在她生下来不久后母亲就发现她的右半身比左半身要略胖些，尤其是右脚比左脚大，家人因此而担心这种差别会不会愈来愈明显。到了3岁的时候她的右脚果然比左脚长了约一公分左右，从此她的母亲经常带着她到处找医师，但是因为这只是先天性的轻微畸形，算不了什么病，医师们都表示不需要治疗。但是由于N女的母亲对女儿的缺陷怀着罪恶感，恐怕是自己在怀孕时出了差错才造成N女的问题，因此她一再带N女到医院去，希望能矫正她所谓的畸形。

N女在幼年的时候除了有左右脚大小不同的问题外，在她的右颈部到肩膀的部位都长有红痣，而且在她四五岁的时候红痣的颜色愈来愈浓。在上幼儿园不久之后，老师就告诉N女在洗澡的时候要把脖子洗干净，N

女回家后把这些话禀告母亲，当时她本人似乎并没有什么特别的反应，反而是母亲十分内疚而激动，觉得女儿太可怜了。小学时候的N女成绩非常好，比起姐姐来是既乖巧又伶俐，因此父母亲的注意力逐渐转移到不太爱念书的姐姐身上。姐姐考上初中之后，每当周末、节假日父亲都陪着她姐姐念书，所以她从小学四年级起就体验到对父母亲强烈的怨恨及对姐姐的嫉妒。某日她在游泳池边遭到几个男孩子的取笑，他们嘲弄她有扁平足，自此以后她即表示不喜欢游泳，连带的也不喜欢其他一切运动。

初一的时候N女得到了最低的体育分数，她开始埋怨自己念的学校不是最好的学校。初二的时候她听说体育成绩不好的话比较难考进高中，于是加入了排球队而且表现得不错，她的体育老师也对她很好，似乎这是她表现得最好的一年。初三的时候又换回她初一时的体育老师来带他们的班，N女虽然还是继续参加球队，但是逐渐显示出消极、忧愁的态度，成绩也愈来愈差。有时还会说一些侮辱姐姐的话，如说姐姐是靠着父亲的社会关系才考上高中的。

N女考上高中之后又开始抱怨自己的学校不够好，不过她在学校里还是交了一些朋友，同时加入了篮球队，但是她表示自己只想担任球队的干事，本身并不想打球。在左腿开始麻木之后，N女遂进入所谓的歇斯底里症了。等她勉强念完高一之后，她就完全脱离了正常的学生生活，在外界接触到的人都是医师。她也曾

经告诉过医师自己将来想当医师，有位医师问她没有念过医科的人怎能当医师，结果她马上大哭大嚷说医师打心底瞧不起她，以为自己当上医师就了不起了。在病得最厉害的时候她就像是个3岁大的女孩子一样成天抱着一个自己做的小洋娃娃在家里晃来晃去，也不跟母亲说话。最厉害的一次是她拿东西丢母亲，当母亲叱责她之后两人开始互相殴打，然后N女回房去在手腕上划了7刀，再用棉被掩盖起来，等到第二天被家人发现的时候，整张床上都是血淋淋的。N女对于自己为什么要割腕从来没有作过任何解释。

最后N女的家替她请了一位在初中任教的男性家庭做师，他一面给N女补习功课准备复学，一面还带着N女到各处游玩，接触外界，这种方式似乎对N女颇有帮助，她终于逐渐恢复正常了。精神科医师一直定时与家庭做师讨论N女的情况，作间接的咨商。过了两个月她想到在高中毕业之后报考药学系，因为她过去所有学科中以化学的成绩最好。在她复原的过程中另外一个重要的问题就是要怎么样来减轻她母亲心中的罪恶感，对于这一点医师也已经为她母亲订下了心理治疗的计划。

强迫症

本症以强迫症状为主，发病前可能有精神因素。病人发病前多做具有胆小拘谨、刻板固执、想守成规、

克制自己的行为，故而在一般的情况下不易被人察觉出来。

以上的种种强迫症状并不是在同一病人身上全部呈现，大多数病人仅出现其中某些症状。

根据以强迫症状为特点的临床症象，自知力完整，结合病前的表现，诊断一般不难。精神分裂症也可出现强迫症状，可根据上述诊断要点，结合有无精神分裂症的其它症状如思维障碍，幻觉妄想和情感不协调等而加以鉴别。

防治

在治疗中，根据病人对强迫症状明知不对的特点，鼓励病人以坚强的毅力与疾病作斗争，控制自己的情绪、思维和行为以克服症状。适当参加体力劳动也是有益的。针刺疗法：取穴神门、内关、间使、照海、足三里、三阴交等穴，可能需要较长疗程。小剂量三氟拉嗪、奋乃静、氯丙嗪或泰尔登以及利眠宁、安定等药物治疗，可帮助解除情绪焦虑和紧张，也有利于症状的减轻和消除。

中药治疗

【处方一】

主治忧愁思虑伤心、令人惕然心跳动、惊悸不安之症。

当归（酒洗用身）、生地黄（酒洗）、远志（去心）、

茯神各 15 克，石菖蒲 9 节，黄连 7.5 克，牛黄 3 克（另研），辰砂 6 克（另研），金箔 15 片。

【制法服法】上药以前六味研细，入牛黄、辰砂二味末子，猪心血为丸如黍米大，金箔为衣，每服 50 丸，煎灯心汤送下。

【处方二】

主治体弱惊悸。

朱茯神 9 克，枣仁 6 克，远志 9 克，柏子仁 9 克，枳壳 4.5 克，当归 6 克，山药 12 克，石菖蒲 4.5 克，炙黄芪 9 克。

【服法】水煎服。

症例治验

例一

【辨证】心虚胆怯，触事易惊，梦寐恍惚，恐惧不安，敏感多疑，虚烦不眠，头昏目眩及某些幻觉妄想等症状。

半夏、远志、菖蒲各 15 克，云茯苓、龙齿各 30 克，竹茹、枳实、陈皮各 9 克，生甘草、琥珀各 6 克。

【服法】水煎服，日一剂。

【疗效】陈××，男，40 岁。因日久劳逸不妥而出现行为、观念异常。怕烟头未熄而引起火灾，以鞋底反复磨灭，将鞋底磨破亦踌躇再三；怕染脏物而经常洗手，虽洗数十遍，指皮被洗破，仍恐污秽未尽；每次便后用半包卫生纸，仍疑不洁；明知门窗已关而仍不

放心，使之反复关闭；虽提前3小时起床上班，距工作单位不足3公里路程，还不能按时到达，及至上了班又担心家里炉子没封妥，小孩被子未盖好等。如此症状，难于摆脱，不能工作，情绪非常紧张焦虑。舌苔薄腻，脉象弦而微滑。依症分析，此属劳心日久，积成痰浊，痰浊犯胆，以致心虚胆怯，心虑不能自主，胆怯断失常，拟温胆、宁心、镇静、安神为法，宜温胆汤加味治之。处方同前。嗣后，按原方随症增删，共服30剂，强迫症状消失。

例二

【辨证】抑郁愤怒，肝气不舒，肝郁气滞，气滞血瘀所致之两肋胀痛或流窜作痛，呕吐酸水或苦汁，而色黧黑，唇色晦暗，朱砂色掌，肌肤甲错，症瘕积聚，经闭经痛，四肢麻木，局部刺能，怔忡癫狂等症。

香附、郁金、当归、牛膝各15克，川芎、木香各9克，丹参30克，琥珀6克，山楂21克。

【服法】水煎服，日一剂。

【疗效】余××，30岁，一个月前因事受屈，出现失眠头昏，继之少语孤独，情绪低落厌世，见绳欲吊颈，见水欲投河，见刀欲自杀，几次欲触电，如此等等。总欲死亡，但又怕死。诊为强迫症，以中药治疗。据病情分析，属情志抑郁不解，病于肝，肝部气滞，气滞血淤累及于胆，决断失常所致。宜疏肝理气、活血化瘀法。以本方服药一剂，自觉症状减轻，但睡仍差，继服7剂，强迫症状基本消失，睡眠正常。带原方7剂，

回家调理。

病例介绍

与夫人床上床下皆不和

M太太的病例可以用来说明，强迫观念性反应可能支配一个人整个的生命到了什么样的程度，以及将一个人与他人之间积极的关系转变成消极的情形。

下面，让我们听听M太太对强迫观念性反应的叙述：

除非我确实知道房间里的每样东西都已整理妥当，否则我就不能安心而睡得着觉，因此每天早晨一起床，我马上就将房子布置好。在我上床之前，我好像疯了一样不把每一件东西弄得服贴了便不肯停止，但是，只要我早晨一起床，我又想出千百件事情非做好不可。我心里知道有些事情简直荒唐好笑，可是不去做又总是觉得没有着落一样，除非做好，才感到好过一点，因为我受不了知道有些事情需要去做，而却放手不去管它们。有件事我从来没有对人说过，有一次，我发现屋里就吊着那么一件肮脏的衬衫，谁想得到，我当天就把它洗好、晾干和烫好了。我当然觉得为一件衬衫而专门花费那么多的时间未免太傻，可是叫我不去想它又做不到。假如不去洗好它的话，那一天我一定整日为那件衬衫而心神不安。

最让我伤脑筋的是关于性方面的事情。我的丈夫

好像什么时候都需要它，而且他总是在不可能的时候提出要求，因为我有许许多多的工作要做。晚上，我已经疲倦，而且我们两个人睡觉的时间又不相同。我老是有千千万万的事情要做，而他却准备好要睡觉了。当然，我喜欢在事前能够从从容容的。我想我们两个人都应该先洗过澡，而且床上也应该换上一条干净的床单。然而，他却大发雷霆地怒吼“去你的！”然后就整天生着闷气。他简直就像是一个大孩子。在上个月，他一直就没有再讲到性方面的任何事情，因此我猜疑他在外面可能另结了新欢。我的疑心越来越重，有一两次我想随后跟踪他，但是，因为房子小孩都需要照顾和整理，因此我脱不出身来。

准备离她睡猪栏

而 M 先生是这样说的：

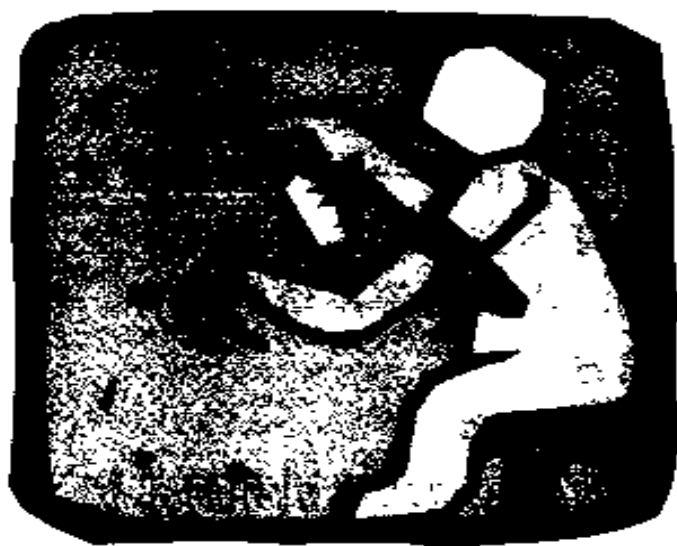
我太太的行为真不可思议，有时候整夜都不曾合过眼。有一天，我清晨 4 点的时候醒来，却听到她在楼下洗衣服的声音。再看看家里的烟灰皿！这么多年来我就没有见过里面留下来一丁点的烟灰。别以为这是好事，其实是精神上极端不正常的表现。假如有一次我不记得将鞋子放到后门外的话，那么她看我的眼神就好像看见我在手术中断了气一样。因此我有许多次睡在外头，而且一旦不得已回到家里时，我几乎整个人都觉得不自在。她甚至不准家里养狗，因为她说狗是脏兮兮的。过去我习惯请朋友过来吃晚饭，一遇到这种情形，她就会神经

过敏地在他们的四周走来走去，让他们觉得食不下咽。我再不好意思打电话叫他们过来，因为每一次我都听得出他们支吾其词，然后找个借口推辞掉。每当走在街道上的时候她也老是害怕自己身上弄脏。我已经感到精神快要发狂了，可是偏偏无法跟她理喻。只要你一开口，她就干脆与你大吵大闹，而且故意多花一倍的时间大洗特洗的。甚至常常请人来洗刷墙壁，我认为这样刮洗下去的话，早晚房子会倒下来。大约在一星期以前，我就已经告诉她，我再受不了与她生活在一起。我准备要离去，说不定暂时住在猪栏里。



第六章

智能障碍症



病因、临床、诊断、治疗

智能障碍就是智能发育不全，又称精神幼稚症。这是指在胚胎期或出生以后，由于各种原因造成中枢神经系统发育障碍，临床上以认知能力（思考）有缺陷、以致于生活习惯、玩耍、语言、社会性等不如常人为主要特征的一组疾病。

病因

【病因和病理】本组疾病复杂，其病理表现也各不相同。概括起来可分为下列几个方面。

一、出生前的原因

母亲在妊娠早期罹患某些病毒感染、过敏性疾患、妊娠期放射线的照射、妊娠毒血症以及其他全身疾病，都可能影响胎儿的发育，一方面直接造成脑发育障碍，产生皮质细胞发育不完善，脑回分化不全；另一方面也影响骨骼、血管、内分泌等系统的发育，这些，反过来又影响了脑的发育。

二、出生后的原因

难产、产钳助娩、负压吸引和脐带绕颈等，常产生头颅的机械压迫和窒息，影响了脑发育。有时候，婴幼儿期高热、脑炎、脑膜炎以及头颅外伤，也可能影响大

脑发育。病理检查可见大脑萎缩、脑血管血栓形成、皮质细胞脂肪变性、神经纤维断裂、髓鞘脱落、脑软化等。原发性癫痫患儿反复之癫痫发作，致长期脑组织缺氧，也阻碍了大脑的发育。

三、遗传及代谢障碍

已经证明某些类型的智能发育不全与遗传及氨基酸或糖代谢障碍有关。如近亲结婚，其子女容易发生智能发育不全。结节硬化症（特点是患者有癫痫发作、面部皮脂腺瘤和智能发育不全）患者家属中往往同时有数人发病。苯丙酮酸尿症患者的父母，也常常有苯丙氨酸代谢障碍，家族性黑矇性痴呆是脂肪代谢（神经节苷脂）障碍所致。伸舌样痴呆患者的第 21 对染色体常是三倍体。另外，性染色体的变异，如超雌（XXX）嵌合型（XY/XY）、13 至 15 或 17 至 18 组常染色体的移位或三倍体都会产生特殊类型的智能发育不全。

临床

【临床表现】智能发育不全患者的生长发育往往是迟缓的，抬头、凝视、坐、爬、立、说话等均较同年龄儿童迟缓。但有的患者开始时很正常，以后逐渐出现智能减退。按智能缺损的程度，可分为白痴、痴愚和愚鲁。白痴的智能缺损极为严重，他们不能学会讲话，只能以简单的音调来表示喜悦、愤怒或需求，不能独自生活，不知逃避和防御危险，躯体的生长明显迟缓，常伴有其他器官的先天性缺损，如不加照料往往在婴儿期夭

第二性征不全等。

诊断

应收集详细而完整的客观材料，（包括学习和工作记录），如在病史中发现一个儿童的记忆、计算、理解等能力较同龄儿童为差，则需进一步作详细的精神检查和体格检查。如发现患儿的智能确实很差，则不难诊断本病。对那些有明显遗传背景的或躯体方而出现病现缺陷的患者，可进一步作内分泌检查、氨基酸和糖代谢检查，或作周围血象中染色体检查，有助于明确病因。例如苯丙酮酸尿症患者的小便与三氯化铁溶液呈阳性显色反应，因此可用小便三氯化铁定性试验来协助诊断。

过去，资本主义国家往往用“智力测验”的方法来判断是否有智能缺损以及智能缺损的程度如何，我们认为这是机械唯物主义的方法，甚不可靠。必须强调指出，在诊断智能发育不全时，应该避免两种倾向。一种是由于父母的偏爱，把明明是智能发育低下的孩子，说成完全正常；另一种是把那些因为缺乏社会实践，而对某些事物无知的人们，误认为智能发育不全。

治疗

尽可能地明确病因，以便进行各种针对性治疗。如对甲状腺功能低下患儿投以甲状腺素；对某些阻塞性脑积水患儿可作针刺、手术治疗。针刺治疗对某些患儿能取得一定效果。取穴：（1）大椎、安眠 2、足三里。

(2) 哑门、安眠 1、内关、备用穴：肾俞、副哑门（三、四颈椎棘突旁开 0.5 寸）。方法：每日一次，两组交替，强刺激，10 天为一疗程，休息 3 至 4 天后可重复治疗。耳针疗法：取神门、皮质下、肾、脑点、枕等耳穴：感染。刺血疗法，主穴，每日一次，每次 2～3 穴（双耳取穴），20 次为一疗程，注意消毒，防止耳廓中冲，天枢。配穴：涌泉、劳宫。方法：三棱针直刺皮下一分深，放出 4 至 5 滴血，主配穴隔天放血一次。药物方面，可用脑磷脂口服，4 克，每日 3 次。可使部分患者的智能发育有所改善。对有癫痫发作者，应予抗癫痫治疗，以免智能缺损加重。对不安定型患儿，可给小剂量氯丙嗪、泰尔登等安定药，以防伤人毁物 and 自伤。发生嫁接性精神病时，应予以针刺或安定药治疗；一般而言，这类嫁接性精神病病程短暂，经治疗后症状迅速缓解。

我们不能一成不变地看待智能发育不全的儿童，要对他们进行耐心细致的训练和教育，合理安排工作，使他们逐步掌握一定的劳动技能，从而使智能得到发展。智能缺损较重者，应多加照料，以防意外和感染。

预防常识

智障的种类很多，但预防的办法只有一个，那就是及早由医师诊断是否会遗传，让小儿科和神经科的专门医生为你提供意见，查明原因，再决定是否继续生

产。若为了怕受人讥笑，而严守秘密，对孩子和父母的危害将更大。

除此之外，首先要注意孕期卫生，怀孕时尽量不要感染病毒性疾病或服食荷尔蒙剂，多注意营养；防止各种可能不利于胎儿的有害因素。若有难产等现象，分娩时要注意避免产伤，应找一设备完善的医院，以免造成不幸。

孩子的养育问题也是父母该深思的重点，预防和治疗少年期的各种疾病是极端重要的，一旦发觉儿童有轻微的智障现象，就要积极找出原因。检查出生的智障儿，究竟是否为遗传性，若有外因性可能，也不可立即断定其为外因性。例如怀孕时孕吐的情况严重，恰好又生出智障儿，这不一定是真正的原因，因为有许多孕吐严重的孕妇，生出的孩子一样很健全。

无论是遗传性或非遗传性的智障儿，他们并非只是智能发展较慢，身体也有许多毛病要多加注意。患有苯丙酮酸尿症的智障儿，若能经常检查尿及血液，即能预防另外的不幸，所以，尽快寻找专门医师检查较安全。

由于染色体异常，也会产生智障儿，所以在这种情形下，不只孩子须接受染色体检查，其父母、近亲也同样要受检。

当然也有许多智障无法查明原因，只有将之归为内因性，因为它有多种原因皆属可能性，但这大多属于劣性遗传。

虽然在现代医学上还没有绝对的方法，保证不会

生智障儿，但我们仍希望能减少这种不幸的发生。如果婚前能多考虑，避免近亲结婚，就能减少劣性遗传的智障儿出生。根据调查有 35% 的苯丙酮酸尿患者，都是由表兄妹结婚所造成的。

有些人认为，父母若非常优秀，则孩子的智能也会好。但实际上仍无法防止他们生出智能不足儿，因为这和父母的智力无关，例如有许多苯丙酮酸尿症的患者，父母皆非常优秀；而智能较差父母所生的孩子，很少是严重的智障儿，大都是情况较轻的智能不足。

当然，最好是你的结婚对象的亲友中没有智障者的先例。

近亲中若有遗传性智障者，可计算出可能生畸型儿的比例。例如生出一患苯丙酮酸尿症的婴儿时，在第二胎生产中，25% 也会生出苯丙酮酸尿症患者，所以父母要能早早察觉，在生了智障儿时找出他异常之处，趁早将他送医院治疗。

婚后还要尽量避免高龄生产，因为染色体异常的蒙古症以及脑性小儿麻痹，大都产自年龄较大的母亲。

何谓痴呆症

痴呆症，是指人在清醒的意识状态下，因某些原因而致使智慧能力丧失的一种疾病，亦即记忆力、判断力、抽象思考力、推理能力等迟钝甚至完全丧失的一种疾病。这是由于器质病变而引起的精神障碍。

痴呆症虽然各种年龄都可能发生，但以老人居多，可以说是最常见、较严重的一种老人病。据欧美社区的调查资料显示，65岁以上的人有4%为器质性的痴呆，10%有进行性智能减退，但仍能在社区中活动。国内65岁以上的老人有7.4%有器质性脑症候群，城市居民有5.7%有认知障碍，农村65岁以上老人仅有2.7%患器质性脑症候群。

老人中发生认知障碍或痴呆症状者，约10%~25%，可以找到可能治疗的原因，经适当治疗可以恢复或获得重大的改善。

不幸的是，大部分引起痴呆的原因，目前尚不很清楚，而且既无治疗良方亦无法预防——其实也很难预防其发生。其中约1/2至2/3的病人是脑皮质退化性疾病，约10%至15%是血管性失智症，而约5%的病因是可以治疗的。

痴呆症病人的病程多数缓慢进展。早期可有类似

神经衰弱以及感情迟钝、自制力减弱等现象，一小部分病人可以发生忧郁或躁狂。如出现幻觉和妄想，通常是片断的，持续短暂。以后则出现明显的、多少具有一定特征性的精神症状，主要可分为三类：

一、意识模糊 多在脑部病变急剧发展时出现，一般较少见，轻者表现嗜睡，对周围反应迟钝，注意力不集中，情绪不稳。亦可出现昏睡、朦胧、谵妄或昏迷。

二、记忆障碍 首先是近事遗忘，以后遗忘程度日益加重，可伴有欣快、虚构等现象。

三、慢性痴呆 主要是记忆、计算、理解、判断能力的减退，伴有构思困难，激惹性增高，并常有大小便失禁。

一般来说，当出现意识模糊、遗忘或痴呆时，结合病史和体格检查，脑部器质性病变的诊断并不困难。但在疾病的早期阶段，尤其是出现幻觉、妄想、兴奋、消极、自杀而类似躁狂症、忧郁症、精神分裂症和神经官能症现象时，往往易被误诊。如脑肿瘤患者可能以精神紊乱作为他的最早症状，或以精神症状为其临床症象中的突出表现，且这些病人的定位体征此时常很少，诊断就比较困难。脑的某些部位的病变引起精神症状也可有一些特点，如额叶病变可在早期出现呆滞，对周围反应迟钝，注意力涣散，缺乏主动性，性格变得激动、粗暴或出现愚蠢欣快的情绪，也可有精神运动性兴奋。颞叶病变常有发作性精神障碍，出现各种恐怖性幻视和感知综

合障碍，发作后往往有不同程度的记忆障碍。要进一步查明脑部器质性病变的性质和病变的部位时，单单依赖精神病症状的检查是不够的，必须进行详细的体格检查和神经系统检查，必要时还要进行腰椎穿刺、脑电图以及颅脑 X 线检查，然后依据病变的不同性质和程度，再进行适当的治疗。

老年性痴呆症

一般而言，男子 65 岁以后，女子 55 岁以后，开始逐渐衰老，进入老年期。所谓老年性痴呆，系指老年期发生的慢性进行性智能缺损，并有脑组织特征性病理改变的一种精神病。本病不包括老年期发生的其它类型的精神病。

据上海市精神病防治院的统计，本病占住院病人数的 1.5%~2.5%。男女性别无显著差异。

【病理】一般认为，大脑组织变性可能与本病的发生有关。此外，一些外界因素，如感染、中毒、精神因素亦可能是发病的有关因素。值得注意的是，本病患者的精神症状和大脑病变的严重程度不一定相一致。有些患者的精神症状很轻、而脑部器质性改变却很严重；相反，有些精神症状很明显的患者，只有轻度的脑部器质性改变。有人更发现一些精神正常的老年人，可出现与老年性痴呆同样的脑组织改变。这种情况可能是由于大脑代偿功能的作用。

至不能正确回答自己姓名、年龄，称自己的女儿为“阿姐”，称自己的太太为“外甥”。最后，连最简单的计算也错误百出，严重丧失思考和理解能力。患者口齿不清，发音含糊，言语变得杂乱无章。行为显得幼稚而愚蠢，喜把废纸、杂物视为珍贵物品小心收藏起来。病程后期患者终日卧床，大小便不能自理。这时常易并发感染、营养不良或电解质紊乱而产生谵妄状态，谵妄之后常使痴呆加重。

老年性痴呆患者常有其他器官衰老的表现，如角膜的老年环、白内障、皮肤老年斑、老年性重听等。神经系统方面，可见步态不稳、肌张力增高、老年性震颤、瞳孔对光反应迟钝等，偶见失语症。

老年性痴呆患者的脑电图无特征性改变，往往可见弥漫性节律紊乱，二半球散见慢波。气脑造影可见脑萎缩。脑脊液检查，除偶见轻度蛋白增高外，余无特殊变化。

【诊断和鉴别诊断】根据在老年期发病、缓慢进行性的体力和智力衰退等特征，不难诊断本病。但应与下列疾病相鉴别：

一、老年期发生的中毒性或症状性精神病。本病因急性躯体疾病而发病，病前没有性格、情绪方面的改变，没有持久性的智能缺损，精神症状常呈谵妄或其它类型的意识障碍，与躯体疾病的严重性相平行，随着躯体疾病的减轻，精神症状也逐渐好转。

二、动脉硬化性精神病（详见后文）。

三、额叶肿瘤引起的痴呆往往出现有定位意义的神经系体征。脑脊液检查可见蛋白质增多、压力增高。必要时作气脑造影和脑电图检查。

治疗

首先要注意生活上的照顾，防止因大小便失禁及长期卧床所引起的褥疮、感染。要防止跌倒而发生骨折。不要让患者外出乱走，以免迷失方向找不到家门。对有吸烟习惯的患者应注意照管，防止乱丢烟头而引起失火。

西药治疗

可试服谷氨酸、氯酯酸等药。如兴奋吵闹、行为紊乱时，可给服安定药物，但剂量不宜过大以免引起昏睡和虚脱。

中药治疗

【处方一】益气补肾宁心。党参9克，黄芪9克，生熟地各9克，山萸肉4.5克，茯苓9克，淮山药15克，远志9克，枣仁9克，龙骨9克，龟板30克，泽泻9克，五味子3克。

【服法】每日一剂，水煎服。服用两至三个月后改服附桂八味丸和安神定志丸，一日三次，每次9克。

【处方二】猪心一个，朱砂7.2克一起放入锅中煮熟，熟后即可食用。

利用“同物同治”的作用，以猪心补足心脏所需。朱砂又名硫化水银，是一种矿物药，亦为精神安定

症例治验

【辨证】肾虚精亏，精血耗损，髓海空虚，心神失养。

【治法】健脾补肾，填精益髓，佐以活血通窍。

熟地黄 15 克，枸杞子 12 克，菟丝子 9 克，鹿角霜 9 克，巴戟天 9 克，北黄芪 15 克，秦当归 9 克，紫丹参 9 克，漂白术 9 克，川芎片 7.5 克，山萸肉 9 克，五味子 9 克。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】庄××，男，54岁，教师。患者因长期患虑，用脑过度，暗耗精血，又后天失充养，致头晕眼花，乏力，记忆力渐减，精神疲倦，嗜睡，性情急躁，且行动逐渐缓慢，表情呆板，寡言少语，齿落发脱落。近半年来，时而傻笑，或胡言乱语，喃喃不休，吐字不精，行动迟缓，不欲食而不知饥，发为痴呆病，二便不能自理。舌质暗淡，脉细弱。脉证合参，此为未老先衰，髓海空虚、神失所养所致。肾藏精，精生髓，脑为髓海；脾为后天之本，气血生化之源，故脾肾亏虚，则精血不足，髓海空虚，脑神失其充养而见痴呆。

方用熟地、枸杞、山萸补肾填精益髓；鹿角霜、巴戟天、菟丝子补肾助阳，以生阴精；白术健脾益气；黄芪、当归调补气血；川芎、丹参通窍活血。

服 15 剂，病情略有改善。唯不欲食而不知饥，二便失禁尤为突出。上方去川芎、五味子，加谷芽 30

克，益智仁 12 克。后再加人参、云苓等健脾之品，守方加减百余剂，诸症基本消失。一年后复访，已能授课。

动脉硬化性痴呆症

本病称为血管性痴呆症、动脉硬化性精神病。其病理变化可分三大类：大小血管栓塞或血栓所造成的多梗塞；微小血管血栓所造成的深部腔隙（陷窝）梗塞；以脑室周围脱髓鞘病变为主的皮质下动脉硬化性脑症。最重要的病因可能是长期血管受到高血压的破坏所致。

大多数病人由于脑内血管栓塞或血管破裂，出现一个或数个大小不一的软化灶（缺血性或出血性），软化灶位于大脑的表面或深部。软化灶周围出现神经胶质细胞和毛细血管增生。另外还可见大脑皮层神经细胞变性和神经细胞数量减少。上述病理改变，可见于脑的其它部位，如基底节、小脑、脑干等。

【临床表现】临床上可能有多次中风病史。

前驱症状：可有头痛、头晕、自身感觉不良、易疲倦、手足发麻、四肢瞬息无力，亦可见短暂的失语和失用症。往往伴有不同程度的睡眠障碍。

精神症状：早期可见近事记忆逐渐减退，患者常忘记人名、地名、物品，工作能力显见减退。患者情绪不稳，激惹性增高，或出现爆发性哭笑。常有恐惧、焦虑、多疑、忧郁等症状。可反复出现发作性的意识模

糊，也可以有脑血管痉挛或出血引起的脑血管意外发作和癫痫大发作。开始时情感反应还较正常，能认识自己所犯的错误，能体会自己病态的严重性，随着病情进展，患者记忆力越来越差，虽经自己很大努力亦难于完成各项任务，并可出现虚构错构的表现。惟须注意，此种记忆障碍具有明显的波动性，常常出人意外地发现记忆力突然恢复。患者可因幻觉、猜疑而发生吵闹、冲动，最后陷入痴呆状态。

体征：大多数患者可见不同程度的神经系统体征，包括动作不稳、肢体末梢震颤、麻木、瞳孔缩小、对光反应迟钝。有脑血管意外或癫痫大发作的病人，也可遗留偏瘫，单瘫、失语、失用，假性延髓麻痹等。

【诊断和鉴别诊断】诊断动脉硬化性精神病时应掌握下列几个特点，以免与其它老年期精神障碍相混淆。

一、高血压动脉硬化的症状和体征。但周围动脉（包括眼底动脉）的硬化不一定伴有脑动脉硬化，反之亦然。

二、精神症状可有一定的波动性，如有时记忆障碍较明显，有时可见意外的记忆力部分恢复。

三、情感不稳定、易激动，有时出现爆发性哭笑。

四、即使在疾病进展期，还存在部分自知力。

五、早期智能改变尚不明显时，即可找到一些神经系统阳性体征。

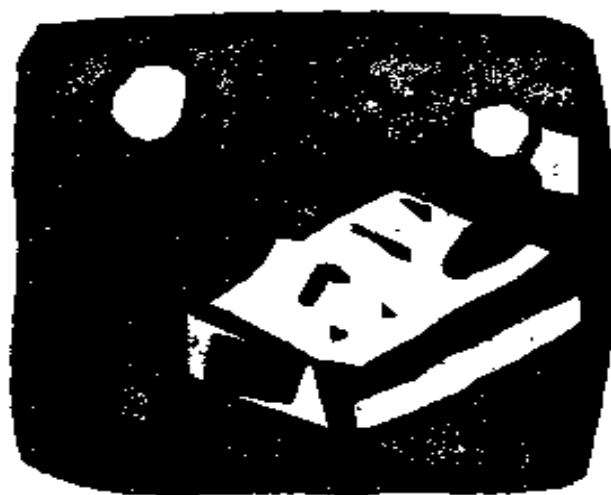
治疗

同老年性痴呆。可针对高血压和动脉硬化进行治疗。另外，可试用 75% 复方当归注射液（成分：当归、川芎、红花）穴位注射。方法：取复方当归注射液 4 毫升，分注于双侧肾俞穴，隔日一次。配穴：足三里、三阴交、合谷。部分早期动脉硬化性精神病患者经治疗后精神症状明显好转，可参加一般的社会活动。



第八章

忧郁性精神病



忧郁性精神病属于情感性精神病的一类，情感性精神病还包括有躁狂忧郁症以及更年期忧郁症等型。现在先谈谈躁狂忧郁症。

躁狂忧郁症

轻度躁郁病的病人由于精力旺盛、行动积极、待人热心亲切、言语流利、办事效率高，因此虽然说他在基本上有过剩的驱策力，但是表面成就与一般表现往往反而较为良好，因此本人以及他身边的人都不会感到有异，反面对这种情形会觉得十分满意。

严重躁郁症具有反复发作、自行缓解的倾向，缓解期精神活动的完整性始终保持良好。极少数的病人可能迁延，很久不愈。

本病可仅有躁狂状态或忧郁状态的发作，也可两者兼有，还可两者间歇交替，循环发作。躁狂状态和忧郁状态是相反的情感障碍，但从本质上看，是同一疾病的两种不同表现。

【病因病理】本病病因目前尚不很清楚。中医认为多因忧思太过，志愿不遂，郁闷不舒，耗伤心脾，以致血虚、肝阴不足；或暴怒愤郁，肝胆气逆，郁而化火，煎熬成痰，上蒙清窍；或因过喜伤心及胃热上蒸，扰乱神明所致。所以本病的发生与气、火、痰的关系最密切。

此外，癫狂的发生还与先天禀赋有关，若禀赋充足，体质强壮，阴平阳秘，虽受精神因素的刺激也只

是短暂的情志失畅。反之禀赋素虚，肾气不足，复因惊骇悲恐，意志不遂等的影响，则可引起阴阳失调而发病。禀赋不足而发病者往往具有家族遗传性，其家族可有类似的病史。

现代精神医学认为：

一、间脑功能紊乱

间脑肿瘤可表现有典型“急性躁狂症”，甚至躁狂忧郁相交替的精神症状。有人发现刺激下丘脑可引起情绪欣快和意念飘忽。因此，间脑，特别是下丘脑的功能紊乱也许和躁狂忧郁症的情感障碍有密切的关系。

二、单胺物质代谢紊乱

有人认为忧郁症的发生也许和中枢神经内 5-羟色胺、去甲肾上腺素等（以间脑及边缘系统含量最高）单胺物质含量不足有关。单胺氧化酶抑制剂和丙咪嗪等抗忧郁药物都能通过不同的方式增加神经组织的单胺物质，临床上也可见由应用利血平而促发的忧郁症。这一观点还在探讨中，很可能单胺物质代谢紊乱只是极为复杂的神经生化变化的一部分。

本病迄今尚未发现脑部有特殊的病理改变。

【临床表现】

一、躁狂症

最基本的症状是病态的情绪高涨，一种持久而强烈的喜悦和兴奋。自身感觉特别好，病人兴致勃勃，谈笑风生，插科打诨，可使接触他的人也感到很轻松（即所谓“感应性欢乐”）。但病人的自制能力大为减弱，一

件不称心的小事可使他暴跳如雷，过了片刻便为高涨的基本情绪所淹没，忿怒，骂骂不休，缺乏欢乐的感情。

联想显著加速，因而口若悬河，言语滔滔不绝，异常健谈。由于病人注意力浮动，指导思维过程的观念随着周围的事物时时改变，往往一个话题未毕，即跳到另一话题，（意念飘忽），甚至前后语句之间存在音韵和字义上的联系（音联、意联）。不少病人把联想加速解释成“变聪明了”或生动地描写成“舌头和思想在赛跑”。

动作增多也是一个特征。病人天不亮就起身，开始极为忙碌的一天，虽然睡眠时间不足，精力却充沛逾常。他可能奔走于亲友同事之间，也可能走访报社或上级机关，提出一些未经深思熟虑的建议。病人往往满怀情心地去实行一些好高骛远的计划，结果总是见异思迁，有头无尾。且一反平时节俭的习惯，购买许多不必要的贵重物品，慷慨赠人也是常有的。严重的病人，行为可以陷于紊乱，通宵不眠，三跑二跳，又唱又叫，甚至毁物伤人。

幻觉和妄想通常不存在，但高涨的情绪往往带来过高的自我评价。病人自诩有过人的体力、才干和学问。近于一种自吹自擂而不是固定的或荒谬的妄想。

躯体方面通常面色红润，容光焕发。入睡困难和早醒可能都有。食欲无明显减退，性欲常亢进。严重兴奋躁动的病人可以体重锐减、失水，甚至并发感染。

二、忧郁症

情感忧郁是最基本的症状，典型的病人伴有自责自

罪和联想、动作的迟缓。病人常常满脸愁容，比平时苍老憔悴。对任何事物都兴致索然，忧念丛生，悲观失望，甚至消极厌世。有些病人自觉变得麻木不仁，不能体会欢乐，对朋友对亲人丧失了原有的热切感情。较深的忧郁情绪总是带来有罪感。迟钝的病人担心自己丧失工作能力，成为家庭和社会的累赘，或者已无可挽回地成了废物、寄生虫。有些病人把过去的缺点错误无限上纲，夸大成不可宽恕的大罪（罪恶妄想），拒绝进食或只吃白饭，因为觉得自己“不配吃”。在罪恶妄想的基础上可以产生关系观念和被迫害妄想，例如认为亲属厌恶他，人们议论他，别人开会认为是开对他判罪的会等等。有些病人仅仅根据腹部不适、食欲不振或便秘而自疑患了癌症、肠阻塞、内脏溃烂（疑病妄想）等。

言语和动作的抑制可能达到接近木僵的程度。但有些病人相反，焦虑恐惧，痛苦悲号，激动自伤，言语动作都增多（激动型忧郁症）。消极病人如无抑制症状时自杀的危险最大，因为他拟定周密计划、采取行动都没有困难。消极病人无故突然变得开朗，必须想到伪装可能，往往这是即将发生消极行为的预兆。

躯体症状相当多：体重显著下降，消化系统的活动减退，因而口干、食欲不振、便秘；心率稍速、血压偏高，提示交感神经活动的亢进。

睡眠障碍以早醒最典型，也可有睡浅和入睡困难。

忧郁症症状有昼重夜轻的特点。曾见一女病人清

状态，脑动脉硬化性精神病等。

心因性反应症的忧郁型和本病的忧郁症可能很难鉴别。一般说来，前者有明显的精神因素和与之密切联系的思维内容，怨天尤人多于自责自罪，言语动作不减少，无昼重夜轻现象（可能昼轻夜重），愉快的场合可以使之暂时好转。

精神分裂症也可能伴有躁狂忧郁症的症状。如果病人同时存在思维障碍、较多的幻觉、行为怪异或整个精神活动缺乏协调性则应诊断为精神分裂症。

有人发现某些周期性的乏力、食欲不振、显著的较固定的述诉而忧郁情绪不突出的病人，经内外科反复检查无结论，对症治疗无效，但可用治忧郁症的方法治愈。因此主张这类疾病是一种“不典型的忧郁症”。这类病人可能有躁狂忧郁症的家族史，过去或未来可有典型忧郁症的发作。

西药治疗

一、躁狂症

氯丙嗪控制兴奋躁动效果良好，用法及注意事项参见“精神分裂症”。异丙嗪也有安定作用，副作用很少，安全，可以合并应用以避免氯丙嗪用量过大。合并使用时异丙嗪的剂量约每日 300 至 400 毫克。

泰尔登有时作用显著，可以单独或合并使用（参见“精神分裂症”）。

氟哌啶醇是一种非酚噻嗪类的安定药，有人报道

对躁症的疗效胜于氯丙嗪（用法参见“精神分裂症”）。

碳酸锂常用于一些顽固病例，单独或与其他安定药合并使用都可以。开始剂量 250 毫克，日服 3 次，可渐渐加到 1500 ~ 2000 毫克/日，甚至 3000 毫克/日。症状控制后的维持量一般在 750 ~ 1500 毫克/日之间。该药有头昏、恶心、呕吐、腹痛、腹泻等副作用。积蓄中毒时，可出现脑病症群，如意识模糊、明显震颤、反射亢进、癫痫发作和局限性神经系阳性体征。再进一步就昏迷、休克和出现肾机能损害。积蓄中毒的症状往往出现于病情好转之时，因此用药时必须严密观察，及时减量。钠盐能促进锂经肾排泄，用药期间应保持不少于正常的食盐摄入量，每周以停药一天较安全。脑病症状一旦出现，必须立即停药，给予支持疗法，适当补充生理盐水；静脉注射氨茶碱有促锂排泄的作用。心、肾疾病，电解质紊乱者忌用。

躁狂病人不少表现阳亢火盛之象，如面红目赤、舌苔黄燥、脉洪数、尿短、大便干结等。治以清热泻火之中药可能奏效。方用龙胆泻肝汤随症加减变化。

针刺疗法加低压直流脉冲电强冲击，常能促使疾病迅速好转。取穴及具体方法见“精神分裂症”。

二、忧郁症

丙咪嗪（Imipramine）为首选之抗忧郁药。开始每次 25 毫克，日服 3 次，缓缓增加，一周后加到每日 150 ~ 200 毫克。疗效的出现多在达上述剂量后 2 ~ 3

躁狂忧郁循环发作的处理比较困难，需要安定药、抗忧郁药两类药物适当而有变化地配合。碳酸锂对这类病人有可能奏效。

躁狂忧郁症维持治疗的久暂应该根据病人的具体情况确定，不能强求一律。如果用药剂量已减到很小，病情仍很稳定，可试行停药。

中药治疗

根据中医辨证的原则，认为躁狂症是属于狂的范畴，而忧郁症则属于癫的范畴。一般认为狂属阳症，癫属阴症。

躁狂症多属实，为重阳之病，主于痰火、淤血，治宜降其火，或下其痰，或化其淤血，后期应予滋养心肝阴液，兼清虚火。抑郁症多属虚，为重阴之病，主于气与痰，治宜以解郁化痰、宁心安神、补养气血为主要治则。

一、躁狂症

(一) 痰火扰心

起病急，常先有情绪急躁，头痛失眠，两目怒视，面红目赤，突然狂暴无知，情绪高涨，言语杂乱，逾垣上屋，气力逾常，骂詈叫号，不避亲疏，或毁物伤人，或哭笑无常，登高而歌，弃衣面走，渴喜冷饮，便秘尿赤，不食不眠，舌质红绛，苔多黄腻，脉弦滑数。治宜泻火逐痰，镇心安神。用大承气汤、泻心汤合礞石滚痰丸。

大黄 15 克，黄连 9 克，黄芩 9 克，生铁落 30 克，厚朴 9 克，枳实 9 克，礞石滚痰丸 6 克（包）。水煎服，每天一剂。

单方验方：

1、黄芩花，取花蕾及叶，晒干研粉。成人每日服 1.5~6 克，饭前一次服下。10~20 天为一疗程。

2、巴豆霜 1~3 克，分两次间隔半小时服完。10 次为一疗程，一般服用两个疗程，第一疗程隔日一次，第二疗程隔两日一次。

（二）阴虚火旺

躁狂日久，病势较缓，精神疲惫，时而躁狂，情绪焦虑、紧张，多言善惊，恐惧而不稳，烦躁不眠，形瘦面红，五心烦热，舌质红，少苔或无苔，脉细数。治宜滋阴降火，安神定志，用二阴煎合定志丸加减。

生地 30 克，麦冬 21 克，酸枣仁 21 克，玄参 21 克，黄连 9 克，灯心草 20 根，茯神 9 克，菖蒲 9 克，远志 9 克，琥珀 3 克（冲），甘草 9 克。水煎服，每天一剂。

症例治验

例一

【辨证】积郁成痰，蒙蔽清窍。

【治法】豁痰开窍，疏肝解郁，养血安神，终以益脾善后。

竹茹 9 克，枳实 9 克，茯苓 12 克，法夏 9 克，陈皮 9 克，丹参 12 克，枣仁 6 克，生龙齿 15 克，夜交

藤9克，甘草3克。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】刘××，女，24岁，因失恋刺激，积郁成痰蒙蔽清窍，致为癫狂。患者身高形瘦，面色红赤，时疑时怯，厌恶见人，纳差口干，寐少梦多，大便不爽，小溲正常，经期错乱。诊脉弦长，舌质淡红，苔黄微腻，证脉合参，此忧思抑郁，激动肝阳，木火生痰，阻蔽肝胆包络，清明之气为邪浊所蒙之癫狂症。处以上方服之，药后头脑感觉轻松，纳食、睡眠好转，能陈述病情，舌脉同前。原方加磁石重镇祛痰，再进5剂，病无进展。因思肝喜条达，不扬则抑，豁痰开窍是治其标，疏肝解郁才是治本，乃易味道遥散：丹皮9克，梔仁9克，柴胡9克，当归9克，白芍12克，茯苓9克，白术9克，丹参12克，生龙齿15克，夜交藤9克，合欢花4.5克，甘草3克，进5剂。症状减半，效不更方，守原方出人治疗三个月后，诸症消失，回厂任教职，经友人介绍再交新友，心情顺畅，病根脱体。

例二

【辨证】无明显诱因的精神失常。

【治法】滋水，疏肝解郁。

生、熟地各30克，白芍30克，当归、梔仁、丹皮各15克，柴胡、花粉、茯苓、石菖蒲各9克，薄荷6克，生姜3片。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】欧阳××，女，23岁。仪容不整洁，面

黄垢青黯，问之不答，答非所问，坐立不安，企图外跑，目视四野，欲寻男性则欢，不知羞耻，不认亲疏，见男性而紧抱。诊视不合作，经强迫切诊，脉象沉弦而劲，启口视舌尖赤、苔薄白而黄，沉乃阴脉，弦属于肝，相火寄居，古人谓“肝胆火炽，欲男不得亦癡”。治以“逍遥散”加减。

逍遥散乃血虚肝燥之良剂，嫌白术固中故去之，加二地、玄参滋水，合丹、梔清心肾，水旺则火不炽；花粉古人谓汲黄泉水最深，使水达上源更速；佐郁金善解诸郁；菖蒲芳香开窍。

因药符症，故服3剂不外跑，安眠知羞，现已如常人，遂结合精神病之心理治疗，一再解释以往系病态所为，不应有任何顾虑。将原方加白术与之，继服10剂而康复，结婚生子，至今已15年，未再复发。

二、忧郁症

（一）肝气郁结

精神抑郁，情绪不安，善叹息，胸肋胀痛，痛无定处，脘闷噎气，腹胀纳呆，或呕吐，大便失常，女子月经不行，苔薄，脉弦。治宜疏肝理气解郁，用柴胡疏肝散加减。

柴胡9克，枳壳9克，白芍9克，川芎9克，香附9克，神曲9克，甘草9克，水煎服，每日一剂，同时服用越鞠丸6克。

（二）忧怒伤神

精神恍惚，心神不宁，悲忧善哭，舌质淡，苔薄

白，脉弦细。治宜养心安神。用甘麦大枣汤合养心汤加减。

淮小麦 60 克，党参 21 克，黄芪 21 克，茯神 15 克，远志 9 克，酸枣仁 15 克，柏子仁 9 克，五味子 15 克，当归 9 克，白芍 9 克，川芎 9 克，肉桂 6 克，大枣 5 个，甘草 9 克，水煎服，每天一剂。

【按摩疗法】

点按揉人中、印堂、百合、大椎、身柱、心俞、膈俞、神门、内关、后溪、足三里、三阴交，每穴约半分钟，每天 1 ~ 2 次。若痰多胸闷者加按揉中脘、丰隆；心烦不宁加按揉巨阙；说唱、打闹者加按揉涌泉。

【食疗方法】

① 青麦苗适量，桔子皮 15 克，苦菜 9 克，大枣 10 枚。

四味共煮，取汁，加白糖，温服，每日一剂。用于躁狂症。

② 木耳 30 克，豆腐 3 块，胡桃（去皮）7 枚。

用水炖，连汤带渣服之。每日一剂，用于躁狂症。

③ 桔子皮 9 克，生姜 9 克，大枣 10 枚，干姜 3 克，龙眼肉 15 克，炒枣仁 9 克，小麦粒 9 克。

水煎服，每日一剂，用于抑郁症。

④ 羊脑子一个，用砂锅加白水煮熟，蘸适量蜂蜜热吃，一次吃完。每隔两日吃一个，连服 11 个，用于抑郁症。

⑤ 白鸽子两只，将鸽子剖开取其心，发作前服用，一次生吃，用于躁狂症。

验方：用小剂量西药（多虑平及阿米替林，每日100～150毫克口服）结合中药龙牡汤（黄芩、郁金、生牡蛎、生龙骨、茯苓、丹参、大黄、芒硝、菖蒲、香附、合欢皮）口服，三个月为一疗程。共治12例隐匿性抑郁症。结果痊愈5例，显著进步5例，进步一例，无效一例，显著率为80.3%。

用滚痰豁窍汤（礞石9克，菖蒲、芒硝、芫花、甘遂、大戟各6克，胆星、竺黄、枳实、竹茹各6～9克，沉香2.1克，生大黄15克，磁石24克，生铁落45克）水煎服。治疗躁狂症230例，痊愈76例，显效59例，有效93例，无效的2例。经对135例痊愈和显效病例进行随访，复发14例，占10.36%。复发后仍以本法治疗，效果亦佳。

用解郁散（陈皮、半夏、枳壳、栀子、红花、香附、菖蒲、苍术、砂仁、苏合香、冰片等）治疗精神病50例（其中抑郁症10例），痊愈16例，显著进步27例，进步6例，无效1例，总有效率90%。

用藜芦配伍枯礞、白芷，加肥肉60克。水煎服，治疗痰涎壅盛的痰狂数例，卓有成效，且未见毒性反应。

病例介绍

女钢琴家跳楼自杀

有一罹患产后精神忧郁病的个案。她原是一位著名的钢琴家，发病住院之后她的忧郁症状逐渐减轻，情绪不安的程度也减少了，几乎可以说跟发病以前的情况相同，仅需服用少量的药物来维持即可，因此医师们决定让她做试验性的外宿，让她跟从未见过的小孩子见个面。整个外出与家人相聚的时间限定为几个小时，并嘱咐她届时必须返院接受继续的观察，病人的家属也都同意接病人回家小聚，病人的丈夫是某企业界的化学家，头脑清晰、慎重，同时对病人的情况十分了解。在病人回家之前，他受到医师再三的叮咛说病人生性敏感，在家时不宜令其独处，必须有家人陪在左右等等。等到她的丈夫开车接她回家中之后，她在三楼的卧室里接过保姆手中的婴儿，整个场面洋溢着一片喜悦的气氛。病人一面十分高兴地谈笑着，一面爱抚着婴儿，但是，突然间，她却穿过走廊直趋阳台上，在人猝不及防的情况下，抱着婴儿跳下楼去。

显然这一个案患的内因性忧郁性精神病，但是她的情形却与一般周期性的个案情形不同，她是在生产之后才发生症状的，而且这也是她初次的发病，并未经过长期的观察，她的诊断也不尽确定。通常在忧郁病的恢复时期中，病人的忧郁症状虽然已经不太明显，但是其

自杀的可能性仍然是很高的。如果医师一开始就诊断出病人患有内因性忧郁病的话，也许不会这么早就给病人试行外宿。不过从另一个角度而言，个案在家属的陪伴之下回家抱抱自己的孩子应该是合情合理的事，我们无法责备医师的判断力欠佳或是医师的决定不当，遗憾的是等到大家发现个案在这个时期中还不宜回家时已经为时太晚了。

更年期忧郁症

这是指初次发病的年龄在更年期，即由中年过渡到老年这段时期所产生的焦虑紧张、忧郁等症状为特征的一种精神病。发病年龄男性通常在 55 ~ 65 岁左右，女性通常在 45 ~ 55 岁左右。此时由于内分泌腺机能减退，妇女亦常在此阶段绝经。

【临床表现】本病可能与内分泌、代谢功能方面的失调有关，精神因素亦常是导致发病的一个因素。本病起病缓慢，开始有失眠、食欲减退、精神疲乏、工作能力减退及一些不确切的述诉，以后逐步发展为焦虑、忧郁、猜疑、疑病等明显症状。

焦虑是本病最普通的一个症状，表现为紧张恐惧、坐立不安、徘徊不定、惶惶不可终日，稍有惊动，即不知所措。

忧郁是本病的主要症状，表现为情绪上的低落，悲观失望，认为自己一切都完了，为此而哭哭啼啼，自责

自罪，常把过去的一些生活琐事重新提起，认为自己这也不对，那也不好，把一些小的缺点说成严重的错误。有的表现为低头认罪，要求组织对他严肃处理，进一步认为自己不配生活在世界上，不配吃饭，因此就产生了拒食和自杀的行为。轻者自拔头发，抓破皮肤，重者跳楼、自缢、撞墙、投河等等，但多数病人常常在事前流露出一些消极的言语，医务人员应引起警惕。

猜疑。患者病前大多表现多疑过敏，遇事多猜测，因而在发病过程中，常常把其日常生活中所碰到的事件联系起来，主观臆断地认为邻居在愚弄她，某某同事在和她作对等等。

疑病。疑病的产生常常是由于一些身体上的不适感，或者在听到别人讲某种病如何危险，结合了自己的症状加以扩大推演，就逐步地形成了疑病妄想，甚至认为自己的各种器官都烂掉了，命在旦夕，感到痛苦不安，生不如死。在这种情况下，亦常常引起自伤、自杀的危险行为。

身体方面，常有植物神经机能失调和内分泌机能减退的表现，如有心率加快或迟缓，四肢发冷，出汗；女病人可有月经失调，闭经。病人可申诉头晕、乏力、全身不适、关节酸痛、食欲不振、便秘或腹泻。面色多显得苍老憔悴，消瘦。

【诊断】根据初次发病年龄在更年期，有焦虑紧张、忧郁疑病等精神症状，结合在更年期出现的植物神经机能和内分泌机能的生理变化，更年期忧郁症即可成

立。但需注意排除器质性疾病，为此应认真进行体格检查、神经系统检查，并进行必要的实验室检查。

防治

对本病患者应认真做好思想工作，及时发现病人可能出现的消极念头，引导病人正确对待与发病有关的精神因素。以焦虑忧郁症状为突出者，可给予泰尔登，开始可用 25 毫克，每日 3 次，以后视情况增加。严重忧郁，有自罪消极等症状时，可以服丙咪嗪，用法参见“躁狂忧郁症”。如有猜疑、紧张不安，亦可酌情应用氯丙嗪。病情轻者可服利眠宁、安定等药物。如植物神经机能失调或内分泌紊乱者，可服谷维素 10 ~ 20 毫克，每日 3 次，若有效可连服 3 ~ 6 个月。

除药物治疗外，亦可根据症状选择穴位进行针刺疗法。

更年期忧郁症可伴有阴虚火旺症候，舌质红绛无苔，脉多细数，这种情况可用滋阴降火的方法治疗，一般可服下列方剂：生地 30 克，玄参 15 克，天麦冬 9 克，石斛 15 克，石菖蒲 9 克，知母 9 克，猪苓 9 克，山萸肉 9 克，淮山药 15 克，泽泻 9 克，丹皮 9 克，黄连 6 克。每日一剂，连用一到一个月；同服大补阴丸，每服 9 克，日服 3 次。阴虚火旺之象消除后停去汤剂，单服药丸巩固，可连服数月。

病例介绍

患妇狂饮醉濒死

有一位妇人自从45岁起就发生一种很奇特的症状，她先是有两三天时间会觉得非常疲倦、背痛而想睡；接着完全丧失体力及做事的意念，只是整天躲在家里；过了四五天之后，又迅速地恢复正常。像这种情形大约每隔一两个月就会发生一次，病人一直以为是得了重感冒，因此只服用了一些感冒药。过了一年多以后，有一次病人的疲状并没有在一星期内好转，反而持续了两个多月，她和丈夫这才发觉她在精神方面有异常，而开始找精神科医师来诊治。此后三年间，病人每年都要发作五六次忧郁症状。症状的表现包括嗜睡、食欲减退，活动量低、极度消沉等，使用抗忧郁病药物对她并没有产生什么效果，而每次病情的好转也是非常突然而迅速的，病人可以一下子就变得十分活跃而开朗。

在她最后一次发作这种反复性忧郁症状期间，有一个晚上她喝下大量的烈酒企图减少自己的苦闷，结果醉倒在地，等到她丈夫深夜应酬回来发现这种情形时，已经是半夜两点了。幸好病人并没有自杀之状，因此情况也不是那么严重。不过病人的丈夫从长期照顾病人的经验中，已经发现病人在忧郁状态中会有极强烈的厌世情绪，因此平时都特别谨慎地预防她自杀。

第九章

精神分裂症



何谓精神分裂症

精神分裂症是最常见的一种精神病，一般占住院精神病人的 60% 至 70%，是医学上的重要课题之一。

本病患者除了精神活动障碍之外，其它脏器多无特殊的病变或机能紊乱，其植物神经系统机能紊乱的情况虽较正常人稍多见一些，但缺乏肯定的诊断意义。

精神分裂症发病形式可分为急性发病及逐渐起病两种。

急性发病可表现为突然的兴奋躁动及行为反常。一些急性发病的病人，如果仔细追问病史，常可发现在明显发病前好几天或几星期内已有些不易引起注意的异常，例如失眠或心神不定等。

部分女病人，特别是年轻的女病人，常在月经来潮前后出现急性发作或精神症状恶化。

逐渐起病的病人常表现为生活懒散、工作与学习的积极性下降，有时会被误认为思想或性格问题。还有的病人有一些身体上不舒服的诉述，最初常被诊断为神经衰弱或其它疾病，经过一段时间的检查治疗，病情不但未好转，反而逐渐暴露出许多怪异的想法，因而被发现有精神病。

目前一般人对精神分裂症的概念多半是认为它是

一种极为严重而治不好的病，一个人只要患上了这种病，就一辈子都是个废人了。由于这种病的发病期多半在青少年到青年期之间，患病期无形中拖得十分漫长，因此给病人的家属带来无尽的困扰，而且大家认为如果让外人知道家里面有这种病人是件极不光采的事。

这种病人的父母亲受到沉重打击的一个主要原因，就是在于社会上一般人对精神分裂症的有色眼光。多年以来，一般人对于精神分裂症的看法，几乎跟对癌症的感受是一样的，总认为患这种病是莫大的不幸。这其中有人相信是命运作弄人，运气不好之故；也有人受到自古以来看法的影响，认为有罪的人才会得这种病，于是想尽办法要把病人藏起来，不让别人发现自己家里有精神分裂症的病人。过去有许多医师为了解病人家属这种心理状态，因此往往不把实情告知病人家属，而把病人的病名改称作神经衰弱、精神官能症或忧郁症等等，希望藉此能避免家属所受到的打击。

近年来，一般人对精神分裂症的看法逐渐有了改变，因此当精神科医师发现病人患有精神分裂症时，通常会把实情告诉病人的家属，偶尔有些个案的症状表现与其它型的精神病无法做确实的鉴别时，医师也会告诉病人家属病人患的可能是精神分裂症。不论医师的说法如何，假如病人患的确实是精神分裂症时，根据追踪研究的结果，已经证实病人之中有 1/4 的人可以完全复原，也有 1/4 的人会慢性化而发生人格败坏的现象，另外还有一半的病人虽然或多或少会残留了一些症状下

来，但是大部分的时间还是可以留在家里和社会中，过着常人一般的生活。倘若给予充分的治疗，精神分裂症恢复的希望仍然相当大。同时话说回来，“精神分裂症”原来也只不过是医学上的一个诊断分类的名词罢了，它并不是代表一种不治之症。

精神分裂症临床类型

精神分裂症的概念迄今尚无定论。但是本症自古以来临床上就分类为单纯型、青春型、紧张型、妄想型等四型。以意识障碍为主要征候的紧张型，由于发病激烈，症状激烈，虽然一般的愈后良好，但是容易附带发生许多偶发事故，往往超过精神科范围而须广泛和一般医生们适切的配合。

【单纯型】此型患者多见于青少年，病情发展持续缓慢，主要临床表现为情感反应减弱，思维内容贫乏，生活疏懒，做事缺少主动性，工作学习漫不经心，可同时伴有联想散漫。此型患者早期症状不突出，不易引起别人注意，所以要在早期发现往往都很困难。

【青春型】此型患者同前型一样，也多见于青少年，常为急性或亚急性发病。主要临床表现为行为紊乱，四处乱跑，哭笑无常，坐卧失度，同时情感反应幼稚，思维内容奇特，有时长时间傻笑，扮鬼脸，不断照镜子，甚或脱衣褪裤，赤身露体，不知羞耻。此型因精神障碍明显，容易早期发现。

【紧张型】此型多数急性发病，主要临床表现为运动方面的障碍。病人不言不动，不食不眠，甚至对外界刺激均没有反应，这种情况称为“木僵”。较轻的可以表现为行为被动，缄默不语。木僵时又可出现违拗现象（病人对别人的要求表现抗拒，例如叫他张口，他僵偏把口紧闭）或蜡样屈曲现象（即别人可把病人肢体摆布成各种不舒服的姿势，而病人可较长时间保持此种姿势不变）。紧张型患者也可出现运动性兴奋的现象，如出现刻板重复的动作或摹仿动作或突然的短暂的冲动行为。运动性抑制及运动性兴奋可在同一病人身上交替出现，但一般面言，兴奋发作较少见，持续时间也较短。

【妄想型】此型患者年龄多在30岁左右，起病有急有缓，主要临床表现为妄想或幻觉，早期妄想内容可以与现实有些联系，因此有时不易发现是病态。病情进一步发展时，妄想内容越来越离奇，同时又可伴有丰富的幻觉，主要为听幻觉。在幻觉和妄想的影响下，患者可以出现种种反常的行为。

以上的分型对估计病情及选择治疗有一定的作用，但同一病人在不同时期可表现出不同类型的症状。也有一些病人的症状不能明确分型，所以分型又不是绝对的。

病因、临床、诊断、治疗

病因

【病面病理】关于精神分裂症的患者，一般中枢

神经系统均无明显形态变化。从上个世纪以来在大脑的病理形态及病理生理、生化、遗传等方面进行了许多研究，都没有获得肯定的结论。所以迄今为止对本病发生的机理尚未搞清。

尽管发病机理尚未明了，但是这些研究所积累的大量资料对于阐明精神分裂症本质仍有其重要价值。发生本病的外部条件可有躯体的和精神的两类因素，本病可在感染、中毒、外伤、分娩以后或在各种精神因素作用下发生。可是这些精神的或躯体的因素通过什么途径、怎样引起大脑功能失调，还需要深入地研究。

但是，中医对精神分裂症的主要的致病因素和发病机理，却有了较充分的认识，大体可归纳为以下六个方面：

(1) 与自身中毒有关。体内代谢机能失调时，往往影响到供给大脑的血液质量，会带进有毒物质，从而导致大脑“自身”中毒。临床观察，大便秘结史者占95.4%。大便长时间积存在肠腔，小便也不能正常排泄，代谢产物不能顺利地排出体外，这就造成了有毒物质在血液中的不断积蓄。而这些积蓄的毒素，随着血液循环对大脑的不断供给，又带给了大脑。其结果必然造成脑细胞对这些有毒物质的吸收，形成脑细胞中毒，从而导致大脑功能的异常，出现思维、情感、智能上的反常和行为的怪异。

(2) 与内热炽盛有关。在大量精神分裂症病例中发现，绝大多数病人尽管存在着诸如幻觉、妄想、狂躁

等不同的症状群，但反应出来的舌苔、脉象、眼神、面色等体征，却有着共同点，都以显著的热象为标志。

“热”这种致病因素，和自身中毒的“毒”，事实上是性质相同，程度有别的两种病理产物。代谢紊乱可以生“热”；情志忧郁也可生“热”。情感的过分强烈和持久，必然引起脏腑功能的失调，“内热”由此而生，诸如心火、肝火、胃火等等，所谓“五志过极”，均可化火。当内火炽盛时，脏腑功能被严重地干扰，气机运转受到阻滞，水液运行受到破坏，导致新陈代谢紊乱，这些内在的异常现象，又反过来引起情感和行为的失常。

(3) 与性格缺陷有关。性格缺陷与精神分裂症有着密切的内在关系，这在治疗“精神分裂症”时必须引起重视。在治疗中，发现95%以上的病人在发病前，都分别存在着急躁、任性、孤僻、胆小、沉默、寡言、多疑、敏感、气量狭窄、倔强好胜、固执己见等性格缺陷，其中尤以孤僻、寡言、气量狭窄最为多见。

人都有各自的性格，但是性格异于寻常，或者过于极端和突出，就成为一种缺陷，称之为“病态性格”。一旦具备了这种“病态性格”，他对外界刺激的耐受量，就必然下降。

(4) 与机体功能下降有关。精神分裂症对于机体功能下降或衰弱的个体，是属于易感病。机体功能下降，主要指的是脏腑功能降低和气血虚弱，特别是心血不足。机体功能的强弱，不仅关系到个体行为方面，更

重要的是直接影响着个体接受外界刺激耐受量。部分脏腑功能下降的结果，必然导致整个机体功能的紊乱，因而在受到某种刺激的时候，表现出特别的脆弱，容易失去理智的控制。

(5) 与精神刺激有关。精神分裂症发病除体内机制外，精神刺激也是一个重要因素。除少数病人起病时的外在因素未被察觉外，绝大多数病人发病前均有明显的精神刺激为诱因。其中以恐吓、失恋、吵架、亲人亡故为多。有的在这种强烈精神刺激的当时或当天就发病。

《灵枢·口问篇》中曾说：“大惊卒恐，则气血分离，阴阳破败，经络厥绝，脉道不通，阴阳相逆，卫气稽留，经脉虚空，血气不次，乃失其常。”又说：“悲哀愁忧则心动，心动则五脏六腑皆摇，摇则宗脉感，宗脉感则液道开，液道开故泣涕出焉。”这就是说，引起“心动”和“气血分离”、“阴阳破败”的前提，必须首先具备“悲哀忧愁”和“大惊卒恐”的外界刺激条件，最后才出现“失其常态”的结果。

(6) 与遗传因素有关。在祖国医学里，关于精神疾病方面的遗传因素学说，比国外医学要早得多。论述首先见于《素问·奇病论》：“人生而有病癫疾者，病名曰何？安所得之？答曰：病名为胎病”。认为是胎中带来的。近年来，随着对细胞遗传、分子遗传学和临床资料的分析研究，证实在精神分裂症和躁狂抑郁症的发病中，遗传因素有较明显的作用。

临床

【临床表现】精神分裂症患者，临床上分别有知觉障碍、思维障碍、情感障碍、智能障碍、意识障碍、运动障碍、行为障碍等现象。也即患者能发生幻觉、错觉、联想力散漫、妄想。在情感上反应病态性的高潮、低落或反常，同时有记忆力判断和计算能力减退，甚至对周围事物的认识，以及对客观刺激不能做出适当的反应。并且还出现动作减少、增多等怪异现象或姿势。

此外，由于上述病态精神活动的结果，也会出现各种形式的行为紊乱。

精神分裂病人发病期还有一个普遍的特点，就是对自己的病症缺乏认识，不承认自己有精神分裂症，因而不会主动就医甚至拒绝就医，这种情况称为缺乏自知力。

精神分裂症在临床上主要表现为精神活动的障碍。在上述各种精神症状中，一般除智能障碍及意识障碍较不明确外，其它均可出现，但以思维障碍为最重要，也是本病最多的症状。

正常的思维过程是一系列概念的联系过程，这种联系必须是合乎逻辑的，前后连贯的，最后才能解决问题。

精神分裂症病人的思维过程的特点是缺乏逻辑性和连贯性，称为“联想散漫”。病人所表达的个别语句或概念都可以是正常的，但是把他的整个谈话联系起来

却不知他是想说明什么问题。有些病人甚至连所表达的个别语句都缺乏连贯、支离破碎和语不成句，称为“思维破裂”。有些病人在叙述一件事时会突然扯到另一件事上去，给人一种喧宾夺主的印象。例如：一个病人在向医生叙述邻居小孩跟她打架的事时，突然高声唱起一支流行的电影歌曲来。问她为什么唱歌，她说：“我跟这个姑娘一样诚朴（指电影中的女主角），怎么会和小孩打架呢？”有些病人思维障碍表现为跟他谈话时他不能抓住问题的本质，例如：在巡视病房时医生问一个病人：“你好吗？”病人立即回答：“我不是坏人。”这说明病人把医生问话中身体好坏的“好”理解为好人、坏人的“好”了，这一回答完全不能和当时客观情境相协调。有些病人常常不能很好地区分抽象和具体的概念，例如：一个病人在听见鸡叫时突然恐惧不安，因为他认为自己生肖属鸡，现在听见鸡叫，表示要杀鸡了，即要杀自己了，所以恐惧不安；又例如一个病人说要进行“冬季训练”，但他并不去进行体育活动，而是采取只穿单衣，拒绝吃饭的方式进行。有些病人创造了一些离奇古怪的符号、标记或动作，以此来象征其它事件。如一病人无论在坐、立、行走的任何时刻，始终保持膝关节不屈曲来象征其性格坚强。对这类象征，别人往往不能理解，但他却认为是别人完全应当现解和接受的，故称为“病理性象征性思维”。还有些病人常用第三人称来代表自己，例如一个名叫张三的病人向医生提出要求出院，他这样表达：“医生，张三叫我请你批准

丈夫爱上了“邻居的老太婆”，或者认为“所有女人都看中了他”，这类妄想称为“嫉妒妄想”。有这种妄想的病人，严重时可整天盯住其爱人，不许爱人上班，或者陪着爱人上班，或者对爱人的所谓“对象”进行攻击。有的病人认为自己生了异常严重或异常怪异的疾病，例如：“血液枯竭了”，“肠胃烂光了”，但他却从不考虑自己有这样重的病为什么还能照常活动的问题，这类妄想称为“疑病妄想”。有的病人认为自己很有才能，发明了某种有巨大价值的东西，或已被选中担任某重要职务等，这类妄想称为“夸大妄想”。有的病人认为自己的思想及身体活动被某种“仪器”或说不清楚的外界力量所控制，觉得“自己不能作自己的主了”，这种情况称为“被控制感”。有的病人觉得自己的一言一行在思想刚冒头的时候就被别人知道了，至于别人怎么知道的，他却说不清楚，这种情况称为“被洞悉感”。有的病人把一些偶然巧合而毫无联系的事情连到自己的身上，与自己的某些想法结合起来，这种情况称为“牵连观念”。牵连观念可以成为各种妄想的基础或不断加强这些妄想。例如有被迫害妄想的病人看见别人做了一个手势或吐一口痰就可以坚信这是对他“进行迫害的信号”，这种牵连不但别人无法理解，而且也很难用一般的解释来动摇他的这种信念。

情感障碍也是精神分裂症的重要症状，这主要表现为情感反应与其思维内容的不协调，与当时环境的不协调。例如：有的住院病人可以表现非常想念其家属，

有声音把所想的東西都宣讀出來”。有的病人可以有喃喃自語、似與人对答的表現，或有側耳傾听的表現，這些表現都提示有幻听。

幻視較少見，所看到的常是一些不完整的“圖像”。嗅幻覺及味幻覺在有被迫害妄想時出現，病人可嘗到或嗅到各種“不好的”、“有毒的”味道。觸幻覺也不多見，此種幻覺有時集中在性器官方面。

各種奇怪的訴述有時可以是精神分裂症的妄想或幻覺的表現，例如病人可以感到“半个腦子壞掉了”、“腸胃被塞住了”等等，有的病人因此反復找醫生作許多檢查，而大量的陰性的檢查結果都仍然不能說服他。

由於精神分裂症患者的幻覺常是在意識清楚的背景下發生的，所以客觀刺激常與幻覺同時被感受，但疾病的一定階段，感受對病人行為的影響往往大大超過客觀現實的影響。例如在幾個人同時對他進行談話的情況下，病人的注意力也可以突然被一句模糊的幻覺的耳語聲所吸引，並且受到此“聲音”的控制，不能接受周圍人的勸說或解釋。幻覺如果較長期存在，它對病人行為的影響可以逐漸減少，病人可以在某種程度上意識到這種“存在”的不現實性，從而減少對它的行為反應。有的病人雖然自己對幻覺堅信不疑，但卻意識到周圍人不會相信，因此可以在旁人面前掩飾或否認其幻覺。當然，許多病人都認為其幻覺是現實的，別人也應該同樣感受到，但對別人為什麼不受幻覺影響這一個問題，他却並不去追究。

精神分裂症除可有各种形式的行为紊乱外，还可有一种较为特殊的行为障碍，就是行为的“内向性”，即病人可以完全沉溺在他自己的内心世界，他的意欲、妄想及幻觉之中，而对周围现实置之不顾。例如病人可以在别人面前喋喋不休地诉述其病态思维内容，即使别人不听他说，甚至不要他说，他仍可诉述不止，好像别人仍在注意倾听一样。有的病人也可以把自己的幻想世界跟现实世界混淆起来，或认为二者都是一样现实的，例如病人既了解给他看病的人是医生，但同时又确认医生就是他的“舅舅”。

精神分裂症病人除非幻觉妄想极度严重，否则意识一般都是清楚的，如果病人在检查时能合作，其智能一般也查不出有什么缺陷。

诊断

【诊断】精神分裂症的诊断主要根据临床表现，把病史中的表现以及精神检查的发现两个方面结合起来分析判断。体格检查也是不可少的，其目的一方面是为了排除其它疾病，因为某些疾病（例如脑肿瘤、某些中毒等）可以产生与精神分裂症很相似的表现；另一方面又同治疗方法的选择有密切关系。在临床表现一节中所描述的许多症状对诊断本病都有重要意义，问题在于如何正确地说明这些症状，并把检查的发现结合病史资料及其它情况进行历史的、全面的、细致的、辩证的分析。

由于屏气过久，会出现紫绀，有时出现心率和心律的变化。人中、百会加强刺激时有时可能出现癫痫大发作，减少通电量即可避免。另外，操作不当可能引起牙齿损伤，咬破唇、舌等。由于电针治疗过程中有时偶尔会出现癫痫大发作，故对使用利血平的病人进行电针治疗时应当慎重。对脑部有器质性病变、高热、心肺功能不良及体质较差的病人，不宜采用电量过高的强刺激方法。

体针手法捻转和耳针（包括电耳针）也可采用。常用体针穴位除上述头面部穴位外，可选合谷、内关、间使、涌泉、足三里、三阴交、太冲、鸠尾、心俞、肾俞等穴，每日2～3次。常用耳穴有神门、交感、脑点、脑干、心、皮质下、肾、内分泌等，每日一次，20次为一疗程。

初步的实践证明，针刺疗法对各型精神分裂症均有一定疗效。兴奋躁动、木僵和有幻觉妄想的患者以强刺激疗效较好；弱刺激对意识较清楚的患者比较适用。手法捻转的疗效比电针略差。

有人采用大椎、陶道等穴位来治疗精神分裂症，也有疗效，但在应用此法时必须极端注意安全，防止损伤脊髓。

西药治疗

目前主要采用氯丙嗪、奋乃静、三氟拉嗪、泰尔登、利血平及氟哌定醇（haloperidol）等药，现分别介绍如下：

(一) 氯丙嗪 或称氯普马嗪、“冬眠灵”等，是对精神病有比较肯定疗效的合成药物，适用于各型精神分裂症，特别是对控制兴奋躁动及幻觉妄想等症状效果较好，对单纯型、紧张型疗效较差。

本药有加强麻醉剂、止痛剂的作用，又有较好的止吐作用，故亦用于临床其它各科，但在治疗精神病时其剂量要较内、外科疾病大得多。一般从每次 25 毫克、每日 3 次开始，在几天内根据其反应情况增至每次 100 毫克、每日 3 次或更大一些。作为治疗剂量，治疗一较长时期（一般为几个月）后，如病情好转并稳定，可逐渐减量维持，维持量每日 50 ~ 150 毫克左右（睡前一次服或分次服），维持量需使用更长的时间。病人不能口服时可以肌肉或静脉注射（静脉注射须用 25% 或 50% 的葡萄糖液稀释至 20 毫升），不宜皮下或皮内注射。注射剂量每次 50 毫克。

本药有明显镇静作用，病人在开始服药阶段可出现嗜睡，它又有对抗肾上腺素的作用，故可引起体位性低血压。较大剂量可引起锥体外系的症状，表现为流涎、手抖、动作不灵活等，这些症状可以加服东莨菪碱（0.2 毫克，每日 3 次）或安坦（即盐酸苯海索，2 毫克，每日 3 次），以减轻或解除之。本药有影响体温调节中枢及阿托品样作用，故在使用剂量较大时应防止中暑（特别是初夏闷热天气）。本药偶可引起黄疸（一般属胆小管阻塞性黄疸），此时肝功能转氨酶试验亦可较正常稍增高，故有肝功能损害者应慎用此药，用此药后如出现

肝功能损害应立即停用。本药引起药物性皮炎较常见，一般多见于暴露部位，太阳曝晒可以加重此种皮炎，亦有发生严重的全身性皮炎者，用此药引起药物性皮炎者应立即停用，以后亦尽量不用。本药还可引起粒细胞缺乏症，但据报道发生率仅几万分之一。

(二) 奋乃静 又称羟哌氯丙嗪，是氯丙嗪类药物之一，对妄想幻觉症状疗效较好，镇静作用不及氯丙嗪。治疗剂量为每日 20 ~ 60 毫克，分次服，必要时也可用 5 毫克肌肉注射，每日 1 ~ 3 次。其用法及疗程与氯丙嗪类似，本药引起的锥体外系症状较氯丙嗪重，其它副作用较轻。

(三) 三氟拉嗪 也是氯丙嗪类药物，对妄想、幻觉、迟钝、被动等症状疗效较好，治疗剂量为每日 20 ~ 60 毫克，分次服。应从小量开始，缓慢加至治疗剂量，其它同奋乃静。

(四) 泰尔登 用法、剂量等均与氯丙嗪相似，但疗效较氯丙嗪稍差，镇静作用较氯丙嗪稍好些，并有抗焦虑性忧郁的作用，副作用与氯丙嗪差不多，但锥体外系反应较少，对肝脏毒性较小。此药与氯丙嗪在化学结构上不同一类，故对氯丙嗪过敏者仍可用。

(五) 利血平 原用于治疗高血压，以后发现亦可治疗精神病，主要用于兴奋躁动，疗效较氯丙嗪差，对忧郁焦虑症状者不宜用。此药目前主要用于对氯丙嗪过敏的病人及用其它治疗无效的病人。治疗剂量每日 4 ~ 8 毫克，分次服，亦应从小量开始，逐渐增加。它

较易引起锥体外系症状，故常需并服安坦或东莨菪碱。它又可兴奋迷走神经，引起胃肠道出血，故有严重消化道溃疡者应慎用。本药其它副作用较氯丙嗪少。

(六) 氟哌啶醇 亦称卤吡醇。此药历史较短，在化学结构上与以上药物不同一类，主要用于兴奋躁动、妄想幻觉等症状，其剂量为每日 5 ~ 20 毫克分次肌注，或取 5 毫克以 25% 葡萄糖稀释后静脉注射。在 1 ~ 2 分钟内缓慢注入，每 8 小时一次，如无好转可将剂量加倍。好转后改口服。如用口服法，可从 2 ~ 4 毫克、每日 3 次开始，酌情逐渐增大剂量，有效剂量一日一般在 20 ~ 30 毫克左右。副作用与氯丙嗪相似而较小，但容易引起严重的锥体外系反应。有些病人在 10 毫克一日时就发生动眼危象，故宜及早使用安坦或东莨菪碱。对肝脏及造血系的毒性作用不明显，可能引起低血压，应避免体位的急剧改变，心脏机能不全者不宜使用。

以上诸药在应用中一种药物无效时，另一种药物可能有效，或合并应用可以收效；在一般剂量无效时加大剂量可能有效；在短期服药无效时，较长期服用可能有效。

由于精神病人大多否认自己有病，认为不需服药或治疗，故常有公开或私下拒绝服药的行为，如不注意亦可以影响疗效。也有些病人把每天要服的药收藏蓄积起来，一次服下造成中毒，必须注意预防。

中药治疗

【辨证施治处方一】

对兴奋躁动，体实并有火盛征象的病人，可应用清热泻火法。黄芩、黄连、黄柏、当归、芦荟、龙胆草、大黄、芒硝各9克，柴胡12克，龙骨、牡蛎、石膏各30克，知母6克，甘草3克。

对情绪不稳、体不虚、精神症状有周期性加重的病人，可用调气破血法（参见“周期性精神病”）。

【处方二】

对迟钝、被动、懒散嗜卧、面色苍白、舌质淡、苔薄白、脉细或沉、或阴盛阳衰征象者，可用温阳兴奋法。附子、肉桂、干姜各6克，巴戟天、淫羊藿、仙茅、黄芪、陈皮各9克，党参6克，熟地15克，龟板15克，砂仁、甘草各3克。

以上方药，均为每日一剂，以30剂左右为一疗程。

症例治验

例一

【辨症】肝郁气滞，气火痰升，上扰神明。

【治法】平肝解郁，泻热化痰，理气散结。

金礞石24克，郁金15克，三棱9克，莪术9克，木香6克，二丑15克，生桃仁15克，枳壳9克，生大黄15克，干姜5.5克，芒硝30克（分冲）。

【服法】水煎服，每日一剂。

若为女性患者，每至月经期病情加重者，兼有血淤之症，可配合服用“活血散”：三七 51 克，血竭 51 克，琥珀 51 克，西红花 30 克，朱砂 21 克，麝香 2.5 克，冰片 9 克。共研为细末，瓶封备用；一日两次，每次 2.5 克至 3 克。

【疗效】① 女，16 岁。因郁怒不消而致精神失常，时哭时笑，不寐不食，语无伦次，每至月经来时病情加剧。诊后以精神分裂症论治，投“平狂汤”，配合服用活血散，用药数剂，其症除病愈。其后上班工作，追访已数年，亦未见再复发。

② 女，23 岁。由于所受惊吓，加之纠纷伤情，致患精神失常，阵哭阵笑，昼夜哭闹不眠，只食一些果类，不食面米，家人为之十分忧伤。诊后即用以“平狂汤”，服药一剂，诸症除去大半，该病人见转机，连进 3 剂，诸症皆除，而获痊愈。

③ 女，40 岁，患精神失常已许久，症见语无伦次，狂言吼叫，不识亲友，打人骂人，哭笑无常。投以“平狂汤”，药到神清，仅服数剂，复如常人。

按：所用“平狂汤”方，药味峻烈，泻下作用甚强，服之泻下不甚重者可常规用药一日一剂，泻重者可隔日用药，更重者可考虑停药。据临床观察，一般服后腹泻重者多疗效佳良，其泻下物可为水样、粘液样、血样、泡沫样，此物排之越为干净，其治愈希望越大。但应注意不使虚脱为宜。

例二

【辨症】气火交郁，热与血结，腑气不利，淤热上熏。

【治法】通腑泻热，行淤散结。

柴胡 12 克，大黄 9 克，枳实 9 克，丹皮 12 克，桃仁 12 克，赤芍 9 克，半夏 9 克，竹茹 9 克，生姜 12 克，梔子 9 克，郁金 9 克，陈皮 9 克。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】李××，女，20岁。患者新产已20日，因琐事与邻人口角，气恼而致精神失常，骂人，摔物，有时瞋目握拳，势如击人，但不付诸行动，口中喊唱不休，烦躁不眠，已7昼夜不曾交睫，精神亢奋。西医诊断为精神分裂症，曾用以冬眠灵等药而不效。患者两目发直，问其家人，得知大便已数日未解，小腹疼痛拒按，发病时恶露已尽，其脉弦滑有力，唇红绛，舌苔黄腻。诊后即用以“狂醒汤”方。用药一剂，大便泻下甚多，皆为粘秽之物，当夜即思睡，呼之不醒，熟睡一夜后，醒来精神已慧，恍如梦境，而恶露遂来病乃获愈。

例三

【辨症】实热痰火，上扰心窍。

【治法】清心泻火，平肝止痉，涤痰开窍。

大黄 30 克～60 克，活地龙 51 克～69 克，韭菜汁 100 毫升。

【服法】先将地龙洗后切断，于瓦罐中文火熬煎

1 ~ 2 小时，取汁约 350 毫升，冲入大黄中浸 2 小时，其后煎片刻，待放温后兑入韭菜汁中分服，每日一剂，分 2 ~ 3 次服。

【疗效】上方曰“大黄韭龙汤”，服后可使多数精神分裂症患者心神宁静，诸症得减，渐有睡意，如此更宜合作治疗，再配合用其它中西药物，即能收到较好的疗效。

霍××，男，26岁。患者于一个月前因精神受挫而致精神失常，沿街叫骂，通宵不寐，胡言乱语，精神恍惚，刚暴不惧，毁物伤人。曾住入某医院治疗，诊断为精神分裂症（狂躁型），治疗未取得明显效果，家长带其出院，后病情加重，此前来诊治。证见两目眦视，面带怒容，体僵目赤，溺短便坚，舌尖红，苔根黄，脉弦滑数（每分钟 126 次），此乃实热痰火，上扰心窍。先投以“大黄韭龙汤”，以期心神安宁。其服药 4 剂，病机已有转势；服药 8 剂，心神已见安宁，神识转清，问答切题，其大便虽已见泻，然此时仍见反应迟钝，语言繁琐，手腕发颤，自觉胸闷如堵，咽喉不利，虽能入眠，但睡之不深，溺短，脉数（每分钟 120 次）。乃实火虽除，但余热未清。因此投以仿生铁落饮方，以求进治。其方为：生铁落 300 克，珍珠母 39 克，磁石 30 克（上三味药先煎一小时）；麦冬 24 克、橘红 9 克、胆星 9 克、京菖蒲 9 克、远志 6 克、郁金 12 克、丹参 24 克、朱茯神 24 克、炙甘草 9 克、小麦 30 克。服药 3 剂已能熟睡，诸症进一步得减；药尽 8 剂，基本治愈。

其后又以百合 30 克、知母 15 克、小麦 30 克、炙草 9 克、丹参 21 克、珍珠母 39 克为方调治，以巩固疗效。追访未见复发。

按：其“大黄韭龙汤”方，乃一董氏家传之方，取之用以治疗精神分裂症，多能取得较好疗效，尤其是病程在一年以内者为佳，且其方无明显副作用。方中之大黄清心泻火，地龙清热镇静活络，韭菜汁涤痰开窍，三药相辅为用，攻逐宣通，使气滞之郁可解，五志之火可泄，上乘之痰可降，故而心神可得安宁，其病势得以精机。

例四

【辨症】痰热内结，上扰心神。

【治法】清热化淤，宁心安神。

生龙骨 30 克，生牡蛎 30 克，白薇 12 克，橘叶 12 克，生地 12 克，生白芍 12 克，川牛膝 12 克，玄参 9 克，麦冬 9 克，山栀子 9 克，竹茹 9 克，炒枳壳 9 克，生甘草 3 克。

【服法】每日一剂。首煎加水 600 毫升，文火煮沸 30 分钟，约取药液 400 毫升；二煎加水约 500 毫升，煮后取 300 毫升；混合，分早晚二次服。

【疗效】郑××，女，38 岁。因精神受刺激，症见躁而不安，坐卧不宁，气逆胸闷，情精抑郁，不饥不食，时而悲伤啼哭，不能自主，且有时跑至街巷，自言自语，或高喊吼叫；时而伴乍寒乍热，项背如灼，头晕头痛，咯吐粘痰，口燥咽干。曾在某院诊治，诊断为精

神分裂症而久治不效。故来求治，其脉沉弦细，舌苔薄白，此乃肝郁气滞，郁而化火，火灼伤津，敛津为痰，痰热上扰，心神不宁。治当清热化痰，宁心安神。投以上方治疗，并配合硃珀散：硃砂 12 克，琥珀 18 克，共为细粉，分作 12 包，每晚睡前服用一包，温开水调服，服 4 日停服一晚，连用汤剂三十余剂，硃珀散二料，诸症次第平息而愈。

按：如上汤剂与散剂配合，除治疗精神分裂症外，治疗“癔病”亦可收到好的效果。

其配合治疗所用“朱珀散”中之朱砂，据现代药理研究证实能够降低大脑中枢神经兴奋性，具有镇静作用。但在用之前不可与火接触，否则会分解出金属汞，而致中毒。如上所用，药量不宜大，不宜连续长期服用，所以服 4 日停服 1 日为妥。

例五

【辨症】肝胆实火，兼挟痰浊，蒙闭心窍。

【治法】清泻肝胆，豁痰开窍。

龙胆草 9 克，山栀子 9 克，黄芩 9 克，炒柴胡 3 克，生地黄 12 克，陈胆星 6 克，菖蒲 6 克，郁金 9 克，生大黄 15 克，熟大黄 15 克，玄明粉 12 克，黄连 3 克，生铁落 30 克。

【服法】水煎，以药汤代水分两日频饮。

【疗效】许××，女，21 岁。新婚半月，不遂所愿，悲哀气恼，遂发狂症，昼夜不眠，语无伦次，时而狂叫，诊时狂笑不已。登桌歌舞，面红体实，舌红苔

黄，脉滑数有力，症系肝胆郁火挟痰，蒙闭心窍。投以上方治疗。用药一剂，共服二日，第三日来诊，其夜已转安，神清，语言中肯。又投以加减丹栀逍遥散（汤）五剂，以善其后，其方为：丹皮9克、山栀子9克、黄芩9克、当归9克、白芍9克、茯苓9克、白术9克、甘草3克、薄荷3克（后下）、郁金9克。药后痊愈，随访已四年余，未见复发。

例六

【辨症】恼怒伤肝，气郁化火，灼津成痰，痰热上扰，蒙闭心窍。

【治法】平肝泻火，豁痰镇心。

生龙骨30克，生牡蛎30克，石决明30克，珍珠母30克，龙胆草9克，天竺黄9克，礞郁金9克，旋复花9克，代赭石9克，黄芩9克，金礞石30克，沉香5.3克，大黄6克。

【服法】水煎服，每日一剂。

甘遂1.5克，朱砂1.5克。共为细末，用汤剂冲服，隔日一次。待狂症平时，可减甘遂。

【疗效】张××，男，20岁。由于工伤所受刺激，而致精神失常，狂躁不安，时而胡言乱语，语无伦次。来诊时由七八个青年架来，猖狂刚暴，不予合作。强行诊脉，弦滑有力，舌象不能观察。详诊脉症，凭经验即投以上方治之。患者用药5剂，病症基本已除。据述，每次服药后，可见大便秘浊粘垢2~3次。复诊时，即嘱用原方去甘遂，再进5剂，药后而愈。



病因、临床、诊断、治疗

本病具有按月周期发病的病程，有明显的间歇期，常重复发作。

本病不但在临床、病程方面有其特殊性，而且通常用来治疗精神病的安定催眠药物对它大多无效，常常需要采用特殊的治疗方法。因此，将本病单独列开叙述，给予应有的临床地位，就显得十分必要。

【病因病理】周期性精神病的病理生理本质至今还没有弄清楚，由于本病在精神障碍的同时，常伴有程度不等的植物神经机能失调和内分泌紊乱，可能指示本病与间脑的某些机能失调有关。对患本病的女病人进行内分泌实验研究的结果，认为本病由于间脑垂体系统机能失调，形成了“不排卵性月经”，因而黄体未能形成，以致尿内孕二醇排出量极少或无。有人更发现本病多见第三脑室的扩张、脑室变形等等。内分泌治疗以及对植物神经机能失调和内分泌紊乱有调正作用的谷维素对本病治疗的良好疗效，也为本病发生可能与间脑机能失调有关提供了佐证。

【临床表现】本病绝大多数起病于青春发育期，以13岁至18岁之间为最多，男女均有，而以女性更为多见。从发病年龄这一事实来看，可能说明内分泌因

素在发病上有重要的意义。但也有少数年龄更小的儿童也可能发生本病。

本病每次发作开始急骤，结束也很快。发作前常有失眠、头晕、口干、食欲改变、鼻出血、发热等前驱症状。女病人发作通常于行经前期数日开始。发作经过5～12日结束。发作时主要以运动和情感的变化为主，或为兴奋多言、躁动不歇，或为呆滞、嗜睡、迷惘、拒食、单调的哭喊、惊恐不安。部分病人发作时有梦样意识改变。但也有呈躁狂、忧郁、兴奋、木僵发作而不伴明显意识障碍者。

发作时多见植物神经功能失调和内分泌紊乱，闭经、体温微升、心率加快、手足冷而多汗、可有轻度肢端发绀，面色或显充血、或显苍白，有时见到明显的食欲异常。部分病人发育停滞、身体矮小、生殖器发育不全。而神经系统体征很少见。脑电图可有轻度或中度弥漫性异常，如节律紊乱，两半球出现少数尖波或 θ 波、 δ 波。

每次发作的临床表现十分相似，具有刻板性的特点。就某一病人而言，其各次发作的症状以及持续时间的长短，几乎都是相同的。

周期交替的时间多为一个月左右。有些病人的周期非常规则，发作往往出现于每月的几天的中。发作间歇期患者完全健康，没有残余精神缺损，病人言行有序，具有良好的批判力。

通常每月重复发病，但也有一年仅为数月出现发

作者。

【诊断和鉴别诊断】 诊断主要依据起病的年龄、规则的周期性病程、发作急骤的起止、重复发作的刻板性以及间歇期精神正常等特点。发作时出现植物神经和血管舒缩障碍，有助于诊断。

本病容易同精神分裂症周期发作类型或经期恶化类型混淆，有时也可能与躁郁症相混淆。应当特别指出，由于本病的发作，就某一病例而言，常同其月经周期有特定的关系。如此次在行经前 2 ~ 3 天发作，则下一次也常是行经前 2 ~ 3 日发作，因此，有人把“精神病发作与月经来潮的关系”作为诊断本病的标志。但是这种看法是不全面的，不可靠的，因为本病可以月经初潮以前发生，或者发病后月经闭止，如仅按上述标志，势必将这类周期性精神病误诊为其它精神病。同样，精神分裂症的某些类型也常常在行经期恶化、加剧，如仅按上述标志，也会将分裂症误诊为本病，可能造成治疗上的周折和失败。

经验表明，发作周期不规则，发作持续时间长短不一，或间歇期残留明显的“精神缺损”，以及发病时出现独特的妄想、各次发作症状不同者，随访证明往往是精神分裂症。

西药治疗

谷维素：使用此药治疗周期性精神病 30 例，除四例发作减轻后中断门诊外，26 例均取得满意疗效，发

作停止。

本药用法：每日 30 毫克，分 3 次服，一般每日剂量不需超过 60 毫克。如已在发作期，谷维素并不能遏止发作（与剂量大小无关）。如在间歇期给药，则可使下次发作减轻或停止。通常 1 ~ 2 个周期即可显现效果。一个疗程为 3 ~ 4 个月，疗程结束后一般不再给药维持。

本药副作用：很少，大多很轻微，在治疗中可自行消失。曾见到轻度胃不适、恶心、口干、皮肤痒感、皮疹（散在丘疹，多不严重）、疲乏感、头昏、体重异常增加等，偶见油脂分泌过多、脱发及男性乳房肿胀现象。

内分泌疗法 根据本病内分泌实验研究的结果，对患本病的女性患者采取性激素治疗，如诊断可靠，治疗多能取得预期的满意效果（对周期型精神分裂症多无效）。

治疗方法：按病人月经周期投药，若停经或末次月经日期不明者，可按开始发作的日期计算。行经第六日起，每晚服乙芪酚 1 毫克，连续两周左右，继用黄体酮 10 毫克肌注，每日一次，连用 10 ~ 12 日。月经来潮时不给内分泌药物，于行经第六日起再作一个周期治疗，如此循环给药。经 2 ~ 3 个周期治疗，发作大多停止，如第一个周期未收效时，决不应轻易放弃。发作停止后仍须维持内分泌治疗 8 个月至 1 年，以后可停药观察。

内分泌治疗时性激素务必连用，不要中断，防止停药后引起阴道流血或月经紊乱。应用黄体酮时，如未用到预定针数，月经已来，则可考虑停止注射，于行经第六日起开始下一个周期治疗。如已用完预定针数，月经未来，停止注射后 1 ~ 2 天内月经将会来潮。少数病例经量过多时，可用丙酸睾丸酮 25 毫克肌注，每日 1 ~ 2 次，连用 2 ~ 3 天。同时给予其它止血药。

关于使用安定药的问题，临床实践证明，氯丙嗪、奋乃静、泰尔登等安定催眠药不能终止本病的周期发作，因此，不必长时间应用安定药，只在发作时为了减轻症状，作为短期的临时性措施，发作一过，即应停止。

中药治疗

根据祖国医学记载，气血不调是造成某些精神病的原因，采用调气破血法，临床观察证实对本病表现有情绪不稳，行为紊乱者有效。

所用方剂为：柴胡 15 克，龙骨（或磁石）30 克，牡蛎 30 克，竹沥半夏 9 克，黄芩 9 克，桃仁 15 克，红花 9 克，丹参 15 克，丹皮 15 克，赤芍 15 克，香附 15 克，青陈皮各 15 克，酒大黄 15 克，甘草 9 克，每日服一剂

每月月经来潮前 10 天至一周开始服 7 ~ 10 剂。

第十一章

癲 癇 症



病因、临床、诊断

癫痫 (epilepsy) 是一组慢性临床综合症，以在长期病程中反复发作的神经元异常放电所致的暂时性脑功能异常为特征。

【病因】癫痫的致病原因十分复杂，按传统分为器质性（继发性）和功能性（原发性）两大类。

一、器质性癫痫

可由脑先天性疾病、脑外伤、脑缺氧、脑部感染、颅内肿瘤、脑血管疾病、代谢障碍或中毒等引起。

癫痫的倾向有遗传性，但是否有症状，还受到多种环境因素的影响。许多生理的和环境的因素如内分泌改变（如妊娠期癫痫）、睡眠（缺睡会激发大发作）、疲劳、饮酒、惊恐、饥饿等都可成为诱发因素。有些病人仅在某些特定的条件下才发作，如光、声、触等感觉刺激，或进食、奕棋等，统称为反射性癫痫。

二、功能性癫痫

是指脑部无明显病理改变，而由于病人脑功能不稳定，往往因为体内外环境在生理范围内的各种改变而诱发发作。通常在儿童期及青少年期起病。

功能性癫痫病人亲属中的癫痫患病率为一般人口中癫痫患病率的 4 ~ 7.2 倍，器质性癫痫病人亲属中

的癫痫患病率也高于一般人口，为后者的 2 ~ 3.6 倍。一般认为，在癫痫的发生方面与遗传有关的可能性有两类情况。一类为由常染色体显性基因所遗传的癫痫，约占癫痫病人的 0.5% ~ 3%，在临床上多数表现为失神小发作，脑电图上呈有规律的每秒 3 次的棘 ~ 慢波，两侧同步地见于脑的各个部位，一部分亲属无临床癫痫发作而在脑电图检查时可见到典型的痫样放电。另一类情况则为可能与几个基因有关的遗传现象，病人并无特殊类型的癫痫发作或脑电图改变，主要表现为惊厥阈值的低于正常，因而在各种脑部疾病时易于发生癫痫。

有时还看到某些癫痫病人的发作可由发烧、饥饿、疲劳、强烈的情绪刺激、闪光、响声或酗酒等因素而激起。

【临床表现】 根据发作时的表现，主要可分为大发作，小发作，局限性发作和精神运动性发作。它们大多具有间歇性，短时性和刻板性的共同特点。所谓间歇性，即常在一次发作后间隔不定的时间再次复发。小发作一日自数次至数十次不等，甚至可达 100 次以上。其他类型发作一般间隔数日至数周，少数为一日数次或间隔一年以上发作。部分病人常在一定的时间发病或发作增剧，例如在人酗后不久或清醒前后以及妇女的行经前期。短时性，即每次发作持续的时间多数不超过几秒钟到几分钟而自行中止。刻板性，即一个病人每次发作时的表现特点基本相间或具有固定的型式。各类发作既可能单独地、或不同组合地出现于同一病人身上，也可

能开始表现为一种类型的发作，以后转为另一类型。例如，在儿童期出现的小发作，常在青春期后停止发病；但有些病人却出现大发作；也有起初为大发作，以后发生精神运动性发作等。

一、大发作

以意识丧失和全身抽搐为特征。发作过程可分为三期：

1、**强直期**：突然意识丧失、跌倒，全身所有骨骼肌呈持续性收缩，表现为上睑上举，眼球上窜，喉部痉挛而发出尖叫声。口先张开而后突然闭合，可能咬伤舌头。此时大多持续 10 ~ 20 秒。

2、**阵挛期**：骨骼肌呈节律性抽搐，先快而逐渐减慢，然后突然终止。一般持续 1 ~ 3 分钟。

3、**惊厥后期**：仍牙关紧闭，有小便失禁。呼吸首先恢复，口鼻喷出白沫或血沫。意识逐渐恢复。醒后感头痛，全身酸痛和疲乏，对抽搐全无记忆。不少病人抽搐停止后进入昏睡，时程不定。发作频率自数年一次至一日十余次不等。

大发作在短期内频繁发作，以致间歇期间仍持续昏迷者，称为癫痫持续状态。必须紧急抢救，否则危及生命。

二、小发作

在儿童期起病，通常至成年后即消失或转为大发作。

1、失神小发作：为短暂的神志丧失，约持续数秒钟至半分钟，患者突然停止活动，中断谈话，面色泛白，双目凝视面无神，手中持物可能落地，有时头向前倾跌或眼睑及上肢出现不易觉察的颤动。也可能机械地从事原先的活动（如行走或骑车）。发作一停止，患者立即意识清醒，但对发作经过毫无记忆。

2、肌阵挛小发作：为涉及肢体、躯干及头部肌肉的突然抽动，通常两侧对称，频率每秒钟三次，有时患者可因强烈的抽动而跌倒在地，每次发作不到一分钟。

小发作与大发作为两种不同类型的癫痫，当大发作病人仅出现先兆而不发生意识丧失或全身抽搐时，可称为不完全性发作而不应称为小发作。

三、局限发作

1、运动性发作：表现为一侧口角、眼睑、手指或足趾局部重复抽搐或短暂的突然不能用言语表达其意念或眼球突然向一侧偏斜，甚至全身扭转。

2 感觉性发作：表现为口角、舌部、手指或足趾的针刺感、麻感、触电感等，也可表现为闪光感，听到噪音等。

四、精神运动性发作

病人往往先有某种局部性感觉发作症状，继面意识模糊或精神错乱，然后出现无意识的重复原动作，或其它无意识的动作如吸吮、咀嚼，甚至游走、奔跑等。

者，进行及时的积极治疗，大约可使 50% ~ 60% 病人的发作得到控制，另有约 25% ~ 30% 的病人发作减少或减轻。尤以早期进行治疗效果为更好。治疗无效的原因，在主观方面，有过早的停药或减量、服药不规则、经常更换药物。剂量不足以及药物选择不当等，均应设法避免或纠正。就发作类型而言，以大发作和小发作的疗效为更满意。

一、发作时的处理

1、一般原则

对大发作病人，注意防止跌伤和碰伤。应立即使其侧卧，尽量让唾液和呕吐物流出口外，不致吸入肺内。在患者张口时，可将折叠成条状的毛巾或手帕塞入一侧上下臼齿之间，以避免舌部咬伤。衣领及裤带应即解松。抽搐时不可用力按压患者的肢体，以免骨折。发作大多能在几分钟内自行中止，无必要采取特殊的治疗措施。对癫痫自动症病人，在发作时应防止其自伤、伤人或毁物。

2、癫痫持续状态的治疗

癫痫持续状态为一极端严重的情况，必须设法于最短时间内中止，保持连续 24 ~ 48 小时无抽搐发作。并应立即给予氧气吸入。在确定病因并予积极治疗的同时，选用以下药物之一作静脉注射（均为成人剂量）。首次即须应用足量，如用量不足，则发作不能控制，势必多次应用，反面更易引起中毒反应。但在另一方面，

克或聚乙醛 5 毫升，每 4 ~ 6 小时一次，待 24 至 48 小时无抽搐发作后，改为间歇期的药物治疗剂量，根据病人的意识状态采用口服或鼻饲给药。

反复的癫痫大发作会引起脑水肿，后者又能促使发作，故可静脉注射甘露醇、山梨醇或高渗葡萄糖以消除脑水肿。在较长时间的抽搐昏迷状况下，还应注意维持病人呼吸道的畅通、循环机能的正常，并预防和治疗各种并发症。

二、发作间歇期的治疗

1、注意事项

- (1) 对诊断明确的癫痫患者即应开始积极治疗。
- (2) 药物选择参照癫痫发作类型和治疗后的具体效果而定，一般自最低治疗剂量开始，逐渐调整剂量至能控制发作而又不出现毒性反应。
- (3) 为了减少发生副反应的机会，最好只在分别单独应用达最大耐受剂量而无效时才合并用药。
- (4) 药物的更换应逐渐过渡，更换期间可先在原用药物上加用新药，然后逐渐减少及停止原用药物。
- (5) 治疗应长期不间断地进行，至完全控制癫痫发作达 3 ~ 年后方可考虑逐渐减量或停止。
- (6) 突然地调换药物或停药可导致癫痫持续状态，应予避免。

2、抗癫痫药物的应用

对大发作或局限性发作的病人，可依次选用苯巴

比妥，苯妥英钠，米苏林，苯巴比妥加苯妥英钠，苯妥英钠加米苏林；小发作病人可依次选用苯巴比妥，乙琥胺，苯琥胺，三甲双酮。精神运动性发作病人可依次选用苯巴比妥，苯巴比妥加苯妥英钠，苯妥英钠加米苏林。这些药物每日均应分成2至4次服用，仅晚间睡后发病者可临睡前口服。发作有规律可循者，可在预计将发作前暂时加大剂量。应用上述主要抗癫痫药物治疗尚不满意时，可加用安定或利眠宁，但剂量需较一般临床作镇静剂应用时为大。对易因情绪紧张而诱致发作或情绪不稳、兴奋躁动的患者，可合并应用氯丙嗪，但剂量不宜过大。其他曾应用于治疗癫痫发作的药物尚有溴化物、咖啡因、醋氮酰胺和苯乙酰脲（phenurone）等。近年问世的抗癫痫药有氨基甲酰环氮己三烯（tegretol），苯磺酰胺二氧四氢噻嗪（sultni-amine）和二丙基醋酸钠（depakin）等。一般抗癫痫药物均有不同程度的镇静作用，初服时较明显，继续服用后则镇静作用减轻。一部分病人出现轻度过敏反应（如发热、皮疹），可暂时停药观察，必要时于反应消后仍可慎试用，如再次出现反应，则需换用他药。多数药物在剂量超过病人耐受程度时，出现共济失调、眼球震颤等神经症状，只须及时地适当减量，均能自行好转。少数病人发生巨幼红细胞性贫血，可加服叶酸，无需停服原用药物。出现剥脱性皮炎、粒细胞缺乏症等严重反应时，应立即停药并采取相应措施，以后绝对不能再用。在治疗过程中须随时警惕出现此种严重反应的可能性。

3、中医药治疗

中医认为癫痫的发生，主要由于痰蒙心窍所致。间歇期治疗的方法是豁痰开窍。可选用：

(1) 温胆汤加减：半夏、茯苓各 9 克，陈皮、远志、石菖蒲各 4.5 克，枳实、竹茹各 6 克，甘草 3 克（也可简化改用二陈丸，每日两次，每次 4.5 克，与白金丸每日两次，每次 4.5 克，共同服用。如体质虚弱，可采用白金丸与河车大造丸同服，每日各 9 克）。

(2) 青黛 0.3 克，硼砂 1 克，胆星 1 克，山药 1 克，水牛角 0.6 克，研末后，一次吞服，日服 2 至 3 次。

(3) 新针治疗，每日或同日进行，选用风池、风府、百会、印堂、鸠尾、曲池、内关、合谷、后溪、通里、三阴交、太冲等穴，强刺激。

中医治疗甚为安全，对部分病人有一定效果，可长期应用。特别对于有肝、肾功能损害不能长期服用抗癫痫药物的病人，更为适宜。

三、手术治疗

经长期服用抗癫痫药物无效，病人因反复发作以致影响正常工作及生活时，如多次脑电图检查证实在一侧大脑半球的可代偿区有固定的局部癫痫放电灶，可手术切除这个部位的大脑层。在作手术后再继续进行药物治疗，约有半数左右的病人可望得到满意的控制。

症例治验

例一

【辨证】肝火痰热，挟风内扰，蒙闭心窍。

【治法】清肝泻火，化痰宣窍，熄风止痉。

陈皮3克，法夏6克，南星6克，化皮6克，柴胡3克，黄芩3克，青黛1.5克，芦荟1.5克，西党参9克，白术6克，干姜6克，当归9克，钩藤9克，炙黄芪15克。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】白××，女，32岁。病者主诉患癫痫症已十余年。每发作前如猪羊啼叫一声，随即昏仆在地，不省人事，口吐白沫，两目上视，手足抽搐，二便失禁。严重时每日可发作数次，一般发作持续数分钟至三十余分钟，醒后感觉体疲乏力，脉弦数而滑，舌苔黄腻。证系肝火痰热，挟风内扰，蒙闭心窍。治宜清肝泻火，化痰宣窍，熄风止痉。诊后投以上方剂前后略作加减，共用药五十余剂，久病得除，健如常人。追访10年之久，未再复发。

按：方中青黛、黄芩、芦荟、柴胡清肝泻火；陈皮、法夏、南星、化皮可化痰开浊；前人有曰“脾为生痰之源”，故配以党参、黄芪、陈皮、白术补脾益气，一可断其生痰之源，二可缓青黛、芦荟苦寒折胃之弊；取其当归、钩藤熄风通络；《金匱》提出“病痰饮者，当以温药和之”，据此配以干姜，协法夏、南星、化皮

等味温化痰浊。方中药寒温虚实并举；确符“痫”症顽杂之说，故临床用之得以获效。然此乃顽杂之病，决非1—2剂即能治愈，必赖守方久用，痫痰方可获愈。

例二

【辨证】肝火偏盛，火劫生风，风动痰升，内扰神明。

【治法】清肝泻火，熄风涤痰，镇心安神。

白附子6克，制南星9克，法夏9克，全蝎3克，礞石9克，沉香3克，龙骨30克，牡蛎30克，建菖蒲6克，琥珀3克，瓜蒌15克，甘草3克。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】邵××，男，6岁。患儿出生1岁后，一日突发神志不清，昏仆在地，肢体抽搐，口吐涎沫，其后有时能日发十多次，常见头部跌伤，门齿已全部脱落，患儿甚为痛苦，家长多年为之担忧。临床诊断为癫痫，在当地久经治疗，未见明显效果。此次诊前，时值病作，突然倒地，不省人事，口吐白沫，双目凝视，两手抽搐，持续约15分钟方才醒来。醒后神疲乏力，面色无华，舌质红，苔黄白腻，舌根稍厚，脉弦滑有力。脉症合参，此乃肝火偏盛，火劫生风，风动痰升，内扰神明。治当清肝泻火，熄风涤痰，镇心安神。投以上方剂，连用12剂，病情遂见好转，由每日发作十余次，减少到每日发作1—2次，且每次发作时间亦见明显缩短，脉转弦细带数，舌质稍红，苔转薄黄，根部腻苔已除。于上方中加入人参须3克，以扬正气，再连进

病十余次。表情痴呆，面色萎黄，营养欠佳，身体虚弱，家长携扶来诊。脉弦滑，舌苔薄白稍腻。诊后即嘱其服用上方剂，连服两个疗程，癫痫病获愈。追访三年，未见复发，身体健壮，已如常人。

例四

【辨证】痰阻壅滞，复因气逆，痰随气升，上闭清窍。

【治法】降逆豁痰，开窍醒神。

生姜 9 克，生白礞 9 克

【服法】上药用木棒共捣为糊状，加水适量，于发作时频频灌服。

【疗效】刘××，女，7岁。患儿突然昏倒，迟迟不见醒来。其口吐白沫，四肢僵冷，口噤握拳，气壅息粗，喉中痰鸣。舌苔白腻，脉沉而滑。急投以上方剂。频灌，时许，患儿醒来如常人，即去玩耍。

按：此姜礞汤主要用于癫痫发作常迟迟不见苏醒者，即用于实证痰厥者为佳。减少病人由于发作持续时间长而遭之较大痛苦。其方中生白礞性味酸寒，燥湿祛痰；生姜性味辛温，下气祛痰；二药合用，行气豁痰，神醒而窍开。

例五

【辨证】痰迷心窍，心神浮越。

【治法】解郁化痰，清心安神。

白樊 60 克，郁金 60 克，朱砂 15 克，琥珀 30 克，苯妥英钠 30 片。

【服法】共为细末，和匀，分为30包，每日一包，分两次服。

另以白夹竹桃叶1日3片，水煎代茶饮用（间断服之）。

服药期间与停药后数月内忌食猪肉、猪油。

【疗效】张××，男，16岁。患者5岁时患过“乙脑”，治愈后未留后遗症。至11岁时开始发作癫痫，每发前两手发麻，心中难受，约持续6～7秒钟而转入神志不清，面色苍白，两目上吊，口吐白沫，有似羊叫声，约持续3～4分钟方苏醒，感觉全身疲困。一般情况下半个月发病一次，长者2～3个月发作一次，短者一日可发作2～3次，多在夜间发作。经用苯妥英钠、针灸、单验方等治疗，发作如故。诊后嘱其服用上方剂，服药3个月，病获痊愈。服药期间仅发作两次。停药后已追访一年余未见发作，其间曾两次生大气而未犯病。

除上病例，另治三例癫痫患者，用法如上，亦获治愈。

按：癫痫即为中医之癇证。现代医学属神经系统疾患。中医治疗着重化痰，清心，镇惊，安神。上方剂乃系治该病的主方之一，此方出自《外科全生集·马氏经验秘方》，名曰癇痛白金丸、白玉化痰丸等。其方中之白礞入脾化痰，郁金入心凉血活血开窍，另增琥珀、朱砂镇惊安神。加以小量苯妥英钠使达到预防发作的作用。其方共奏化痰开窍、镇静安神、行气活

血、抗惊痛之作用。茶饮之白夹竹桃叶，具有明显的强心作用，其叶的作用较夹竹桃其它部分的作用强，且还有抗癫痫功效。民间亦有用白夹竹叶3片，配以生铁落60克水煎治疗癫痫验方。然该品有一定的毒性，故不可连续服用及多服、久服，是当注意。

例六

【辨证】风痰壅滞，上扰清空，蒙闭心窍。

【治法】驱风化痰，通经开窍。

菊花9克，钩藤9克，薄荷3克，胆南星3克，姜半夏3克，广陈皮3克，云茯苓9克，僵蚕9克，竹茹9克，天竺黄3克，宣木瓜9克，丝瓜络9克，炙甘草3克，淡竹叶9克（上为儿童量）。

【服法】水煎服，每日一剂。

痰热盛可加炒黄芩3克，地龙9克等；抽搐后肢体麻木者可加忍冬藤9～12克，桑枝9～12克，鸡血藤9～12克等；头目晕眩，躁而不安可加龙齿12～15克等；热症不显者可酌加羌活3～9克，独活3～9克等；如兼有消化不良可酌加麦芽、谷芽、苡仁等适量。

【疗效】陈×，男，5岁。患儿足月顺产，产后发育尚可。自一年前开始，发生四肢无力，行走不便，经过治疗，其病获愈。随后又见体弱食差，继而发作癫痫。前来就诊时，正值癫痫发作，见其两眼斜视，四肢抽搐，口吐白沫，面色苍白，神志不清。其舌红，苔黄腻，指纹红。诊后即投以上方剂。前后共诊5次，其方

略作加减，共服药 24 剂，诸症平复。其后家长致信感谢，云患儿病已痊愈。

周××，男，7岁。其儿患癫痫病已两年之久，每次发作即突然倒地，不省人事，两目斜视，四肢抽搐。近些时来发作频繁，每日达 6～7 次之多，患儿头部多处伤痕，口渴思饮，苔黄，指纹红。诊后即用上方剂治之，前后加减共投药 22 剂，其病悉除。

例七

【辨证】风痰内聚，郁久化热，热灼肝阴，肝阳上亢。

【治法】镇肝熄风，滋阴降火，豁痰定痉。

生代赭石 120 克，灵磁石 60 克，金礞石 15 克，全蝎 9 克，陈皮 9 克，法半夏 9 克，淡竹茹 9 克，胆南星 9 克，生甘草 6 克。

【服法】水煎服，每日一剂。

【疗效】孙××，男，18岁，学生。患癫痫已十余年，曾经用多种药物治疗而不效。近来病情又有发展，每日发作，少则一至二次，发作时突然尖叫，两目上吊，手足抽动，口吐痰涎，患者极为痛苦。诊见患者表情迟呆，言语不爽，记忆力差，其大便发干，脉沉弦有力略数，舌质略红，苔黄白腻。诊后投以上方剂。服药一周，发作渐减，仅发两次，且症状明显减轻。舌苔减，脉沉弦。嘱其照原方继续进服，共进二十余剂，其症发作得以控制。停药已数年，其间仅见发作一次，而症状甚微。其记忆力较前大有好转，并能做些家务劳

动。

例八

【辨证】寒郁化热，心阴气虚，肝风内动，挟痰上逆。

【治法】化痰熄风，滋阴定痉。

天竺黄 15 克（另碎研细），沉香 9 克，天冬 60 克，白芍 90 克，茯神 120 克，炙甘草 18 克，远志肉 60 克（蒸熟），麦冬 60 克（去心），旋复花 45 克，苏子 30 克，制香附 90 克，姜半夏 30 克，皂角荚 60 克（去黑皮、去子炒酥）

【服法】共为细末，以淮山药适量粉糊和水为丸，朱砂为衣，每次服 9 克，每日 2~3 次。

【疗效】蔡××，男，25 岁。患者癫痫症已有 9 年之久，曾多方求治而效果不佳。诊前仍坚持每天服用苯妥英钠，然每隔 10~20 天仍发作一次，发作时先有尖叫，其后昏倒，口吐白沫，手足抽搐。诊后即投以上方剂一料，病者服用月余，其间病症未再发作。再续配一料，嘱其继续坚持服用，药尽病除，随访近两年，情况良好，状如常人，癫痫未再发作。

感染性精神病

所谓感染性精神病并不是一种特殊的疾病，而是指由于全身性或脑部感染引起的精神方面的并发症，所以它只是由于各种原因的感染引起的一组症状群，其主要表现是意识障碍，与中毒性精神病类似。

慢性全身性感染有时会产生类似神经衰弱的症状；慢性的脑部感染（例如梅毒性脑膜脑炎）主要表现智能障碍的症状。

在此主要叙述由急性或亚急性全身性感染引起的精神障碍，脑部感染（例如脑炎、脑膜炎等）引起的精神障碍将在各有关章节中叙述。

【病因病理】常见的感染性疾病如败血症、流行性感、肺炎、尿路感染、伤寒、原因未明的发热等，均能引起感染性精神病。

至于感染为什么会引起精神障碍，目前尚未完全搞清楚。由于体温升高、细菌的毒素或由于新陈代谢亢进，体内消耗增加，使某些营养物质缺乏，某些代谢产物蓄积以及脑血循环障碍等都曾经被视为原因，进行过很多讨论。目前有人认为，由于维生素B族的缺乏而影响脑的糖代谢可能是产生感染性精神病的原因之一。

儿童及老人较易因感染产生精神症状，其机理尚待进一步研究。感染性精神病患者的脑部多无特异性病理形态学变化，故较难从这方面来说明其发病机理。

【临床表现】 本病的临床表现除感染本身的症状及体征外，在精神方面主要是不同程度的意识障碍。如前所述，意识障碍可在发热前或热退后出现，但多数出现于发热期。一日之间症状轻重常有波动，一般则夜间较重些。

意识障碍的轻重主要根据病人对周围环境的认识及对客观刺激（包括言语问答）的反应来衡量。较轻的病人表现昏昏欲睡，注意力不集中，不能很好地回答问题，只能对较简单的问题或要求（例如要他张口，伸舌等）作出正确的反应，对较复杂的问题或要求往往表现茫然，好像没有听到或听不懂的样子，有时要重复地大声询问才可以获得一些反应，病情进一步发展，可以进入谵妄状态。也可逐渐进入昏睡、昏迷。

谵妄的病人除对周围环境不能正确认识、对客观刺激不能适当反应外，还有大量的错觉和幻觉以及相应的情绪及行为紊乱。例如病人可以把墙上的灯影看成可怕的怪物，因而发出恐惧的叫声，表现逃避或反抗的行为。有些病人好像看见空中或床上有什么东西似的，乱抓乱摸。谵妄的病人白天比较安静，常表现昏昏沉沉，夜间比较吵闹，有时病人仅表现卧床喃喃自语，没有其它动作，对周围刺激也毫无反应，并可由此逐渐进入昏迷。谵妄病人生活完全不能自理，大小便常解在床上。在其它体征改善时，病人夜间睡眠的改善常为谵妄即将好转的征兆。

在急性感染的恢复期，可以出现一些类似神经衰

2、聚乙醛（副醛）5 毫升。

3、氯丙嗪 50 毫克。

4、氟呱啉醇 5 毫克。

5、苯巴比妥钠（鲁米那）或异戊巴比妥钠（阿米妥钠），前者一般剂量为 0.1 克，后者为 0.5 克。

兴奋骚动时，病人对服药或注射往往不能合作，故有时须强制进行。日间有轻度骚动不一定要处理，以上安定药物首先考虑在夜间使用，保证病人睡眠，并可减少对周围人的影响。当病人兴奋骚动基本控制后，应尽量减少用安定药物。如病人已能口服，可给予利眠宁 10 ~ 20 毫克，每日 3 次；或安定 2.5 ~ 5 毫克，每日 3 次口服。

如病人表现倦怠、昏睡，不应给安定药物。

有的病人因为受错觉、幻觉影响，可以表现紧张恐惧，有时会冲门或跳窗而出，不肯卧床，因此易造成伤害。此时除使用适量安定药物使之镇静外，尚应加强护理照顾，室内光线不要太暗，布置要尽量简单，减少易引起错觉的阴影或陈设。接触病人时避免突然发出大声，以免引起病人的恐惧紧张。

二、补充营养

有精神症状时往往不能很好进食，但体内消耗却因发热及兴奋骚动而较平常增加，因此必须注意补充充分的营养、水分等，以利疾病好转。如前所述，维生素 B 族的缺乏在感染性精神病发病中可能起相当作用，因此必须注意充分补给，特别是 B1 及烟酰胺的补充。拒食

的病人可通过鼻饲或静脉途径补充，安定药物亦可加入鼻饲流汁中。

内脏器官疾病引起的精神病

肝脑综合症

又名肝脑病变、肝性昏迷（未进入昏迷时则称肝昏迷前期）等。

【病因病理】本病多见于肝硬化以及门静脉高压症施行门腔静脉分流术、脾肾静脉吻合术，或建立侧枝循环的患者，其次为病毒性肝炎、急性黄色肝坏死、肝癌和胆道疾病损害肝实质等的患者。

发生本病的机理尚未得到肯定的结论，但一般认为肝功能障碍造成血氨增高及氨基酸代谢异常可能是引起本症的主要因素之一。大量消化道出血、感染、大量摄入蛋白质、腹水穿刺放液、长期应用利尿剂、饮酒等，是促使本症发生和症状加剧的常见诱因。

【临床表现】精神症状大致可分三类：

一、性情改变

可出现于早期，病人变得情绪不稳、激动、易怒、欣快多言、失眠、不能静卧或嗜睡不起。有的病人对自己的迫切问题漠不关心，有的表现过分焦虑不安，猜疑重重甚至有被害妄想和幻听。这些症状可以持续数月甚至近一年，亦可能同时存在极轻度的意识障碍。

二、遗忘症状群

多见于意识模糊而转清楚之后，但也有的在早期即可出现。最初为近事遗忘，渐而及于远事，偶尔有错构及虚构。发展至严重时则完全呈痴呆状态。

三、意识障碍

最为多见，开始时有恍惚状态，衣服鞋帽穿错，目光无神，错认，注意力不集中。随之可有意识模糊、嗜睡、深睡样的木僵状态或进入昏迷；有时呈谵妄状态，兴奋骚动、幻觉和言语错乱等。

上述症状往往先后或同时出现，其中意识障碍在多数人身上可有不同程度存在。

神经系统体征可见有一侧或双侧不很固定的锥体束征，肌张力增高，腱反射亢进，踝阵挛。此外有步态不稳，两手摸索和扑翼样震颤，口齿不清，大小便不能自理，瞳孔扩大，对光反应迟钝，眼外肌麻痹，眼球震颤和肌痉挛等。这些体征常伴随意识障碍出现，在意识清醒后也可遗留一段时间。

【诊断】 肝病患者如果出现有精神症状，并见有意识障碍和神经系统体征，必须考虑到本症的可能性。下列各点有助于明确诊断：①血氨高于100%微克则本症可能性极大，但低于此数亦不能除外；②脑电图检查无例外地可见弥漫性阵发性高电压慢波；③肝功能检查亦可供参考，但正常时也并不能排除本症；④有无氨基酸尿。另外如有严重肝病体征如“肝臭”等，显著侧枝循环形成，曾施行短路环手术等，亦可作诊断参考。

【防治】 本病预后取决于肝脏病变的程度。治疗

的主要环节在于祛除诱因，降低血氨，保护肝脏，具体方法参考“肝昏迷”。对于精神症状的防治，应避免使用巴比妥类和氯丙嗪等药，如无明显意识障碍而有兴奋躁动和不眠，可给予利眠宁 10 毫克，1 日 3 次；或安定 2.5 ~ 5 毫克，1 日 3 次；或泰尔登 25 毫克，1 日 2 次口服；不能口服者可肌注，利眠宁一次量 25 毫克，安定一次 10 毫克或泰尔登一次 30 毫克，1 日 1 ~ 2 次。也可针刺内关、神门、太冲。有幻听可针刺听宫、翳风，用强刺激或加电针，1 日 2 ~ 3 次。

肺脑综合症

包括肺气肿脑病，肺源性脑病。多发生于因患各种慢性支气管或肺部疾患的后期产生不同程度肺气肿的患者。当肺功能不全时，因发生缺氧、二氧化碳潴留以及代谢紊乱等从而引起本病，并常同时伴发肺源性心脏病。在肺源性心脏病出现心力衰竭时，又可加剧肺功能障碍而诱发加重肺脑综合症。

多数病人发病的诱因是肺部感染，发病年龄都在 40 岁以上。

【临床表现】多数病人在肺部疾病严重、肺功能障碍时而伴随出现神经精神症状，但少数病人的神经精神症状可在肺部疾患减轻时出现。其临床表现大致可分为三种类型：

一、类精神分裂症型

这类病人开始时意识障碍不出现，仅表现为精神分

水肿。密切注意电解质和酸碱平衡。

为改善脑缺氧，可用尼可刹米 4 ~ 8 支加入 5% ~ 10% 葡萄糖液 500 毫升由静脉缓滴，亦可用细胞色素 C30 毫克、三磷酸腺苷 40 毫克、辅酶 A100 单位、维生素 B₆100 毫克一起加入 10% ~ 25% 葡萄糖液 500 毫升中静脉滴注。

对于精神症状治疗，一般使用利眠宁、安定等。如有兴奋骚动、妄想、幻觉等症状出现而无意识障碍时，则需给氟丙嗪、泰尔登或奋乃静等一类药物控制，但要注意剂量，以免病人产生严重嗜睡。如病人的意识障碍突出时，应禁止使用上类药物，禁用聚乙醛、吗啡等类药物。对昏迷的病人，可给谷氨酸钠、钾三：一合剂 23 克加入 5% ~ 10% 葡萄糖液中静脉滴注，如经治疗后意识清楚，仍留有精神症状时，可精以安定或氟丙嗪等类药治疗一阶段。当本症基本好转后，应及时给予病人思想安慰，使病人树立战胜疾病的信心。

尿毒症时的精神障碍

精神障碍常是尿毒症最先出现的症状。当肾功能衰竭引起氮质血症时，病人常有轻度的意识障碍，同时，可有兴奋不眠，欣快多言，或有猜疑妄想、幻觉、行为紊乱；可以一时清楚，一时糊涂，当出现酸中毒或有电解质紊乱时，病人可由淡漠、嗜睡、意识模糊而进入昏迷；也可因继发感染出现高热谵妄而进入昏迷。

尿毒症又常因伴有高血压症而出现高血压脑病症状，表现为头痛、恶心、呕吐、躁动不安、谵妄、昏睡和癫痫样发作。此外，神经系统体征有腱反射活跃、踝阵挛，有时见到扑翼样震颤和锥体束征。一般体征常见有面色苍白、口炎、呼吸有氨味和酸中毒大呼吸等。

诊断主要依据病人有肾脏疾患史，有肾功能衰竭，同时出现精神症状并有意识障碍，血液化验有非蛋白氮增高（主要是尿素氮和肌酐），加上各种肾功能试验均明显减退时，应考虑本症。脑电图异常亦有助于诊断。

治疗方面主要在于控制尿毒症，使躯体情况好转，则精神症状也会随着好转。至于治疗精神症状，如病人未出现意识模糊，有一般兴奋不眠，可给利眠宁 10 毫克，1 日 3 次。如有猜疑、妄想、幻觉和行为紊乱，可给服氯丙嗪 25 毫克，每日两次或 3 次；或奋乃静 2 毫克，一日两次。上述药量如还不能控制精神症状，可适当加大药量，但以不使病人发生严重嗜睡为限。如病人出现意识模糊，则不应使用上述安定剂。

产后垂体功能低下症引起的精神障碍

本症因产后大出血，垂体发生缺血性坏死，引起体内各种内分泌失调而伴发精神紊乱。精神症状主要有淡漠、迟钝、忧郁、焦虑、疑病、嗜睡、言语减少、动作缓慢等，亦可有幻觉妄想及精神模糊状态。

诊断本症除有产后大量出血、停经、消瘦、性欲减

退、乏力畏寒、厌食呕吐、乳房萎缩、毛发脱落、贫血苍白等典型病史及体征外，实验室有关内分泌检查亦可助诊断。本症引起的精神障碍，有发作性特点，波动性很大，当躯体情况改善后精神症状亦可完全消失，自知力也完全恢复，此点可与更年期精神病及其它类型的精神病相鉴别。

治疗本症主要在于纠正内分泌失调，辅以支持和对症治疗。所伴发的精神症状一般只需用利眠宁、安定等治疗，如有行为紊乱可用奋乃静 2 ~ 4 毫克，一日两次。对这类病人，应慎用氯丙嗪、泰尔登等一类药物。若使用不当，很可能引起严重休克，甚至死亡。病人如处于意识模糊状态不应使用安定剂。

系统性红斑狼疮引起的精神障碍

系统性红斑狼疮的患者可以出现精神症状，常酷似精神分裂症，可表现为焦虑不安，猜疑、幻觉、忧郁、木僵及行为紊乱等。在急性期可出现意识模糊症状群，严重时可导致昏迷。

本病以青年女性多见，如发现青年女性精神病患者有不规则发热、关节疼痛、皮肤红斑损害及多发内脏器官损害者，应考虑本病的可能性。

对于本病引起的精神症状治疗，可以用氯丙嗪或泰尔登 25 ~ 50 毫克，一日两次；或奋乃静 2 ~ 4 毫克，一日 2 ~ 3 次。当躯体状况改善后，精神症状亦可逐渐好

转。

中毒性精神病

中毒性精神病是指由于化学有毒因素造成中枢神经系统功能紊乱或器质性损害，临床表现以精神症状为主的一组疾病。

几乎任何毒物都对中枢神经系统有一定影响。临床上较为常见的中毒性精神病是由重金属（铅、汞、锰等）、有毒气体（一氧化碳、硫化氢）、药物（阿的平、莨菪碱类和溴剂等）、有机化合物（二硫化碳、苯、硝基苯、汽油、有机磷农药等）和误食毒蕈、莽草等有毒植物所造成的。中毒性精神病的发生除了取决于毒物的理化性质、摄入的数量和速度外，同机体的原先健康状况、对药物的敏感程度和神经系统功能的稳定性也有很大关系。所以，即使在同样的环境内中毒，有的发生了中毒性精神病，有的却没有精神活动的改变。

各种中毒性精神病的临床表现虽有相对特异性，但总的而言，大同小异。大量毒物摄入所致急性中毒，表现为意识模糊症状群。少量毒物反复摄入所致慢性中毒，表现为类似神经官能症的脑衰弱症状群。严重的急、慢性中毒也可产生痴呆症状群。

中毒可能作为一种诱因促发其它精神病。发病初期

头痛、健忘等中毒后衰弱症状。

在清醒期后出现精神症状，常是急骤的。如患者在返家或去单位时，突然迷失路途，到处乱走，或突然胡言乱语，出现一些莫明其妙的行为。病情发展迅速，患者在短期内即丧失了工作和料理生活的能力。患者言语杂乱，词不达意，不会穿衣着袜，不会主动进食，大小便失禁，意识模糊，定向错误，思维不连贯，动作减少或表现摸索、攫抓等无目的行为，违拗、抗拒，注意涣散，领悟困难，近事、远事记忆均明显减退，虚构、错构，理解、判断和计算力严重缺损，甚至不能分辨男女，记不住自己的年龄。重症患者的智能障碍更为严重，只能讲几个片断的词，无法进行交谈。情感反应平淡，少数患者有短暂的情绪激动，因而冲动伤人，撕衣毁物。个别患者可有片断幻听幻视。

神经系统方面以锥体外系体征最为突出，患者呈假面样面容，表情刻板，肌力齿轮样增高或呈去大脑样强直，步态不稳，共济失调，甚至不能站立和行走。腱反射亢进，不对称，常可引出阳性锥体束征。部份患者有偏瘫、失语和失用等症状。

患者多汗，皮肤易发生水疱或灼伤样皮损，肢体浮肿，周围循环不良。

【诊断】根据急性中毒史，经过一段间歇清醒期出现以意识障碍和智力下降为特征的临床征象、锥体外系等神经系统体征，本症诊断并不困难。此外，实验室检查中，脑脊液可能有蛋白增加，脑电图可见A节律抑

制或消失和以前半球为主的对称弥漫的高幅慢波，此种变化常与病情演变相平行，亦有助于诊断。至于测定血中一氧化碳浓度，病发后已无实际意义。

【防治】本病的根本预防途径是防止一氧化碳急性中毒。一旦发生急性中毒，应及时抢救（详见“职业中毒”）。急性期处理之恰当与否，对后发神经精神障碍具有一定影响。有人主张在中毒后的清醒期内，予以烟酸、咖啡因和高热量高维生素饮食，以改善血循环，可能防止或减少精神症状的发生。

中医药对于本病有较好疗效。根据中医辨证多为痰浊蒙闭心窍，采用涤痰开窍法，方药如下：竹沥半夏 15 克，胆南星 15 克，天竺黄 15 克，煅礞石 30 克，瓦楞子 30 克，枳实 15 克，青陈皮各 9 克，郁金 9 克，生大黄 15 克，石菖蒲 9 克。此方每日一剂，30 剂为一疗程。必要时继服数疗程。

苏合香丸（中药成药），每次 1 ~ 2 粒，日服两次。与上方同服。

氯酯醒 1 克静脉滴注，或 0.1 ~ 0.2 克口服，每日 3 次， γ -氨酪酸 1 ~ 2 克静脉滴注，或 0.5 ~ 1 克口服，每日 3 次，也可能对改善病情有所帮助。

对症和支持疗法也很重要。必须保证营养和水分的摄入，保持水及电解质的平衡，拒食患者应予鼻饲和输液。烟草酸等维生素 B 族和维生素 C 可能有利于病情恢复。对卧床不起、肢体僵硬的患者须注意保暖，作按摩和被动运动，以防止肢体挛缩、变形而影响功能恢

自得；错觉幻觉丰富，以幻视为主，内容鲜明生动，如火花飞耀、动物窜行；有时则见惊恐场面，患者常作出逃避或攻击假想对象的举动，因而发生自伤和伤人。有些病人在病愈后对发病可部分回忆。

患者诉说头昏、头痛、口干烦渴、身热无汗、视物模糊和排尿困难。检查可见瞳孔扩大，对光反应迟钝或消失，面部及胸部皮肤潮红灼热，口腔干燥，心率增快，血压轻度升高；部分患者发热，体温可达 42 度；腱反射亢进，共济失调，可见指划样或舞蹈样动作，甚至全身抽搐。

实验室检查除血钾、血钙可能降低外，无其它阳性发现。

本病预后良好。本类药物的致死量估计在 100 毫克左右，远高于一般中毒量，因之罕见死亡；如有发生，多因伴有其它疾患或并发症所致。躯体变化通常在 2 至 7 天内恢复正常，精神症状亦随之消失，一般无后遗症和精神障碍存在。如毒物摄入过多，治疗延误者则病情恢复较慢。

【防治】本药物的应用需由医务人员指导，除特殊情况（如用作麻醉），剂量不宜过大，严禁滥用。普及药物知识，使病家了解药物性能，加强野生药材的管理，防止孩童误服等均属必要的预防措施。

急性中毒时应以 0.5% 高锰酸钾溶液洗胃及 50% 硫酸镁 30 毫升导泻；静脉输入大量葡萄糖盐水，补充维生素。

一般而言，上述措施足以使病情恢复。只有在病人陷入深昏迷，或兴奋吵闹过剧、症状维持过长时可考虑应用拮抗剂毒扁豆碱。可予毒扁豆碱 2 毫克静脉注射，15 分钟后如仍不苏醒可重复注射，一般均能在 1 ~ 2 次注射后意识恢复，停止躁动。但该药在体内分解甚快，苏醒后还应以维持量：静脉注射 1 毫克，每小时 1 次；或口服 2 毫克，每小时 1 次，连用 3 小时。同类的新斯的明、毛果芸香碱之类因不易进入血脑屏障，中枢作用不理想。

生甘草 120 克或槟榔 60 克，煎服，也有一定解毒作用。

在支持与对症处理方面，如兴奋过剧可选用聚乙醛 5 毫升肌肉注射，或异戊巴比妥纳 0.5 肌肉注射；神志不清时须防止自伤或伤人；体温过高时作物理降温。此外应加强护理，预防并发症。

药物治疗过程中出现的精神障碍

某些药物在治疗剂量的给药过程中，可出现精神障碍。这些精神症状常被视为药物的副作用，以往记载多的为阿的平、激素类（促皮质激素及皮质酮）、合霉素及抗痨药物（异烟肼）应用过程中所出现的精神障碍。

现就激素类扼要介绍如下：皮质激素所致的精神障碍并不多见，服用皮质激素后，病人常自觉情绪高涨，精力充沛，言行增多，兴奋失眠。其中，仅极少数患者

的兴奋程度逾越正常范围，忙忙碌碌，易激惹，好与人争吵；也有极少数病人出现焦虑。停药后，大部分病人精神症状消失，少数病人精神症状可迁延较久。治疗时，可投用小剂量氯丙嗪或泰尔登，一般为 25 ~ 50 毫克，1 日 3 次口服。激素的继续应用问题，应视躯体疾患及具体情况而定，如躯体情况不允许则不强调停用激素。



第十三章

性 变 态



性变态与精神病

所谓的性变态，乃是指那些性行为的方式与通常性交的方式相异，且被当作满足性欲的主要或唯一的方法。这种变态（性变态）包括以身体其它部分（而不是性器）当作满足性欲的主要来源，或者性活动不是集中在性器以宣泄性欲。

性变态是不是一种精神病的表现？这个问题没有一定的答案，要看其变态程度和精神状况。

何况，性变态行为所违背的社会规则是相当复杂的，它受着一个人身处的文化所限定和社会所容纳的行为标准所左右，其本身也没有固定不变的含义，所以私人的性行为与公众所许可的行为之间经常存在着冲突，以致于变态的意义无法十分明确。

有人以传统界限为依据，划分出几种性变态方式，这些方式如果是由于精神因素而发展严重的话，当然是一种疾病——属于心理（精神）范畴的疾病。

这些变态的方式归纳起来有下而几种：

口对性器（口交）；性器对肛门（肛交）；女子淫狂（或慕男狂）；男子淫狂（或求雌癖）；乱交、乱伦；手淫、兽奸；恋物癖、恋童癖、窥淫癖；露阴癖或露阳癖；易装性欲；同性恋等。

但以这样的方式划分性变态也不够准确，而且多少容易导入错误的观念中。例如：假如口对性器的接触如果是发生于两位异性之间，且是刺激性欲的一种方法而不是从头到尾都是这样，那么大多数的精神治疗家便不以为这是一种性变态。同样的，把手淫作为一种性变态也不大可以成立，因为手淫的对象或目标只是本身，而所谓性变态大多是指性欲方式发生于异性或同性之间的。

以理论解释性变态：

依照海立克（1967）的解释，性变态的动机有三项：

（一）在发育时发生了某种引起以后敏感的事情，因此对异性爱产生了恐惧。

（二）对禁忌或刺激的性行为发生了欲望，亦即渴望新奇的变化。

（三）由于与双亲不正常关系的影响，而导致变态或偏差的发生。

精神分析的理论家认为，性变态之造成是由于一个人在适应心理发育的各阶段中，没有正常地进展所致。在性心理发展中，开始是婴儿期散漫的性欲，最后（理想上）是成人时期集中于性器的异性爱关系（Apperson and McAdoo, 1968）。

变态的行为通常（窥淫癖与露阳癖或露阴癖的方式却时常可能发生例外）有一种特殊的发泄方式。而每一种障害成变态的成因随着每一个人情绪与行为经验的性

质不同而各有差别。而有人认为，变态越是奇特，则一个人的适应越是有病态的地方。

同性恋

常满足性欲的对象不是异性而是同性，便属于性变态的范围，这就是所谓男性同性恋、女性同性恋。

男性同性恋

从历史上来看，过去每一种文化中男性同性恋的多寡是随着每一个时代而不同的。有人辩称（男性）同性恋是一种优越的生活方式，常常提到被允许存在于古代希腊中男性间的合法关系，然而要了解这个时代就必须记得早期的希腊社会之赞成同性恋，仍是历史上罕有的现象，而且这种社会习惯是源于男性较女性更优越的观念上。而女性是享受不到为人的幸福的。在当时，女人是为了繁衍后代，而且是男人取乐的对象。在那时候的文化下，任何种性冲动的发泄方式都是被允许的。

在男性同性恋当中有些人能够从同性恋与异性恋两种行为中获得快乐，得不到女性的对象时，暂时以同性恋取代，其实他们主要兴趣还是在于异性恋的关系。也有人不管对象是谁，总是喜爱一种满足性欲的方式，通常与作爱的对象（男性或女性）互相对换角色。

但更多的男性同性恋者，常是厌恶地躲避异性，渴望与同性或外表男性化的女人发生关系。他们满足性欲

女性同性恋

女性同性恋一直被理论家所完全忽视。这不仅因为女性同性恋的人被认为数目较男性同性恋的人为少，而且自古以来就认为女性不如男性，因此导致对她们的性活动漠不关心。而且，女性同性恋者较不容易被察觉，在寻求同性对象时较没有挑衅性，较少成为社会上的问题，而且即使在婚后她们的恋态行为也比較容易被掩饰。

在女性同性恋的关系中，一位可能负起男性的角色，另一位担任女性的角色，就好像丈夫与妻子的关系一样。男性同性恋者之渴望有一位巨大阴茎的同伴，正好像女性同性恋者之重视丰满美观的胸乳一样。根据毕伯的看法，“无论是何种性别的同性恋者都是在寻求补偿他们有缺乏的性功能，而要达到这个目的，使渴望与代表男性与女性的突出标志（阴茎与胸乳）发生奇妙的结合”。女性同性恋者较男性同性恋更可能保持长久的暧昧关系。不过她们的精神却停留在青春期的情绪阶段，因此好像男性同性恋者一样，容易引起像未成熟者所发生的无谓的争吵和嫉妒。

女性同性恋者可能由于以下两种原因之一而致不能正常发展与异性的爱。

（一）无法以一位男性来替代她原来热爱的女性对象。

（二）或由遇到成人的男性时感到焦虑，而退缩到

寻求只适于非常幼小儿童的性对象。

心理分析学的理论认为，男性同性恋者之所以感到焦虑，是由于对他们生殖器之无法隐瞒的知觉，这种知觉使得他们对自身真实性别没有了争论和自欺的余地。而女性由于没有男性的生殖器，因此只要易穿男装，表现出男性的特征与粗线条，便能否认了她真实的情况。这样否认自身是女性不只可能满足了潜意识里的欲望，而且可以阻退那些想要进一步发生关系的男性。当然，并不是所有女性的同性恋者都显出男性化来，或者公开将她们的幻想表现出来；女性同性恋者有些是对男性不信任，较喜爱女性的伴侣，可是从来不与那一种性别的人发生性方面的关系。

窥淫癖

在没有说明窥淫癖之前，我们必须先让读者了解，假如说利用视觉欣赏裸体是因为情绪障碍的话，那么我们社会中绝大部份的人必定都是变态的人了。依照理想，每一个社会最好都进步到一种精神成熟的状态，人们对肉体所感到的兴趣和热情，其程度刚好是日常生活中平常的部份。不幸，现代大部分的社会都与这种理想距离甚远。结果，观看裸体便成为有些人性变态的习惯；而对于我们大部分的人，却是整个异性爱行为中一种满足与刺激性欲的方式。

假如以观看裸体的异性为刺激性欲的主要方法，面

且以这种观看来取代性交的话，我们就认为它是一种窥淫癖。真正的窥淫癖者（最常是男性）常常以秘密窥视裸体的女性，达到兴奋的状态。就是这种行为中的施虐部份（即取得女性所不愿给予的东西）引起了性的兴奋，而且这种兴奋时常还另外有冒险窥看所引起的兴奋。

就儿童的窥淫癖来讲，这是由婴儿期进展到成人期性欲的一种合理的正常现象。因为这种行为对于在发育中的男性而言，是为了解开性方面的神秘，同时在他想像中，建立起他未来成人时所要担当的角色。因此在性方面比较开放的社会里，窥淫癖就大大减少了。当然有些国家、社会供给了一些窥视裸体的发泄地方（例如，低级的歌舞表演、着上空装的女侍、极短的迷你裙以及刊裸体照的杂志），不过这些都是得政府的允许，社会的赞同，因此缺少了非法的偷看时的冒险成份。

窥淫癖的成人是以观看他人的性交而得到满足，而且他的病态也比较复杂得多。他之引起性的兴奋可能主要由观看男性的生殖器与男性的性活动而获得，而观看女性的活动却是次要的来源。窥淫癖的人对女性有恐惧的感觉。当像窥看别人赤裸而没有注意时所引起的兴奋，使得他觉得自己真的比其他的人更诡计多端，同时又能够秘密而单独地经验到使人刺激、紧张而心跳的高潮。窥淫癖者最害怕的事情，是让对方察觉到他的行为，要求他发生异性间的关系。总之，窥淫癖者（即畅销文学作品《偷看的汤姆》所描绘者）是一位被动、而很少有危害行为的人。

社会制订了严厉的法令，惩罚那些危害儿童的性罪行，而且社会上的每一个人也都对这种恋童癖者采取极端嫌恶的态度。这种人一般被正常的公民所排斥，即使在监狱中亦被其他的监犯们所痛恨。

恋物癖

当性的刺激与满足是习惯由没有生命的对象而不是人所引起时便称这种习惯为恋物癖。恋物癖或恋物欲者通常都是男性，他们之违反社会有关性方面的传统习俗，是因为他们性的兴趣在于没有生命的物件上面，因此反而不注意正常的异性爱关系。恋物癖者所选择的物件常常是习俗象征热情的日用品，例如，女人的丝袜、内衣、内裤、乳罩、发夹等等。这些东西可能代表女性身体上的某一部份，或者可能是整个女性的象征品。因此恋物癖可能是为了发泄内心深藏的敌意，对象是使他遭受爱情挫折的爱人，或是针对所有的女性而发。

对一位恋物癖的人来说，睹“物”所以思“人”是因物件代表或象征了人或人体。例如，毛皮可能是阴毛的象征物，同时间接表示了正常性冲动的一部份或一方面的迷惑或神往。这些东西的本身可能会引起性的高潮，或者只是性关系前整个刺激中的一部份。

恋物癖也可能反应出施虐或受虐的欲望；它可能代表一种自贱与自损的倾向，因为这是恋物癖者在性行为中达到高潮所不可缺少的条件。也许罗兰德（Lordnd，

1950)所说的话是对的,他认为,恋物癖使得一个人免于沦为男性同性恋的人,同时也使他不能成为一个正常的人。由于恋物癖者专心于代表和象征性的东西,因此他设法躲避直接的异性爱关系。显而易见,恋物癖者的性生活太依重于幻想的兴趣,因此最常引起手淫的习惯。只是观赏女性的裸体照片或图画并不能使恋物癖者望梅而止渴,因为画片是象征的物品,因此只能暂时代替真实的事物。

露阴癖

男性将他的阴茎显露在女性的面前,或在女性的观看下施行手淫,都是为了使他自己相信他是一位男性,亦即他有一根阴茎,而且使他自己相信这件性器坚强、有力、能引起女性深刻的印象。假如有阴部显露欲望的人在他显露阴部时遭到别人的耻笑和嘲弄,或者被人完全不加理睬,那么他必定感到比死还要难过。由于有阴部显露欲的人会定期升高他的焦虑,因此他必须显露他的阴部,观看这种行为所引起的恐惧和震惊,以加强他肯定自己做人的价值。有阴部显露欲的人最常利用孩童满足他们暴露的欲望。

检查了有这种显露欲望的人后显示,他们的变态程度是非常厉害的。汉宁格(Henninger, 1941)研究分析了51个作这种猥亵性暴露的人,结果发现其中有14位经鉴定为情绪未成熟,10位为精神退化,8位是精

神病，另有4位是患了慢性酒精中毒。有些露阴癖是恋童癖的前兆。那些因为这种不道德的暴露而被捕的年青成人，几乎全部在结婚以后，才公然发生暴露阴部的行为。这些沉默、无禁忌而未成熟的男人由于性欲不满或婚姻冲突，因此克制不住一时情感猛烈的冲动和欲望，而将他们的生殖器当众展示。

理论家认为阴部显露欲是强迫观念性的一种性方面的障碍，因此在成因上稍异于非以性的变态方式与对象为发泄出路的精神病障害。幸好，露阴癖不足构成社会上的重大问题，因为它发生的次数极少，而且这种行为很少有危害他人的性质。

易装癖

有这种穿戴异性服装的强烈欲望（即易装癖或易装狂）的人，几乎清一色都是男人。易装癖的病人可能将女性的角色扮演得维妙维肖，而且在这种找不到破绽的伪装之下，他可能幻想他自己是一位女性。由于对女人有惧心，因此他将自己的外表变装为女性，使自己感觉到他终于也有了“自己的”女人，这表现于他独处时所扮演的两种角色。总之，他在安全的情况下伪装成女性的角色，以缓和他自己内心的害怕。

易装是因为男性在伪装成异性后，内心可以获得舒适的感觉，以及男性在潜意识中，有成为女性的欲望之故。另外，这种行为与异性也有重要的关连，因为这样

的服饰以获得兴奋，以及获得易性身份所拥有的方便”。

某些有易装癖的人所以穿着女装，是因为幻想外科手术有一天将能够把他生理上男性的记号割除。而事实上，已经有希望利用外科变性的手术，再投以荷尔蒙制剂，便能将一位易装癖者的第一与第二性征悉数转成接近异性的程度。在成因上，有易装性欲的人可以说是同时患上了露阴癖、恋物癖与男性同性恋的人。因此变性的手术可能是增加而不是减除问题的办法，因为变性对于性的任务、身份和性别等方面所提供的帮助是非常有限的。

施虐狂与受虐狂

施虐狂与受虐狂两个名词首先发现于马贵斯。塞第 (Marquis de Sade, 1740 ~ 1814) 与李耳波德·沙雪麦斯克 (Leopold von Sacher-Masoch, 1863-1895) 的作品中，他们充分地描写了他们个人对性的幻想，以及遭受到的痛苦、辱骂与羞耻。一旦折磨他人的肉体或精神，成为自身获得性的刺激与快乐所不可缺少的手段时，则被公认为是有了施虐狂。而假如一个人除非被伤害或被羞辱以后，才可能获得性的刺激与满足，则这个人就是有了受虐狂。佛洛伊德对这两种变态作过说明，他认为两者都有性欲的冲动与攻击性的冲动，由于发泄的冲动逸出了一般人正常的规范而导致产

生这两种变态的行为。因为同一个人的性欲与攻击的冲动随时都在变化，因此将这种状态称作施虐狂(Sadomasochism)，可能是最恰当的事情。

有施虐或受虐性欲经验的人，并不一定能够自己察觉到这是一种人与人关系的变态方式，无论是藉羞辱或虐待另一位男性或女性，以获得性欲的最大满足，或者藉着被他人粗暴虐待，才能满足他的性欲，这两种人都不了解这种行为的方式是他人格的重要部份。那些鞭挞或殴打他们性对象的男人，可能幻想是在毁灭另一个人，以便保全和安慰自己现有的性关系。因此在这种情况下发生的性交，便是随施虐攻击后得到允许的一种强暴。

男性在性关系中一般都比较具有攻击性，因此“粗暴”地对待对方可能是为表现男性的支配和力量，同时使性行为更加刺激。那些除非压迫他人（亦即性的攻击与强暴），才能觉得性的愉快的人，他们将施虐欲与性欲混合在他们极端性的行为方式中，以达到满足的目的。而施虐狂者寻求受虐狂者，以满足互相需要的欲望。当施虐或受虐的行为是满足性欲的唯一方法，或者变得极端而强烈时，那么我们所要治疗的就很可能是精神病的一种现象了。

性变态的治疗

在研究男性同性恋以及其它许多的性变态时，遭遇

了一项不容易解决的问题，即无法接近和调查男性同性恋的集团和性变态者，因为他们必须隐饰他们被社会所禁止的行为，所以，在对这种人的心理分析和治疗上出现了麻烦和棘手的地方。

根据毕伯（1962）的报告，经过总共 150 小时以下的心理分析疗法以后，28 位同性恋者中只有两位被改变为正常的异性恋者；而接受总共 150 到 350 个小时治疗的 40 位性变态者中，只有 9 位变成正常的。我们并且尝试过在住院的监视下作集团的治疗，但是结果却不很乐观。

最近尝试使用制约与学习的方法，将变态的性欲改为“正常的”，亦即将造成男性同性恋的罪魁或刺激（裸体的男性）与痛苦或有害的刺激（电击）连结在一起，则一旦性变态的对象出现时，便能产生“制约”的效果，使病人的心情突变或退却。我们利用“学习”理论以解释正常与变态性欲的产生，而利用强迫“忘却”的方法（即制约的方法）来治疗病人。

虽然我们尝试过包括范围很广泛的如药物、电击、阉割、荷尔蒙的服用等疗法，在当初都显露出一道曙光，然而至今还没有重大的收获。

不过，医生与学者仍然积极地从事寻找新的疗法，以及诊断与侦测出社会中性变态者的新方法。我们不敢希望能够发现出简单的方法，以解决上面的问题。至今不断有人再接再厉地研究这些未解决的问题，而且探研性问题的教科书与百科全书也继续从各种角度详细描述

男性同性恋等各种性变态。

虽然各种理论在解释性变态时显得人言人殊，不过它们却有一个主要的共同焦点，即认为性变态者在学习社会所规定的正确的性角色时，都发生了混乱与冲突的现象，而所谓性的角色也就是一个人所获得的性身份与他的生理遗传互相符合一致。不断的临床研究已经驱散了许多有关性变态与性变态者的小说所描述的神话与罗曼蒂克的气氛，因为这些研究指出，凡是性变态的人在真实的生活里很少有几个是什么风云人物。性变态的人通常都是情绪未成熟、焦虑、自我中心且能力缺乏。他似乎滞留在发育的某一个阶段上，因此他在处理与他人极重要的关系或困难时，总是在发挥出他的能力与判断力以前，就已经犯了错误。

一个人只要自认为是正常的人，都会对性变态感到害怕。社会对性变态的反应时常是忧惧、幼稚和采用惩罚的方法。但是即使对成人的性变态者加以治疗，结果亦不乐观。性变态似乎在幼年的时候就已经定形，因此在后来的岁月中便很不容易改变过来。我们的治疗最有效的时候是：病人很希望接受治疗而且对他自己的状况很担心的时候。

新的研究可能开辟出有希望的途径，不过这也可能是过分乐观的看法。

